



RSI GONDANGLEGI

LAPORAN TRIWULAN I PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEEN (PMKP)

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Triwulan IV Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Islam Gondanglegi Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, komitmen dan dokumentasi kami terhadap kegiatan pemantauan, evaluasi dan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di lingkungan Rumah Sakit Islam Gondanglegi selama Triwulan I Tahun 2026. Melalui evaluasi rutin dan analisis terhadap indikator mutu serta insiden keselamatan pasien, kami berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi program-program mutu dan keselamatan pasien, pencapaian indikator, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk periode selanjutnya dan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, terutama kepada manajemen rumah sakit, unit-unit terkait, serta seluruh tim Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berfokus pada pasien.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam Gondanglegi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

COVER

DISPOSISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
A. PENDAHULUAN.....	1
B. TUJUAN	1
1. Tujuan Umum	1
2. Tujuan Khusus	1
C. KINERJA DAN PRODUKTIVITAS	2
1. Capaian Indikator Mutu Unit Dan Instalasi	2
2. Capaian Indikator Mutu Management.....	53
3. Capaian Indikator Kepala Bidang Keperawatan.....	56
4. Capaian Indikator Mutu Komite Rumah Sakit	58
5. Monitoring HAls Rumah Sakit	63
6. Monitoring INM	65
7. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit.....	68
8. Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	Error! Bookmark not defined.
9. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).....	69
10. Hasil Validasi IMPRS dan INM	73
D. EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN	75
E. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN	76
F. RENCANA TINDAK LANJUT	76
G. KESIMPULAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian indikator mutu Instalasi Gawat Darurat (IGD)	2
Tabel 2. Capaian indikator mutu Instalasi Rawat Jalan (IRJ)	6
Tabel 3. Capaian Indikator Mutu Instalasi Kamar Operasi (IKO)	9
Tabel 4. Capaian indikator mutu IRNA Intensif (ICU)	12
Tabel 5. Capaian indikator mutu IRNA Anyelir	14
Tabel 6. Capaian indikator mutu IRNA Cendana	16
Tabel 7. Capaian Indikator Mutu IRNA Camelia	19
Tabel 8. Capaian indikator mutu IRNA Gardenia.....	20
Tabel 9. Capaian indikator mutu IRNA Edelweis.....	22
Tabel 10. Capaian indikator mutu IRNA Jasmine	26
Tabel 11. Capaian indikator mutu Instalasi Rekam Medis (IRM)	30
Tabel 12. Capaian indikator mutu Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS).....	32
Tabel 13. Capaian indikator mutu Instalasi Pelayanan laboratorium Terpadu (IPLT)	34
Tabel 14. Capaian indikator mutu Instalasi Radiologi Rumah Sakit (IRRS)	36
Tabel 15. Capaian indikator mutu Instalasi Gizi Rumah Sakit (IGRS)	38
Tabel 16. Capaian indikator mutu Instalasi Laundry Rumah Sakit (ILRS)	39
Tabel 17. Capaian indikator mutu Instalasi Sterilisasi sentral (ISS)	42
Tabel 18. Indikator Instalasi Pendidikan Pelatihan dan Penelitian (DIKLIT)	44
Tabel 19. Capaian indikator mutu Instalasi Teknologi Informasi	45
Tabel 20. Capaian Indikator Mutu Telemedik	46
Tabel 21. Capaian Indikator Mutu HUMSAR	47
Tabel 22. Capaian indikator Instalasi Logistik	47
Tabel 23. Capaian indikator mutu Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Pelayanan Rohani (IPJPR)	48
Tabel 24. Capaian indikator mutu Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)	49
Tabel 25. Capaian Indikator Mutu Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL)	50
Tabel 26. Capaian Indikator Mutu Pelayanan Rehabilitasi Medis	51
Tabel 27. Capaian Indikator Mutu Unit Kendaraan	51
Tabel 28. Capaian indikator Instalasi Keamanan	52
Tabel 29. Capaian indikator Koordinasi Cleaning Service	52

Tabel 30 Capaian indikator Tata Usaha	53
Tabel 31. Capaian Indikator Mutu IPP	54
Tabel 32 Capaian Indikator Mutu Akuntansi dan Keuangan.....	55
Tabel 33. Capaian Indikator Bidang Keperawatan	56
Tabel 34 capaian Komite Medis (Komed)	58
Tabel 35 Capaian Indikator Mutu Etik Dan Hukum (KEH).....	59
Tabel 36 Capaian indikator mutu komite keperawatan	60
Tabel 37 Capaian indikator mutu Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	61
Tabel 38 Capaian Indikator Mutu PPA lain.....	62
Tabel 39 Capaian indikator mutu Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah sakit (K3RS)	62
Tabel 40 Surveilans HAIs Triwulan I Tahun 2026	63
Tabel 41 Monitoring INM	65
Tabel 42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Triwulan I 2026 RSI Gondanglegi.....	68
Tabel 43 Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) . Error! Bookmark not defined.	
Tabel 44 Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2026	69
Tabel 45 Validasi data IMPRS dan INM	73
Tabel 46 Rencana Tindak Lanjut.....	77

A. PENDAHULUAN

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP) Rumah Sakit Islam Gondanglegi memiliki peran strategis dalam mengawal peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan. Sejalan dengan regulasi nasional serta standart akreditasi rumah sakit, pelaksanaan program Komite Mutu dan Keselamatan Pasien merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien.

Laporan Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan program-program yang telah dirancang oleh PMKP, dalam periode Januari hingga Maret 2026. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien fokus pada pemantauan indikator mutu prioritas, pelaksanaan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), serta koordinasi lintas unit dalam mendorong budaya keselamatan.

Laporan ini memuat data dan analisis capaian indikator mutu, jumlah dan klasifikasi insiden keselamatan pasien, serta evaluasi kegiatan perbaikan mutu yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem mutu dan keselamatan di tahun berikutnya.

Harapannya laporan ini dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh civitas hospitalia dalam mewujudkan pelayanan yang unggul, aman, dan bermutu tinggi sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Islam Gondanglegi.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Menyajikan data, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien selama Triwulan I Tahun 2026 sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Gondanglegi.

2. Tujuan Khusus

- 2.1 Mengevaluasi capaian indikator mutu pelayanan rumah sakit pada Triwulan I Tahun 2026.
- 2.2 Mengidentifikasi dan menganalisis Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang terjadi selama periode laporan.
- 2.3 Mendokumentasikan kegiatan perbaikan mutu dan keselamatan pasien yang telah dilakukan oleh unit-unit terkait.
- 2.4 Memonitor pelaksanaan program kerja Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sesuai rencana strategis tahunan.
- 2.5 Memberikan rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk triwulan berikutnya.

C. KINERJA DAN PRODUKTIVITAS

1. Capaian Indikator Mutu Unit Dan Instalasi

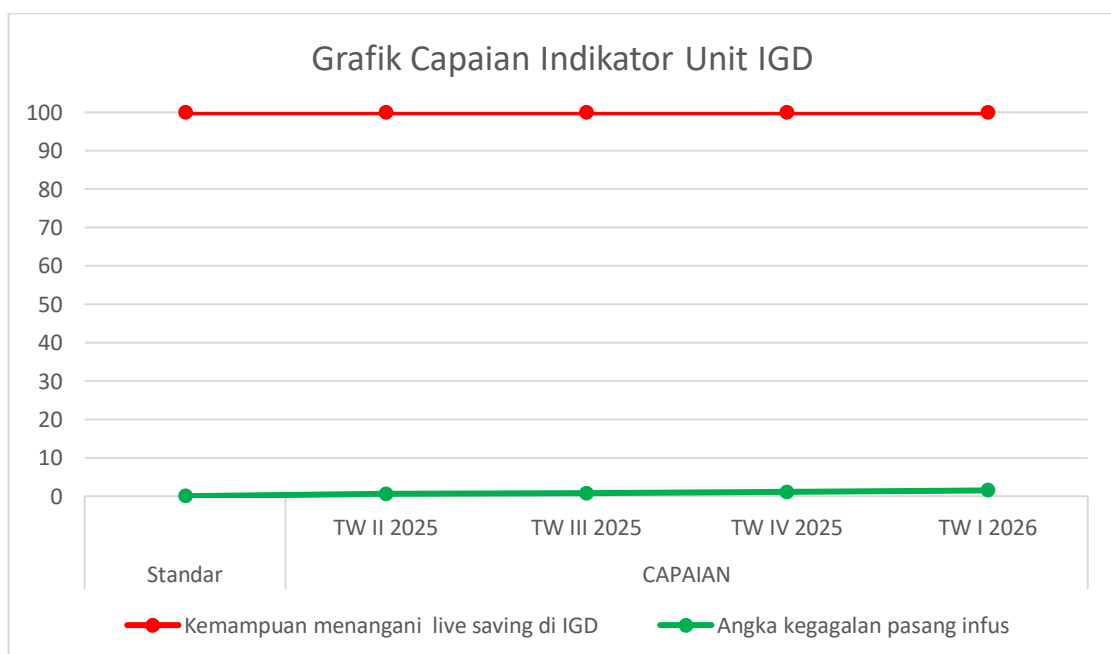
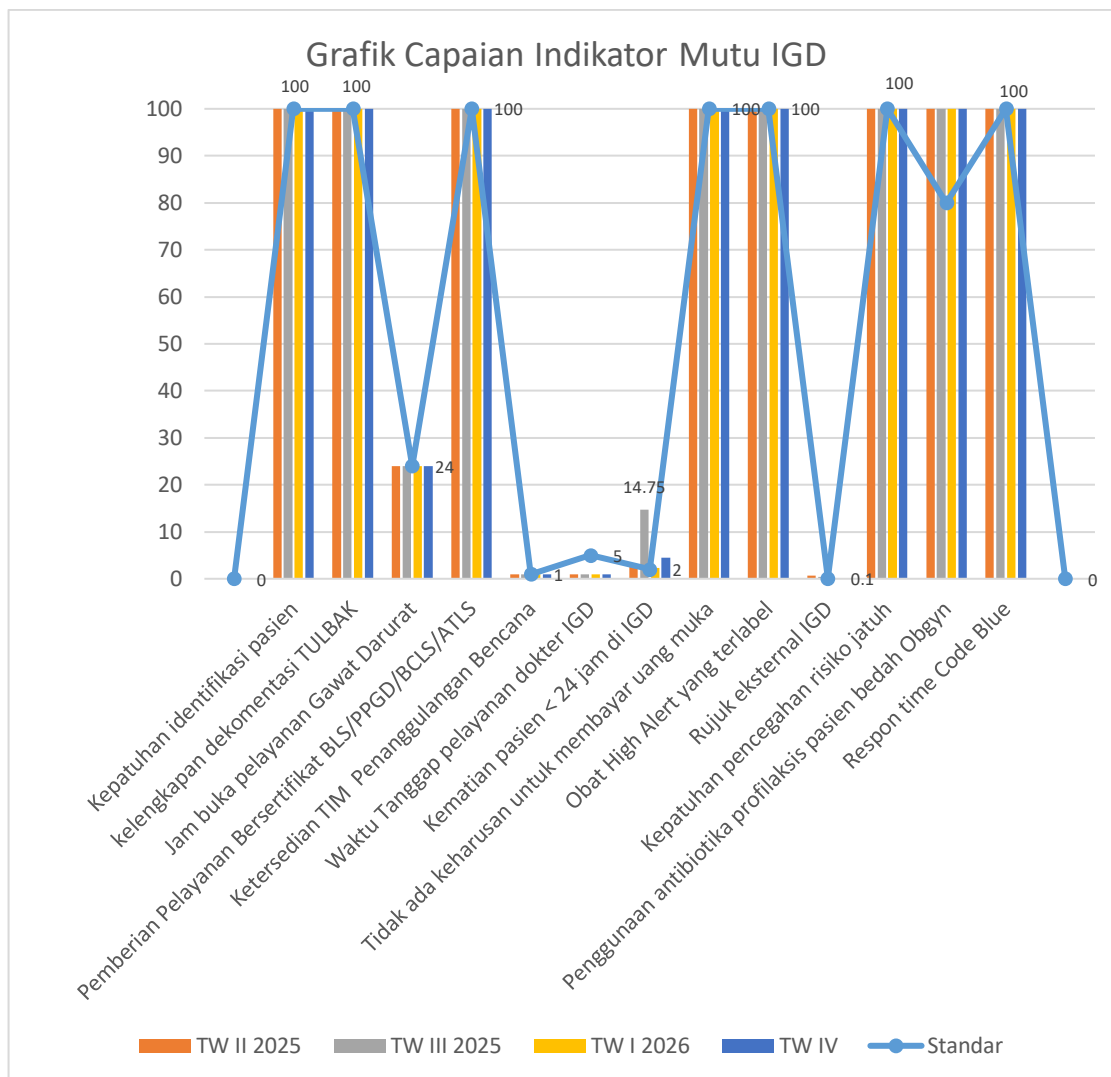
1.1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

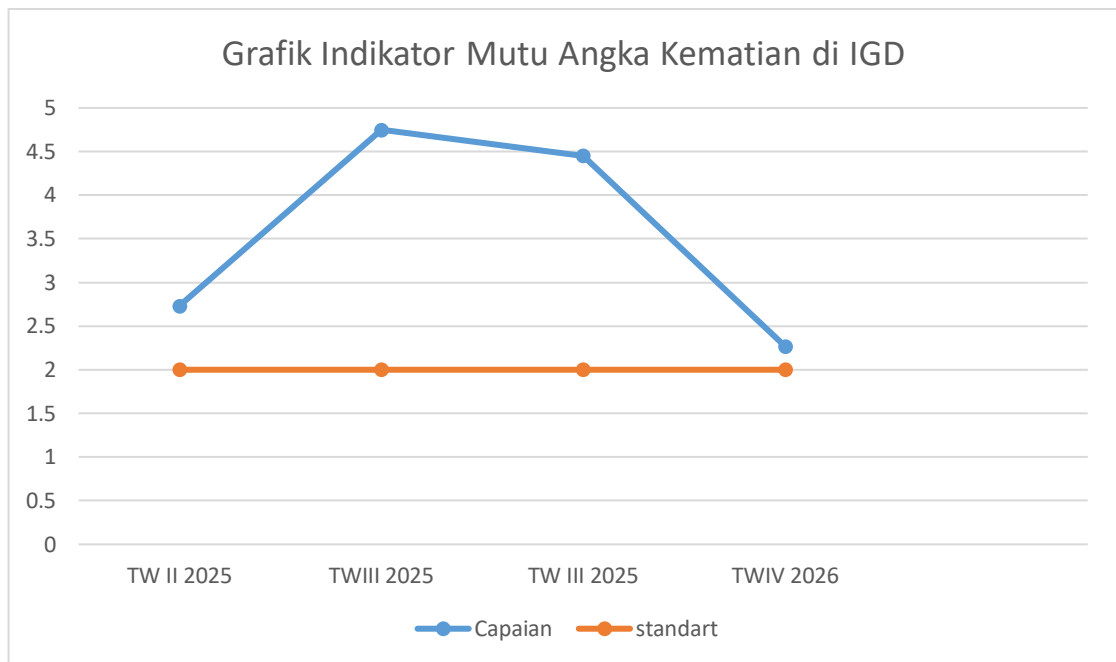
Tabel 1. Capaian indikator mutu Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
1	Kemampuan menangani <i>live saving</i> anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24jam	24jam	24 jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	1 menit	1 menit	1menit	1 menit
6	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam	2,73‰	4,75‰	4,45‰	2,27‰
7	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%
8	Angka kegagalan pasang infus	0%	0,6%	0,77%	1,05%	1,49%
9	Ketersediaan obat life saving dalam troli emergency	100%	100%	100%	100%	100 %
10	Rujuk eksternal instalasi gawat darurat	0,1%	0,69%	0,39%	0,06%	0,19%
11	Respon time code blue	100%	100%	100%	100%	100 %
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP):						

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
12	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	100%	100%	100%	100%
14	Obat <i>High ALert</i> yang terlabel	100%	100%	100%	100%	100%
15	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	100%	94%	100%	100%
16	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Pelayanan Klinis prioritas:						
17	Penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien bedah <i>Obsgyn</i>	80%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS





Analisa:

1. Kematian pasien ≤ 24 jam pada TW I 2026 mengalami penurunan 2,18 % dari TW IV 2025 tetapi masih belum sesuai standart.

Dari hasil monitoring indikator mutu bahwa sebagian besar pasien yang meninggal di IGD datang dalam kondisi kegawatan tinggi, seperti syok, gagal napas, stroke berat, acute coronary syndrome, sepsis, trauma berat, maupun kondisi terminal dengan keterlambatan rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya atau keterlambatan keluarga membawa pasien ke rumah sakit.

Dari kasus kematian di IGD tidak ada penyebab kematian karena keterlambatan *response time* akibat salah penentuan kategori triage (*under-triage*) dan ketersediaan peralatan maupun SDM dan kompetensi.

2. Angka kegagalan pasang infus pada Triwulan ke I Tahun 2026 1,49% meningkat dari capaian Triwulan IV 2025 dan belum mencapai standart.

Faktor penyebab angka kegagalan terbanyak adalah pada:

- a. Kasus pediatri menyumbang angka kegagalan terbesar dengan rata-rata percobaan penusukan 2–3 kali sebelum berhasil. Hal ini karena Vena anak secara alami lebih kecil, rapuh, dan sering tertutup oleh jaringan lemak subkutan (terutama pada bayi) dan kebanyakan anak berperilaku tidak kooperatif.

- b. Pada pasien geriatri dan pasien riwayat penyakit kronis. Pada pasien geriatri karena proses penuaan menyebabkan vena menjadi lebih kecil, rapuh, kehilangan elastisitas, dan mudah bergeser (rolling vein). Dinding vena juga lebih tipis sehingga mudah pecah saat dilakukan penusukan, sedangkan jaringan subkutan yang berkurang menyebabkan vena kurang stabil dan lebih sulit difiksasi. Sedangkan pada pasien riwayat penyakit kronis mengalami gangguan sirkulasi perifer, dehidrasi, edema, dan perubahan struktur pembuluh darah akibat penyakit kronis sehingga menyebabkan vena sulit terlihat maupun diraba. Selain itu pasien yang sering menjalani terapi intravena, kualitas vena umumnya telah mengalami penurunan. Pembuluh darah dapat mengalami sklerosis (mengeras), fibrosis akibat pemasangan infus berulang, penyempitan lumen vena, serta mudah kolaps saat dilakukan aspirasi atau pemasangan kateter. sehingga menyebabkan vena sulit terlihat maupun diraba.

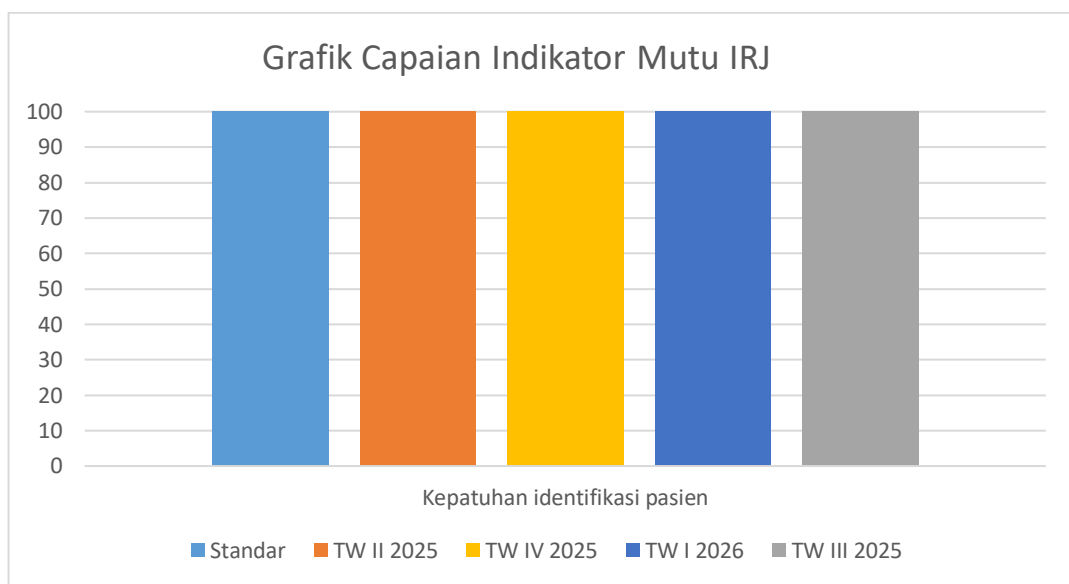
1.2. Instalasi Rawat Jalan (IRJ)

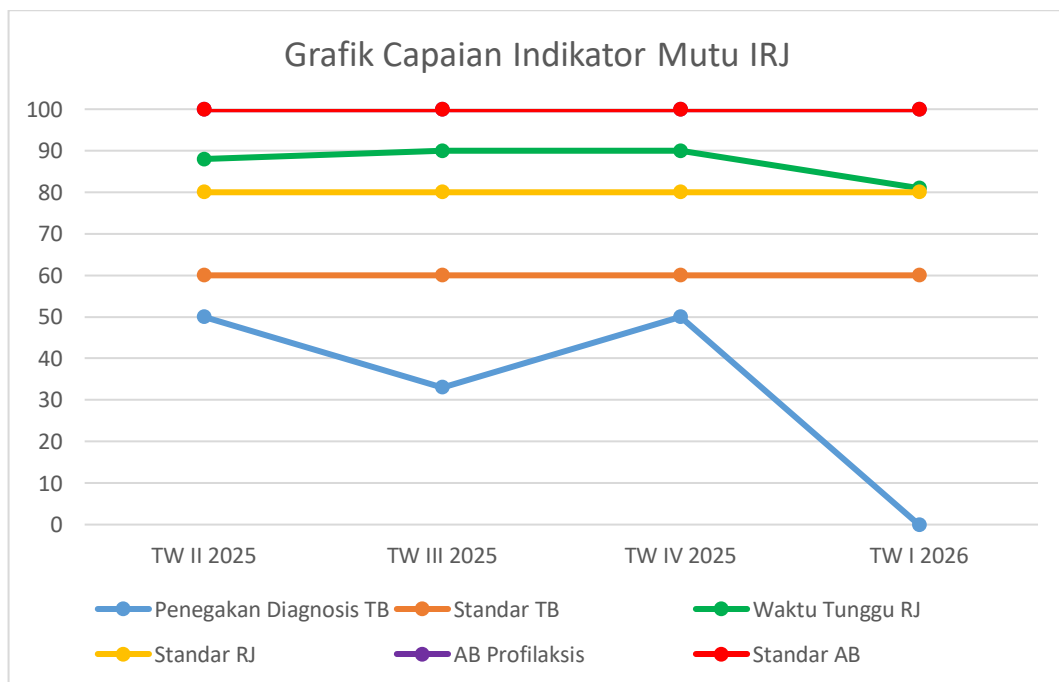
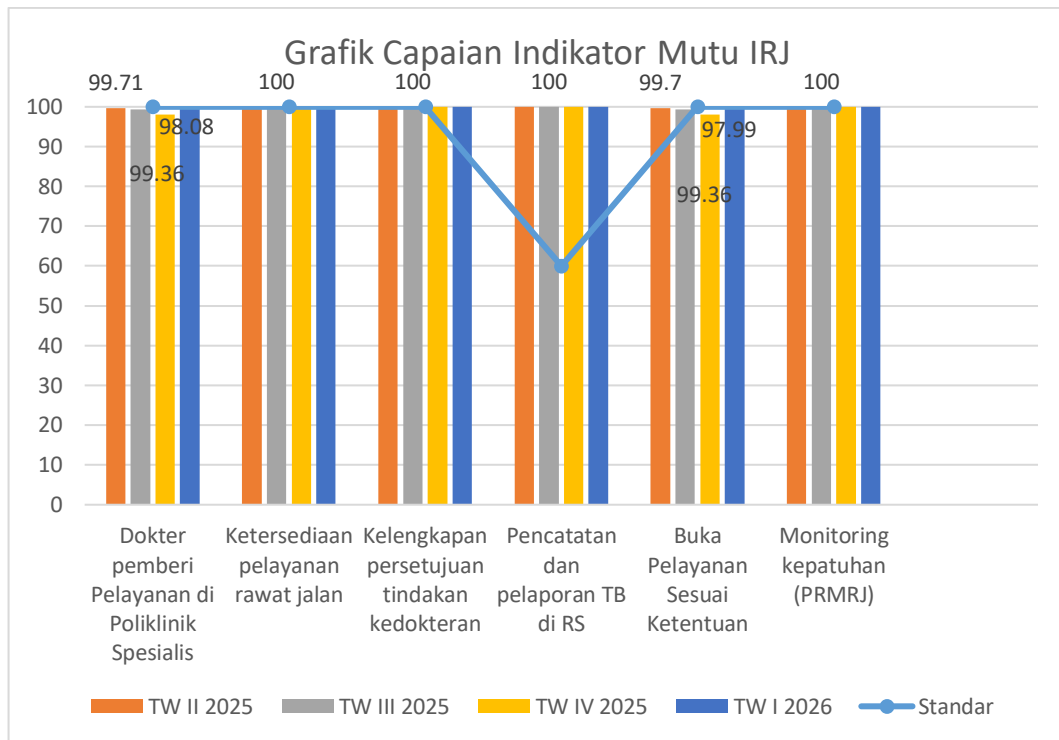
Tabel 2. Capaian indikator mutu Instalasi Rawat Jalan (IRJ)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100% Dokter Spesialis	99,71%	99,36%	98,08%	100%
2	Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan.	100%	99,71%	99,36%	100%	100%
3	Waktu tunggu di rawat jalan	(≤60 menit) ≥ 80%	88,34%	89,57%	90,45%	81,42%
4	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	50%	33,33%	50%	0%
5	Terlaksananya kegiatan dan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
6	Monitoring kepatuhan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ)	100%	100%	89,57%	100%	100%

7	Kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran	100%	100	100%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
8	Kepatuhan Identifikasi Pasien Obgyn	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	100%	100%	90%	95%

Sumber Data: SIMRS Khanza





Analisa:

1. Pada indikator waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 9 % dari Triwulan IV 2025, hal ini disebabkan karena pasien datang lebih awal dari jadwal dokter spesialis poliklinik.
2. Indikator penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis pada TW I 2026 0% dan belum mencapai standart yang telah ditetapkan karena menunggu hasil pemeriksaan mikroskopis 5-7 hari (karena

pemeriksaan harus dikirim) dan tidak ada kurir tetap untuk pengiriman sample ke laboratorium rujukan.

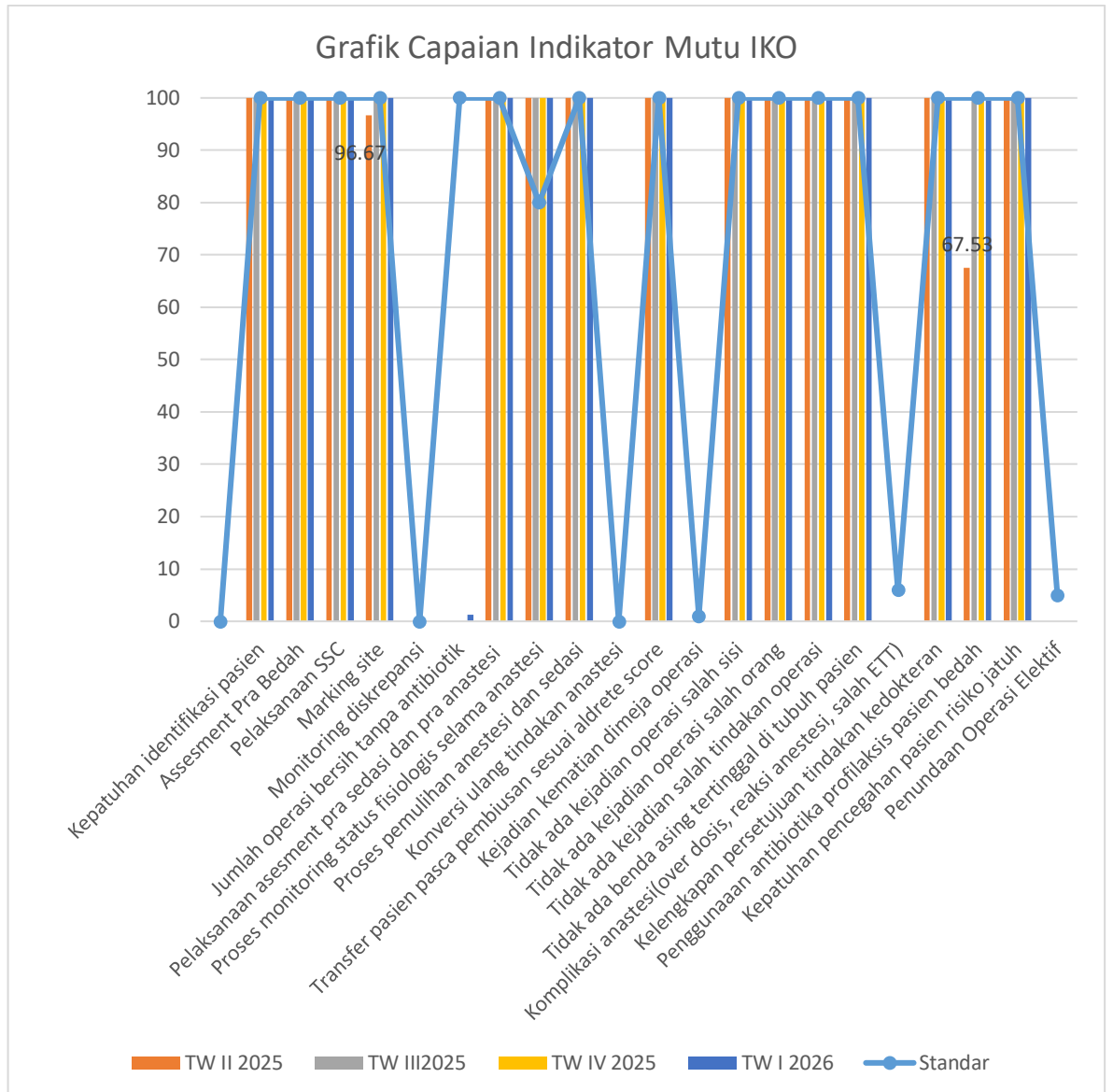
1.3. Instalasi Kamar Bedah (IKO)

Tabel 3. Capaian Indikator Mutu Instalasi Kamar Operasi (IKO)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Assesment Pra Bedah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketidak sesuaian diagnosa pre dan post operasi (monitoring diskrepansi)	0%	0%	0%	0%	0%
3	Jumlah operasi bersih tanpa antibiotik	100%	0%	0%	1,23%	0%
4	Pelaksanaan asesment pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Proses monitoring status fisiologis selama anastesi	80%	100%	100%	100%	100%
6	Proses pemulihan anastesi dan sedasi	100%	100%	100%	100%	100%
7	Konversi ulang tindakan anastesi	0%	0%	0%	0%	0%
8	Transfer pasien pasca pembiusan sesuai dengan aldrete score	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penundaan operasi elektif	< 5%	0%	0%	0%	0%
10	Kejadian Kematian dimeja operasi	≤ 1 %	0%	0%	0%	0%
11	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	98,5%	100%	100%	100%
14	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%
15	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan <i>endo tracheal tube</i>	≤ 6%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
16	Kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pelaksanaan <i>Surgical Safety Checklist (SSC)</i> pasien Obgyn	100%	100%	100%	100%	100%
18	Penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien <i>Obsgyn</i>	100%	67,53	100%	99,53%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
19	Kepatuhan Identifikasi Pasien <i>Obsgyn</i>	100%	100%	100%	100%	100%
20	Penandaan Lokasi Operasi (<i>Marking Site</i>)	100%	96,67%	100%	100%	100%
21	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	100%	100%	100%	100%
22	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

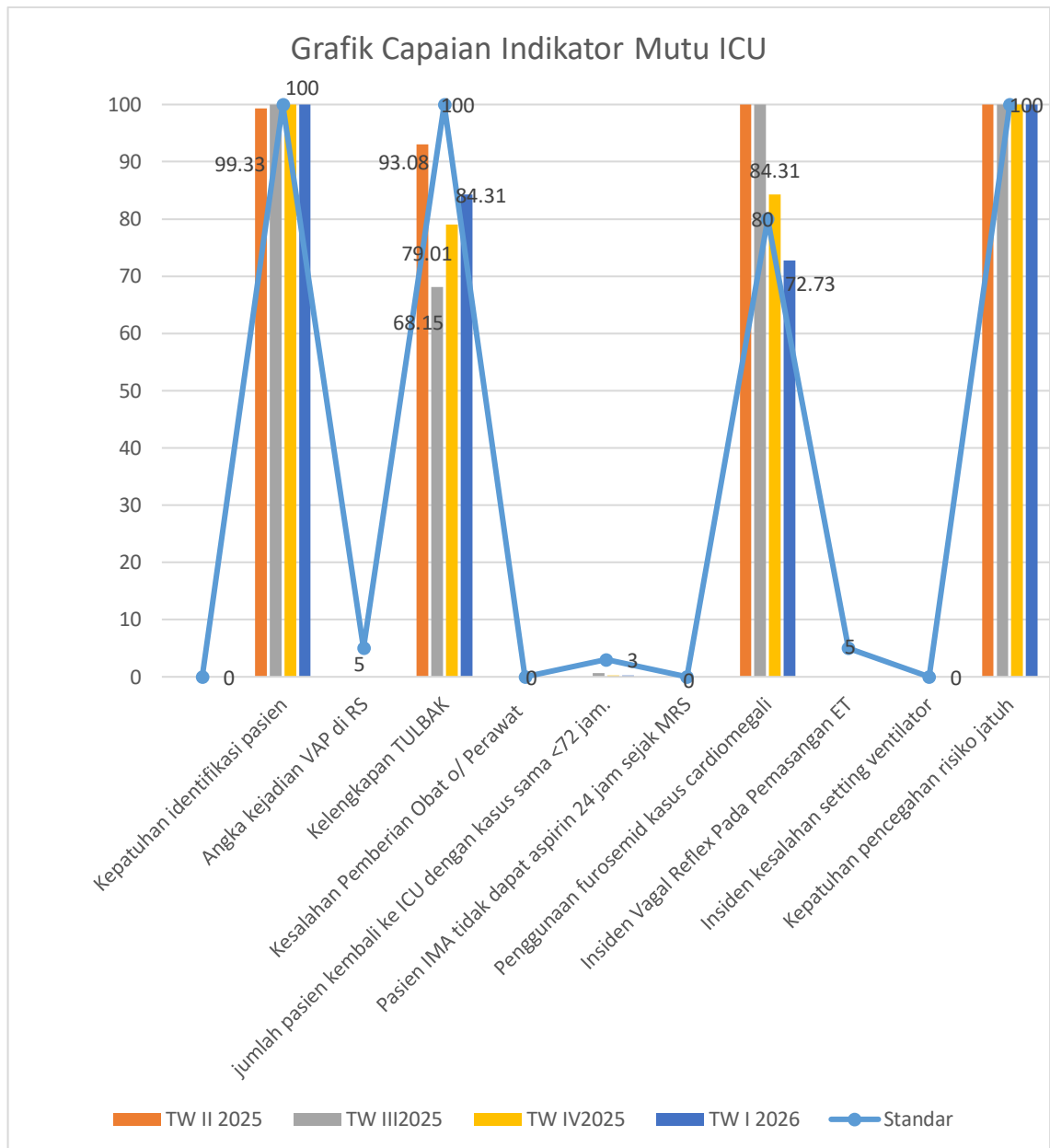
Semua indikator instalasi kamar operasi pada TW I 2026 sudah sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

1.4. Instalasi Rawat Inap Intensif (ICU)

Tabel 4. Capaian indikator mutu IRNA Intensif (ICU)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Rata-rata pasien yang kembali ke ICU dengan kasus yang sama < 72 Jam	≤ 3 %	0%	0,62%	0,23%	0,2%
2	Pasien IMA yang tidak mendapatkan terapi aspirin (anti trombotik) dalam waktu 24 jam sejak datang ke Rumah Sakit	0%	0%	0%	0%	0%
3	Penggunaan furosemid pada kasus cardiomegali	80%	100%	100%	84,31%	72,73%
4	Insiden Vagal Reflex Pada Pemasangan ET	5%	0%	0%	0%	0%
5	Insiden kesalahan setting ventilator	0%	0%	0%	0%	0%
6	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
7	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100 %	99,33 %	100%	100%	100%
8	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	93,08%	68,15%	79,01%	84,31%
10	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	100%	100%	100%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

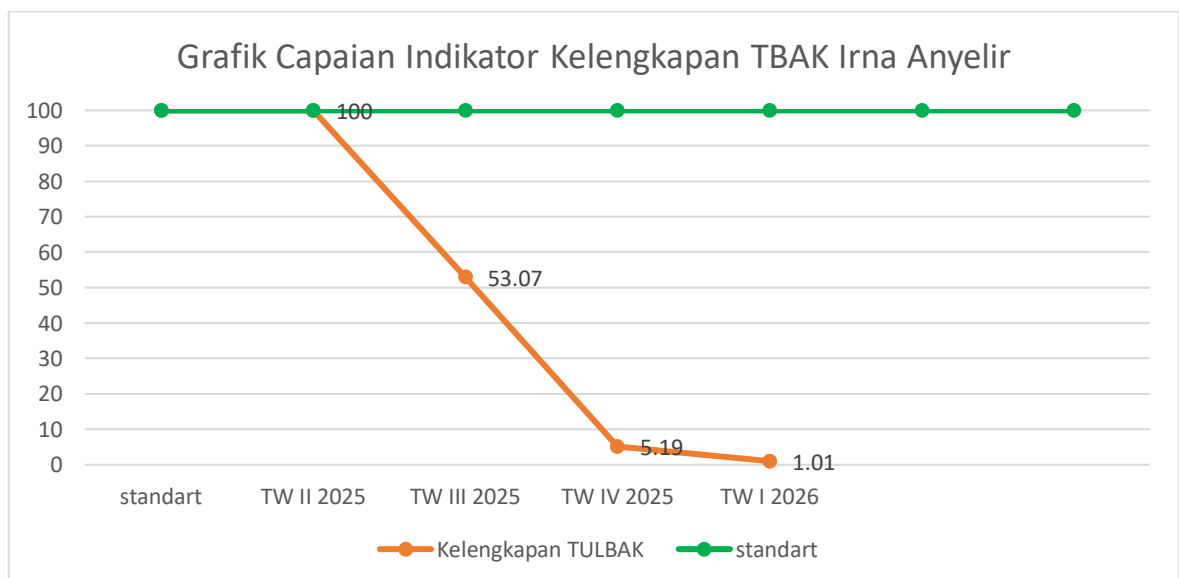
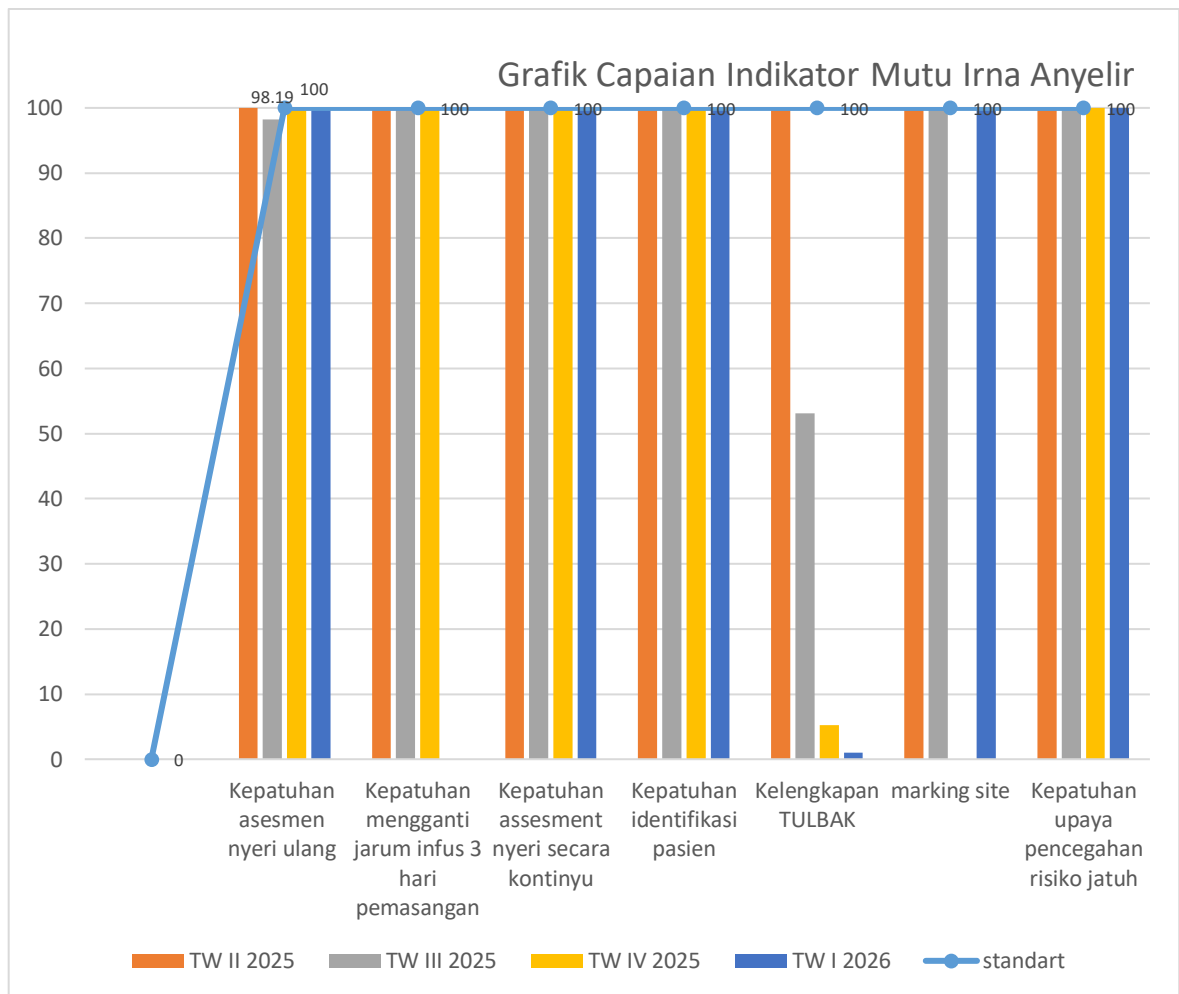
1. Pada masa peralihan RME pada pada Triwulan I 2026 pada indikator kelengkapan dokumentasi TBAK rawat inap ICU sudah mengalami kenaikan 5,3 % dari Triwulan IV 2025, tetapi masih belum mencapai standart yang telah ditentukan.
2. Pada indikator penggunaan furocemida pada kasus pasien dengan cardiomegali pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan menjadi 79,01% dikarenakan kondisi klinis pasien dengan cardiomegali yang menjadi kontraindikasi diberikannnya furocemida (misal: TD dibawah normal)

1.5. Instalasi Rawat Inap Anyelir

Tabel 5. Capaian indikator mutu IRNA Anyelir

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kepatuhan pendokumentasian asesmen nyeri ulang di status pasien	100%	100%	98,19%	100%	100%
2	Kepatuhan perawat dalam mengganti jarum infus 3 hari pemasangan	100%	100%	100%	100%	0%
3	Kepatuhan pendokumentasian assesment nyeri secara kontinyu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
5	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	100%	53,07%	5,19%	1,01%
7	Penandaan Lokasi Operasi (<i>Marking Site</i>)	100%	100%	100%	-	100%
8	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	93,3%	94%	96%	100%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS



Analisa :

1. Indikator mutu pada instalasi rawat inap Anyelir kelengkapan dokumentasi TBAK pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 4,18% dari TW IV tahun 2025 dan tidak mencapai standart yang telah ditetapkan karena dokter DPJP tidak memverifikasi TBAK 1X24 jam. Penyebabnya antara lain:
 - a. Proses transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medik elektronik, sehingga dokter belum sepenuhnya familiar dengan alur dan fitur RME.
 - b. Tampilan dan struktur menu RME yang belum *user friendly*, sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan poin – poin yang harus diisi didukung dengan keterbatasan waktu pelayanan.
 - c. Waktu pelayanan yang terbatas, pengisian RME belum menjadi prioritas utama dibandingkan tindakan klinis.
 - d. Keterbatasan sosialisasi penggunaan RME kepada dokter DPJP
 - e. Belum ada pengingat otomatis (*alert sistem*) pada sistem RME untuk kelengkapan isian RME dan verifikasi.
2. Pada indikator kepatuhan perawat dalam mengganti jarum infus 3 hari pemasangan pada Triwulan I 2026 0 %, karena pasien tidak mau diganti jarum merasa tidak ada keluhan dan rasa takut dipasang lagi walaupun sudah dilakukan KIE oleh perawat tentang resikonya.
3. Pada indikator kepatuhan pencegahan resiko jatuh pada adalah 100 % karena tidak ada pasien dengan resiko jatuh.

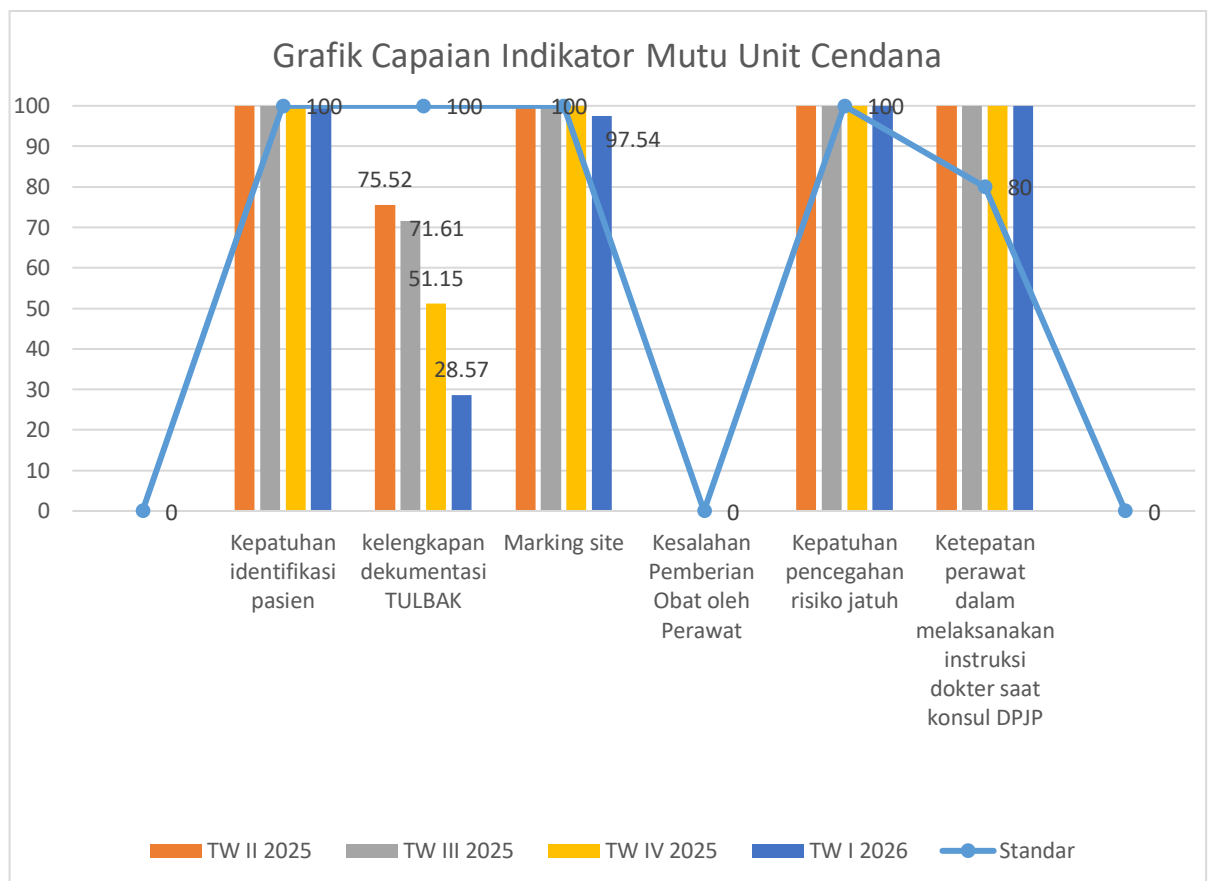
1.6. Instalasi Rawat Inap Cendana

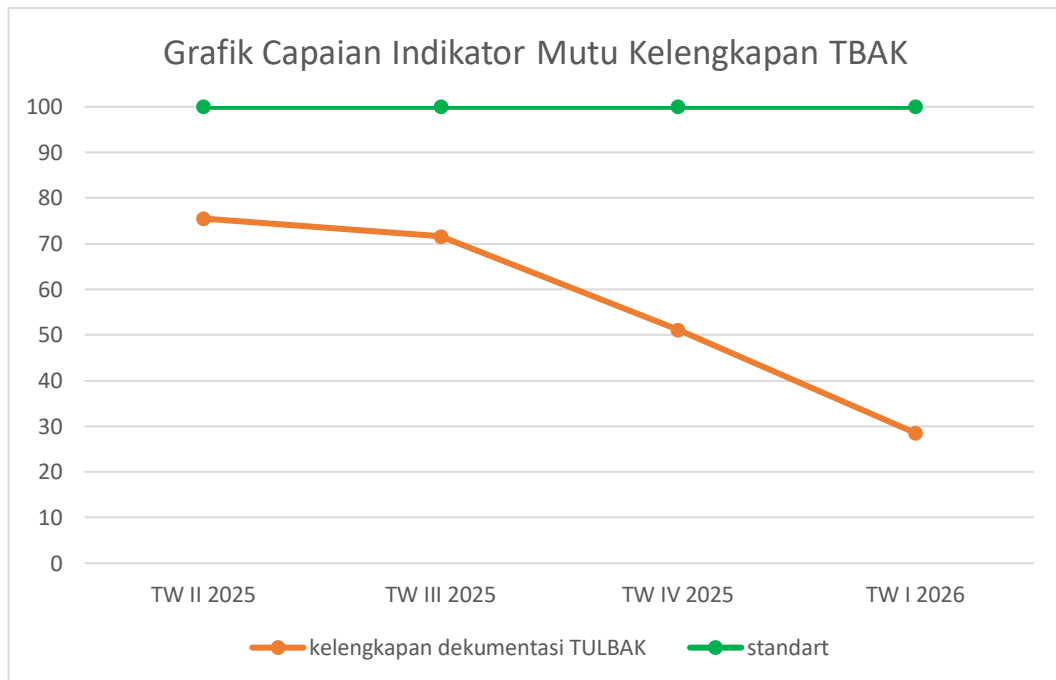
Tabel 6. Capaian indikator mutu IRNA Cendana

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
2	Ketepatan perawat IRNA Cendana dalam melaksanakan instruksi dokter saat konsul DPJP	80%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	69%	71,61%	51,15%	28,57%

5	Penandaan Lokasi Operasi (<i>Marking Site</i>)	100%	100%	100%	100%	97,54%
6	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	96%	87%	90%	94%
7	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza





Analisa :

1. Kelengkapan dokumentasi TBAK pada Instalasi Rawat Inap Cendana TW I Tahun 2026 28,57% mengalami penurunan 22,58% dari TW IV 2025 dan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 90%, dikarenakan DPJP melakukan verifikasi >24 jam, penyebabnya antara lain:
 - a. Proses transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medik elektronik, sehingga dokter belum sepenuhnya familiar dengan alur dan fitur RME.
 - b. Tampilan dan struktur menu RME yang belum *user friendly*, sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan poin – poin yang harus diisi didukung dengan keterbatasan waktu pelayanan.
 - c. Waktu pelayanan yang terbatas, pengisian RME belum menjadi prioritas utama dibandingkan tindakan klinis.
 - d. Keterbatasan sosialisasi penggunaan RME kepada dokter DPJP
 - e. Belum ada pengingat otomatis (*allert sistem*) pada sistem RME untuk kelengkapan isian RME dan verifikasi.
2. Pada indikator *marking site* capai pada TW I 2026 97,54 belum mencapai standart yang telah ditentukan, yaitun terdapat 3 pasien tidak dilakukan *marking site* petugas kurang konsisten dalam melakukan verifikasi ulang *marking site* sebelum masuk ke kamar operasi. Tetapi *marking site* dilakukan di kamar operasi sebelum timeout.

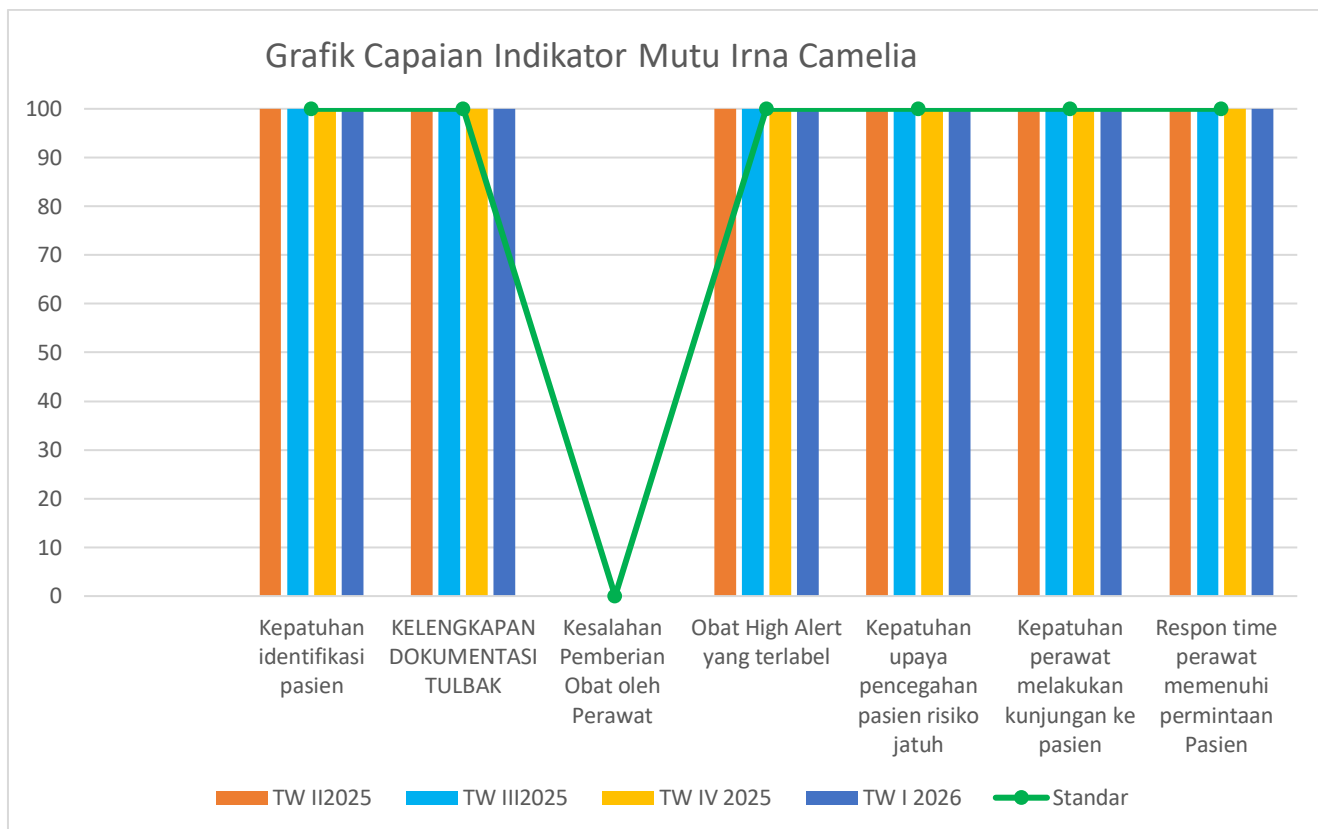
3. Kepatuhan Hand hygiene pada rawat inap Cendana TW I 2026 mengalami peningkatan dari TW IV 2025 sebesar 4 % , dan sudah memenuhi standart yang telah ditentukan.

1.7. Instalasi Rawat inap Camelia

Tabel 7. Capaian Indikator Mutu IRNA Camelia

No	Indikator	Standart / Target	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kelengkapan dokumentasi TBAK	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
4	Obat <i>High Alert</i> yang terlabel	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan pasien risiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kepatuhan perawat dalam melakukan kunjungan ke pasien	100%	100%	100%	100%	100%
7	<i>Respon time</i> perawat dalam memenuhi permintaan dari Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kepatuhan kebersihan tangan(<i>hand hygiene</i>)	≥85%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS



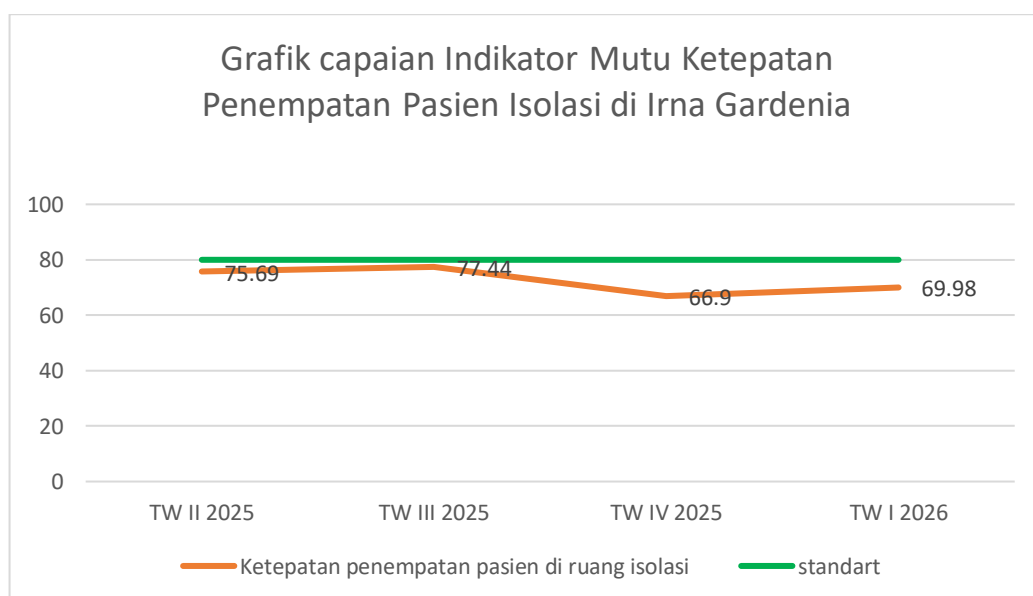
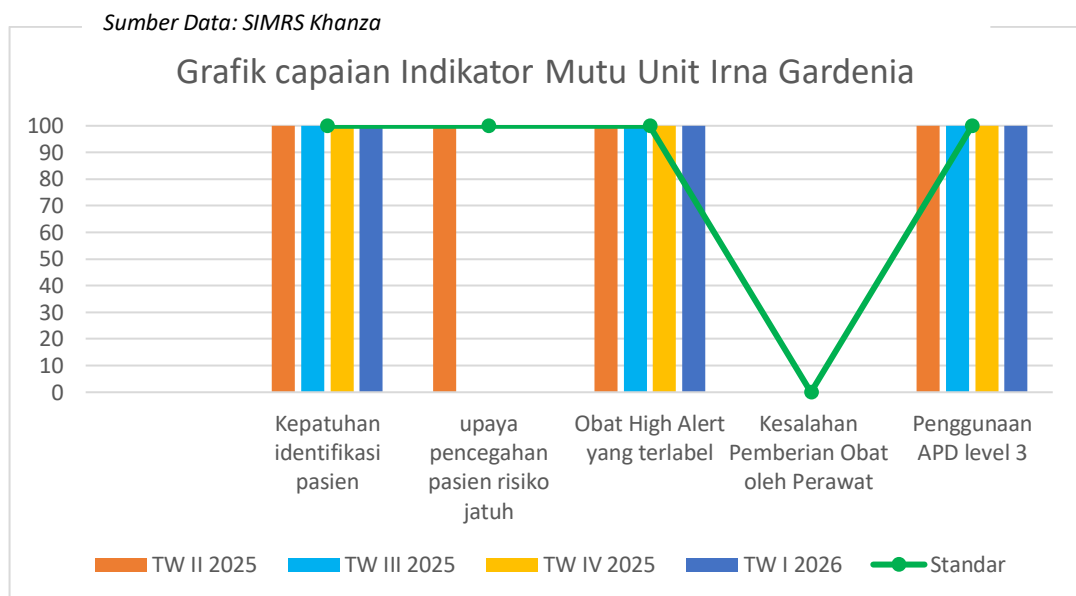
Analisa :
Seluruh indikator pada rawat inap Camelia pada TW I 2026 sudah memenuhi standart target yang telah ditentukan.

1.8. Instalasi Rawat Inap Gardenia

Tabel 8. Capaian indikator mutu IRNA Gardenia

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Penggunaan APD level 3	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
3	Ketepatan penempatan pasien di ruang isolasi	80%	75,69%	77,44%	66,9%	69,98%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
4	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	87,88%	91,85%	94,48%	94,37%

6	Obat <i>High ALert</i> yang terlabel	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	100%	100%	100%	100%
8	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	0%	0%	0%



Analisa :

Berdasarkan hasil monitoring indikator ketepatan penempatan pasien di ruang isolasi, secara umum petugas telah melakukan penempatan pasien sesuai dengan diagnosis, status infeksi, dan kebutuhan isolasi yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap prosedur penempatan pasien berperan penting dalam mencegah terjadinya transmisi infeksi di rumah sakit serta mendukung keselamatan pasien, pengunjung, dan staf.

Capaian Indikator ketepatan penempatan pasien isolasi TW I 2026 mengalami peningkatan 3 % dari TW IV Tahun 2025, tetapi masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan rumah sakit. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab ketidaktepatan penempatan isolasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterbatasan ketersediaan ruang isolasi dan ruang rawat inap, tingginya jumlah pasien yang memerlukan isolasi pada periode tertentu, serta adanya kondisi over kapasitas sehingga beberapa pasien ditempatkan pada ruang yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan klinisnya.
2. Belum optimalnya proses skrining dan identifikasi pasien yang memerlukan isolasi sejak awal masuk rumah sakit, keterlambatan penetapan status isolasi, komunikasi dan koordinasi antar unit yang belum optimal, serta dokumentasi status isolasi yang belum lengkap saat proses admisi maupun perpindahan pasien.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap ketidaktepatan penempatan pasien dan berdampak pada belum tercapainya target indikator. Oleh karena itu, diperlukan penguatan proses skrining, peningkatan koordinasi antar unit, optimalisasi manajemen tempat tidur, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pasien ditempatkan sesuai kebutuhan isolasi dan mendukung keselamatan pasien serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

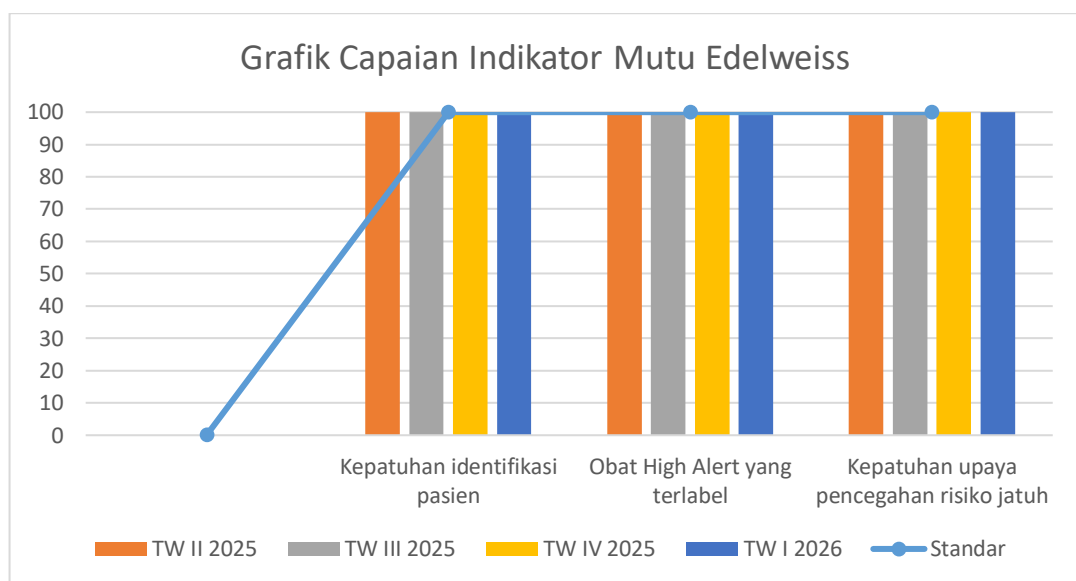
1.9. Instalasi Rawat Inap Edelweis

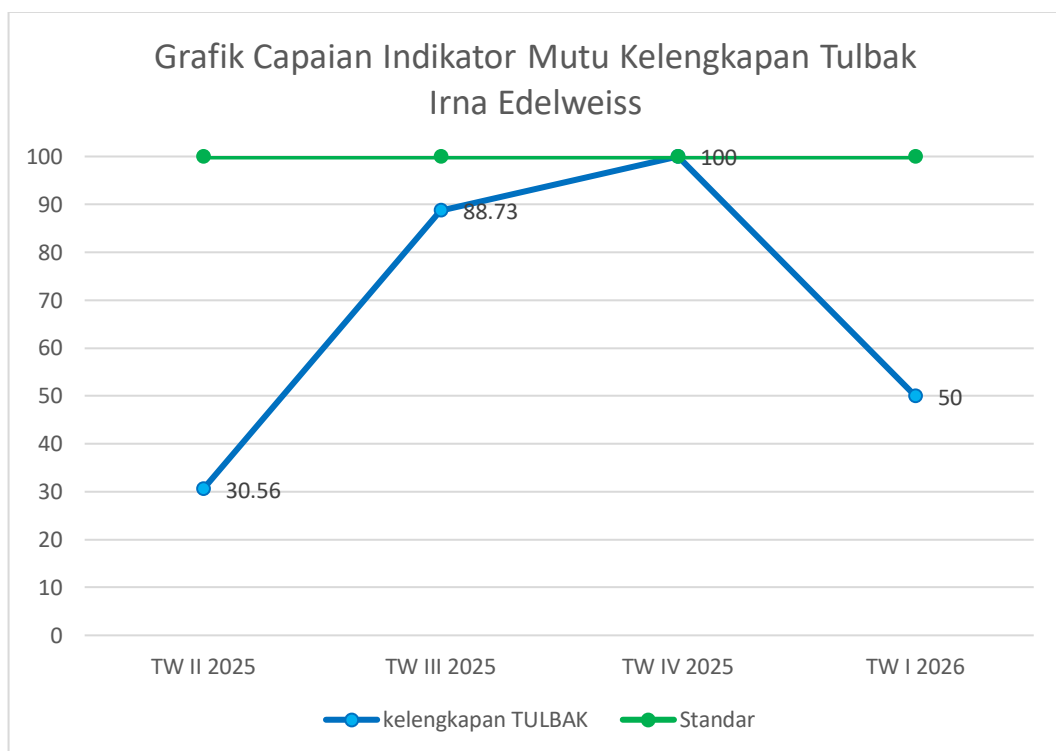
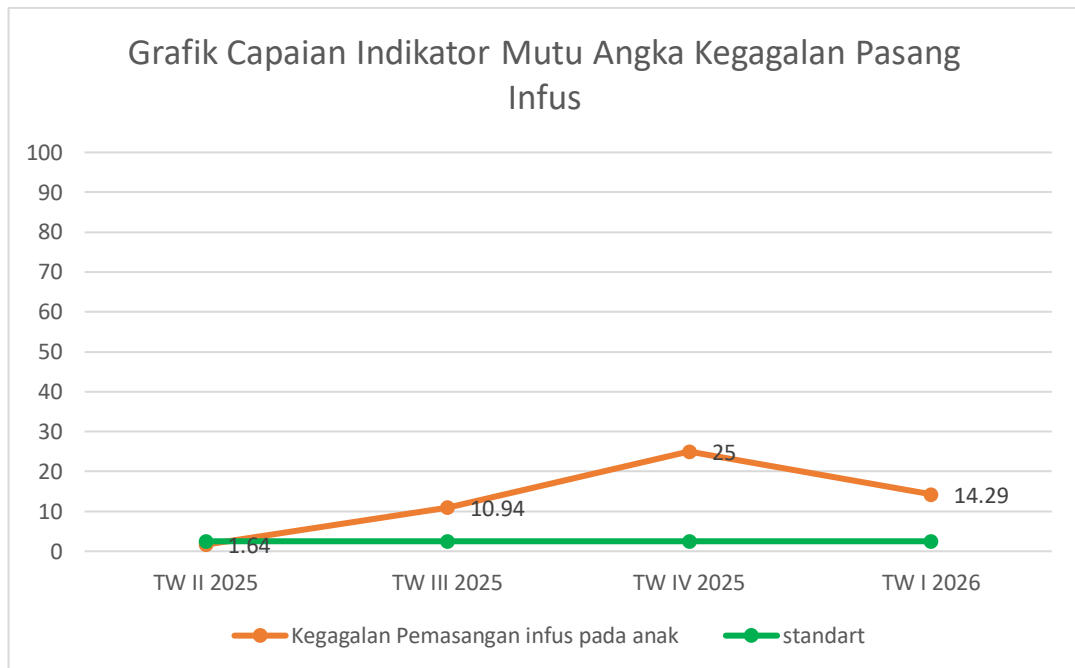
Tabel 9. Capaian indikator mutu IRNA Edelweis

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Pasien Asma anak yang tidak menerima bronkodilator selama masa rawat inap	0%	0%	0%	0%	0%
2	Kegagalan Pemasangan infus pada anak	2,5%	1,64%	10,94%	25%	14,28%
3	Ketidaktepatan pemberian obat 5 benar Pasien asma pada anak	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
5	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%

6	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	30,56%	88,73%	100%	50%
7	Obat <i>High ALert</i> yang terlabel	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	100%	100%	100%	100%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza





Analisa :

1. Angka kegagalan pemasangan infus anak pada TW I 2026 masih belum mencapai standart yang telah ditetapkan. Capaian indikator angka kegagalan pemasangan infus pada pasien anak masih perlu menjadi perhatian karena terdapat beberapa kasus kegagalan pemasangan infus pada percobaan pertama. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik pasien anak:

- a. Ukuran vena lebih kecil, kondisi pasien yang kurang kooperatif akibat takut atau cemas saat tindakan, serta kondisi klinis tertentu yang menyebabkan vena sulit ditemukan.
- b. Keterbatasan lokasi pemasangan infus juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pemasangan. Sebagian vena yang berpotensi digunakan tidak dapat dimanfaatkan karena telah mengalami pembengkakan atau infiltrasi akibat percobaan pemasangan infus sebelumnya di IGD yang mengalami kegagalan. Kondisi tersebut menyebabkan pilihan akses vena menjadi lebih terbatas dan meningkatkan tingkat kesulitan pemasangan infus di ruang perawatan. Faktor keterampilan petugas, pemilihan lokasi vena yang tersedia, serta kondisi pasien saat tindakan turut memengaruhi keberhasilan pemasangan infus.

Kegagalan pemasangan infus berulang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien, meningkatkan kecemasan anak dan keluarga, serta memperpanjang waktu pemberian terapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi petugas.

2. Pada Indikator kelengkapan dokumentasi TULBAK pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 50% dari Triwulan IV 2025 karena dokter DPJP tidak memvalidasi < 24 jam, hal ini karena:
 - a. Proses transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medik elektronik, sehingga dokter belum sepenuhnya familiar dengan alur dan fitur RME.
 - b. Tampilan dan struktur menu RME yang belum *user friendly*, sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan poin – poin yang harus diisi didukung dengan keterbatasan waktu pelayanan.
 - c. Waktu pelayanan yang terbatas, pengisian RME belum menjadi prioritas utama dibandingkan tindakan klinis.
 - d. Keterbatasan sosialisasi penggunaan RME kepada dokter DPJP
 - e. Belum ada pengingat otomatis (*allert sistem*) pada sistem RME untuk kelengkapan isian RME dan verifikasi.

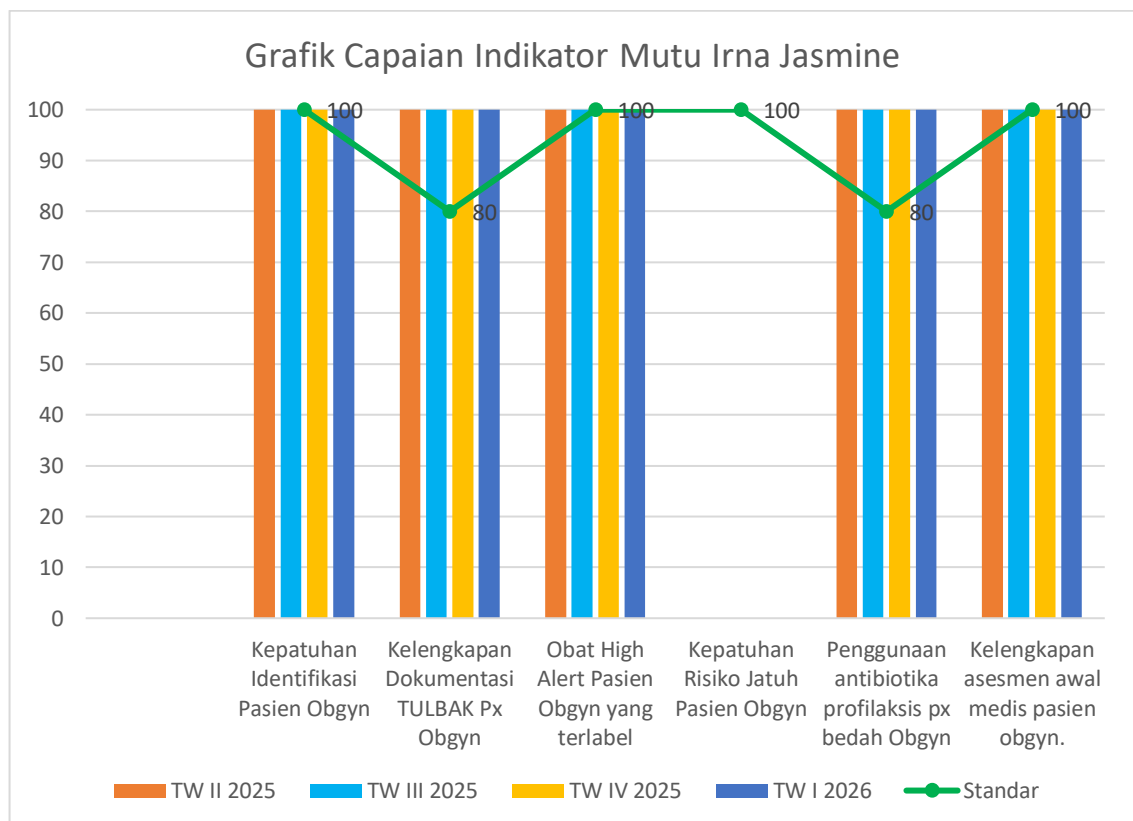
1.10. Instalasi Rawat Inap Jasmine

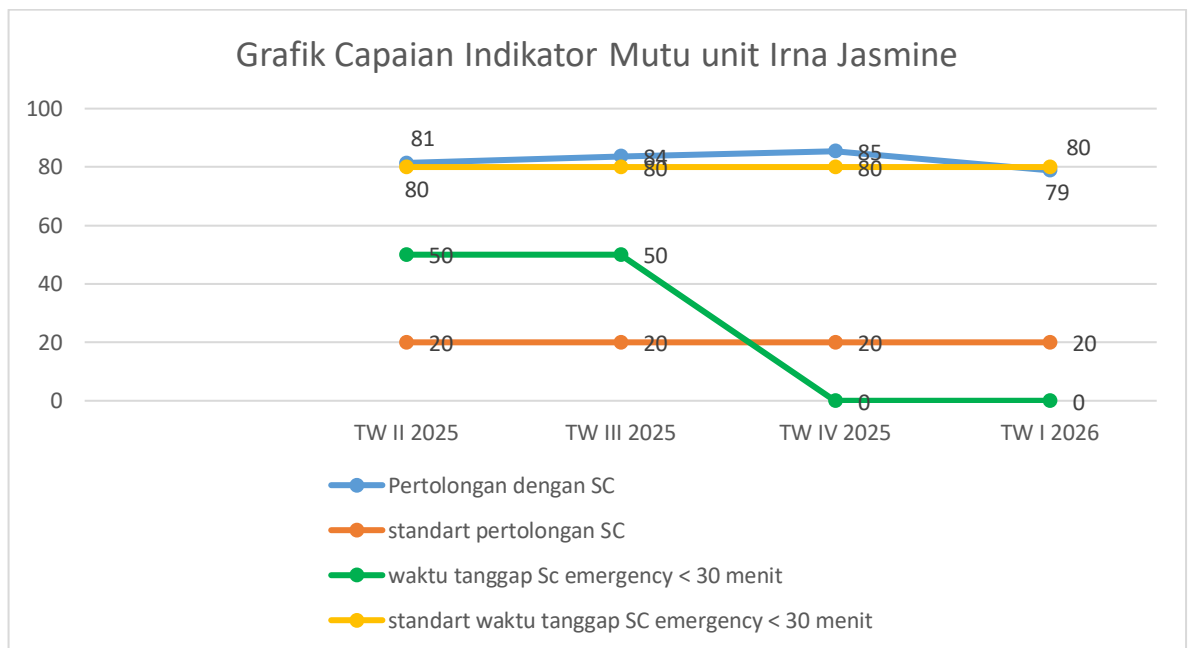
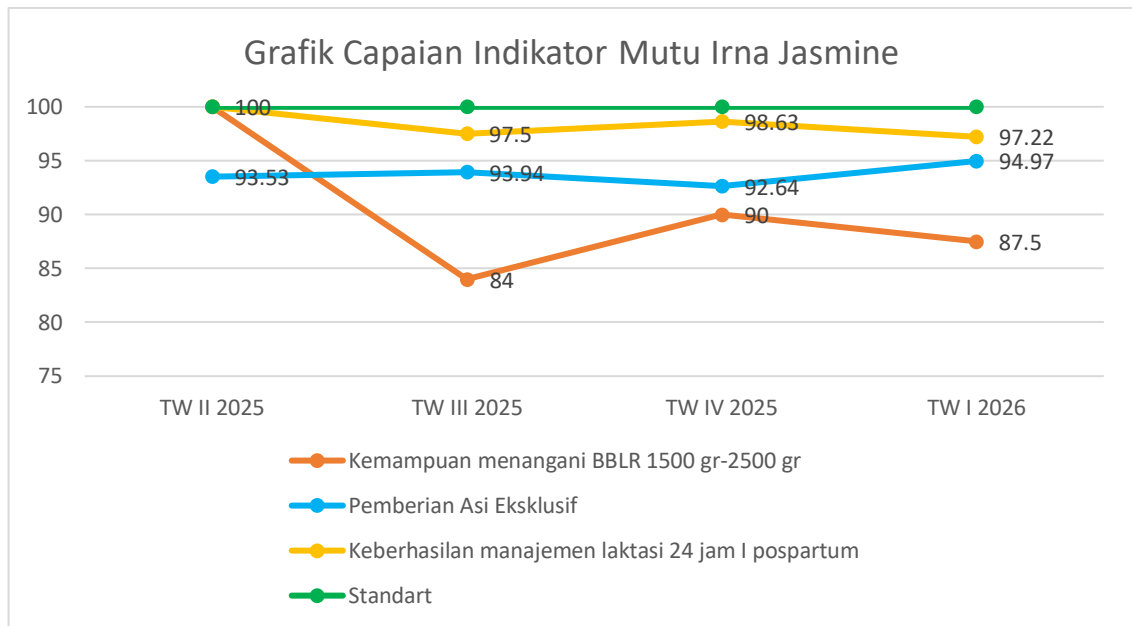
Tabel 10. Capaian indikator mutu IRNA Jasmine

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr	100%	100%	84%	90%	87,5%
2	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	20%	81,33%	83,65%	85,4%	78,87%
3	Konseling Keluarga Berencana Mantap	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pemberian Asi Eksklusif	100%	93,53%	93,95%	92,64%	94,97%
5	Kejadian Tidak Dilakukan IMD	0%	0%	0%	0%	0%
6	Kesalahan Pemberian Obat oleh Perawat	0%	0%	0%	0%	0%
7	Capaian keberhasilan manajemen laktasi	100%	100%	97,5%	98,63%	97,22%
8	Kejadian kematian ibu/ Anak	1%	1,17%	0,89%	1,49%	0%
9	Pemberi pelayanan persalinan termasuk penyulit dan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penggunaan antibiotika profilaksis pada pada pasien bedah Obgyn	80%	100%	100%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
11	Kepatuhan Identifikasi Pasien Obgyn	100%	100%	100%	100%	100%
12	Kelengkapan Dokumentasi TBAK Obgyn	≥80%	100%	100%	100%	100%
13	Obat <i>High ALert</i> yang terlabel	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	94,3%	96%	97%	99%
15	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	0%	0%	0%	0%
Indikator Mutu Prioritas RS(IMP RS)						
16	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥80%	50%	50%	nihil	nihil

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
17	Kelengkapan asesmen awal medis 24 jam pada pasien emergensi obgyn.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza





Analisa:

1. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr pada TW I 2026 mencapai 87,5 %, ada 2 bayi BBLR yang dirujuk ke rumah sakit lain karena membutuhkan CPAP mesin.
2. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria menunjukkan trend angka masih tinggi dalam 1 tahun terakhir, tetapi pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 6,53% dari Triwulan IV 2025. Hal ini Karena sebagian besar tindakan SC dilakukan atas indikasi serta rujukan dari jejaring RS yang memerlukan tindakan operasi dan rendahnya dukungan terhadap persalinan normal. Jika angka kejadian tindakan pertolongan sectio secarea tinggi berarti tidak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan Kemenkes maupun WHO, dimana sectio secarea merupakan tindakan yang beresiko komplikasi ibu dan bayi tinggi, dan selain itu tindakan Sectio membutuhkan SDM yang banyak dan membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan yang banyak.
3. Pemberian Asi Eksklusif pada TW I 2026 2,33% terdapat sekitar 4 bayi baru lahir yang tidak mendapatkan ASI secara Eksklusif.
Tidak tercapainya standar pemberian ASI eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - a. Dari sisi ibu, masih terdapat ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui seperti produksi ASI yang dirasakan kurang, puting susu datar atau lecet, kelelahan pasca persalinan, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan teknik pemberian ASI eksklusif.
 - b. Dari sisi bayi, terdapat kondisi tertentu seperti bayi prematur, berat badan lahir rendah, gangguan pernapasan, atau bayi yang memerlukan perawatan khusus sehingga pemberian ASI eksklusif mengalami hambatan. Pada beberapa kasus, bayi mendapatkan tambahan susu formula atas indikasi medis maupun atas permintaan keluarga.
 - c. Dari sisi keluarga, masih ditemukan adanya pengaruh budaya dan kepercayaan yang mendorong pemberian makanan atau minuman tambahan sebelum usia 6 bulan. Dukungan keluarga yang kurang optimal terhadap proses menyusui juga dapat memengaruhi keberhasilan ASI eksklusif.
4. Pada indikator capaian keberhasilan manajemen laktasi pada 24 jam pertama pada TW I Tahun 2026 sebesar 97,22% mengalami penurunan 1,13% dari TW IV tahun 2025 dan belum memenuhi 100% standart telah ditentukan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tidak tercapainya standar antara lain kondisi ibu pasca persalinan yang masih mengalami

nyeri, kelelahan, produksi ASI yang belum lancar, serta kurangnya kepercayaan diri ibu dalam menyusui, sehingga proses menyusui menjadi tertunda atau tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dari sisi bayi, beberapa kasus melibatkan bayi prematur, bayi berat lahir rendah, bayi dengan gangguan pernapasan, atau bayi yang memerlukan perawatan intensif sehingga kontak dini antara ibu dan bayi serta proses menyusui langsung tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dari aspek pelayanan, pelaksanaan edukasi dan konseling laktasi belum sepenuhnya seragam pada seluruh petugas. Pendampingan menyusui pada periode awal setelah persalinan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam membantu ibu mengatasi masalah pelekatan (latch on), posisi menyusui, dan teknik memerah ASI.

5. Tidak ada kejadian kematian ibu dan bayi pada Triwulan I 2026
6. Pada indikator waktu tanggap operasi sectio secarea emergency pada TW I 2026 adalah 0%, karena tidak ada kasus SC emergency pada TW I 2026.

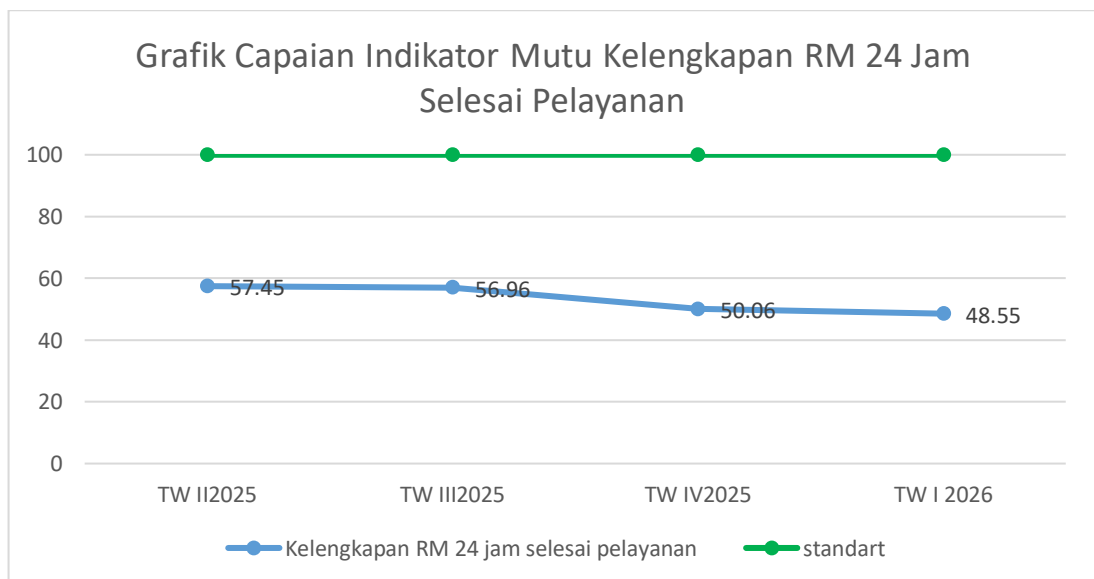
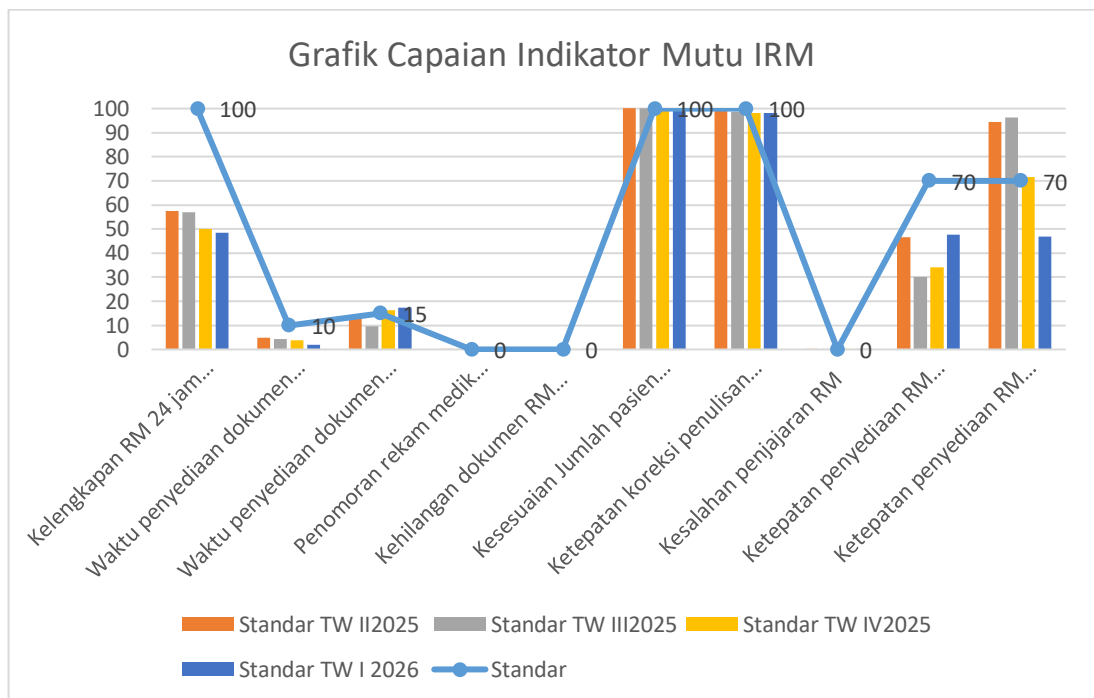
1.11. Instalasi Rekam Medis (IRM)

Tabel 11. Capaian indikator mutu Instalasi Rekam Medis (IRM)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Waktu pelayanan rekam Medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	4,86 menit	4,21 menit	3,77 menit	1,85 menit
2	Waktu pelayanan rekam Medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	13,57 menit	9,63 menit	16,22 menit	17,25 menit
3	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	57,45%	56,96%	50,06%	48,55%
4	Penomoran rekam medik ganda / dobel	0%	0,26%	0,24%	0,27%	0,32%
5	Kehilangan dokumen rekam medis pasien rawat jalan	0%	0,07%	0,05%	0,01%	0,02%
6	Kesesuaian Jumlah pasien rawat inap dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kesalahan penjajaran rekam medis	0%	0,04%	0,04%	0,03%	0,06%

8	Ketepatan penyediaan rekam medis rawat jalan	70%	46,59%	30,06%	33,98%	47,57%
9	Ketepatan penyediaan rekam medis rawat inap	70%	94,53%	96,24%	71,68%	46,88%
10	Ketepatan dalam koreksi penulisan rekam medis	100%	99,15%	98,57%	98,28%	98,15%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

1. Pada indikator kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan pada triwulan I 2026 mengalami penurunan 1,51% dari Triwulan IV 2025 dan belum mencapai standart target yang telah ditentukan disebabkan karena kurangnya kepatuhan DPJP/ perawat dalam pengisian rekam medis terutama poin resume medis di RME.
2. Masih ada penomoran rekam medik ganda / dobel pada instalasi rekam medik 0,32% pada TW I 2026 hal ini disebabkan kesalahan saat pendaftaran pasien baru, terutama pasien tanpa KTP/NIK dan yang mendaftarkan pasien bukan keluarganya.
3. Pada indikator ketepatan penyediaan rekam medis rawat jalan dan rawat inap capaiannya turun drastis pada Triwulan I 2026 disebabkan karena ketidakterpaduan sistem pendaftaran dengan sistem distribusi rekam medis menyebabkan berkas tidak dapat diproses lebih awal meskipun pasien telah mendaftar pada pagi hari.
4. Pada indikator ketepatan waktu rekam Medik pelayanan rawat inap pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 24,8% dari Triwulan IV 2025 disebabkan terkendala pada rekam wajah dan sidik jari pasien saat proses pendaftaran rawat inap.

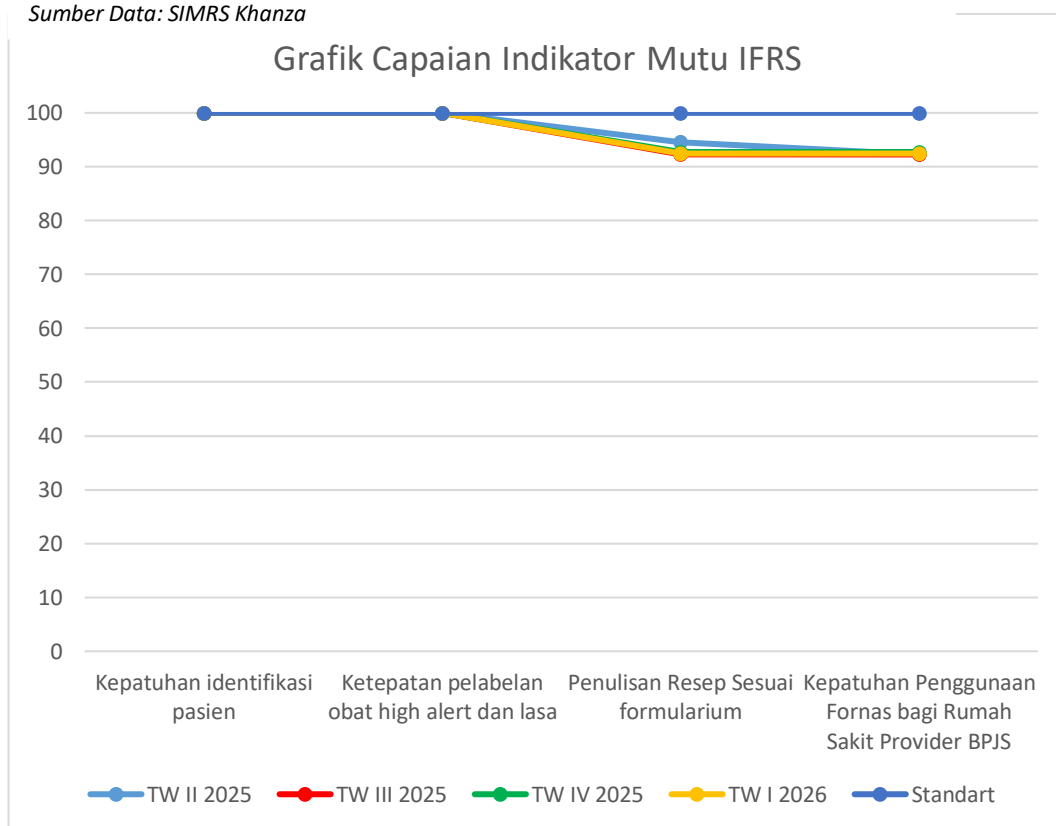
1.12. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

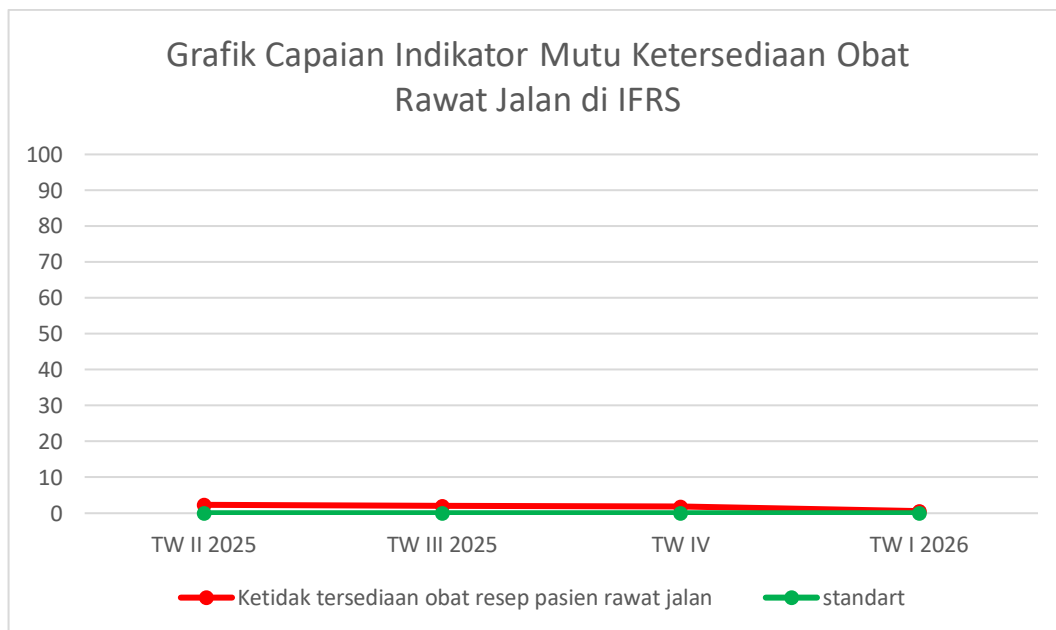
Tabel 12. Capaian indikator mutu Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Waktu tunggu pelayanan Obat Racikan	≤ 60 menit	38,67 menit	44,84 menit	43,89 menit	42,16 menit
2	Waktu Tunggu Penerimaan Obat Non Racikan	≤30 menit	26,79 menit	26,2 menit	26,15 menit	25,7 menit
3	Ketepatan dalam melakukan pelabelan obat <i>high alert</i> dan <i>LASA</i>	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketidakterediaan obat dalam resep untuk pasien rawat jalan	1%	2,03%	1,79%	0,78%	0,59%
5	Kepatuhan Penggunaan Fornas	≥ 80%	92,33%	92,73%	92,23%	92,44%
6	monitoring efeksamping obat	100 %	0,01%	0%	0,01%	0%

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
7	Kesalahan Penyerahan Perbekalan Farmasi	1%	0%	0%	0%	0%
8	Penulisan Resep Sesuai formularium	100%	94,72%	96,03%	96,13%	96,19%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
9	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza





Analisa:

1. Ketidakterediaan obat dalam resep untuk pasien rawat jalan pada TW I 2026 sebesar 0,59% mencapai standar yang telah ditetapkan 1%.
2. Pada indikator penulisan Resep Sesuai formularium nasional pada TW I 2026 mencapai angka yang sama dengan TW IV 2025 , tetapi masih belum mencapai standart yang telah ditentukan 100%. Hal ini disebabkan karena dokter meresepkan obat berdasarkan pengalaman klinis pasien tanpa melihat daftar formularium nasional.

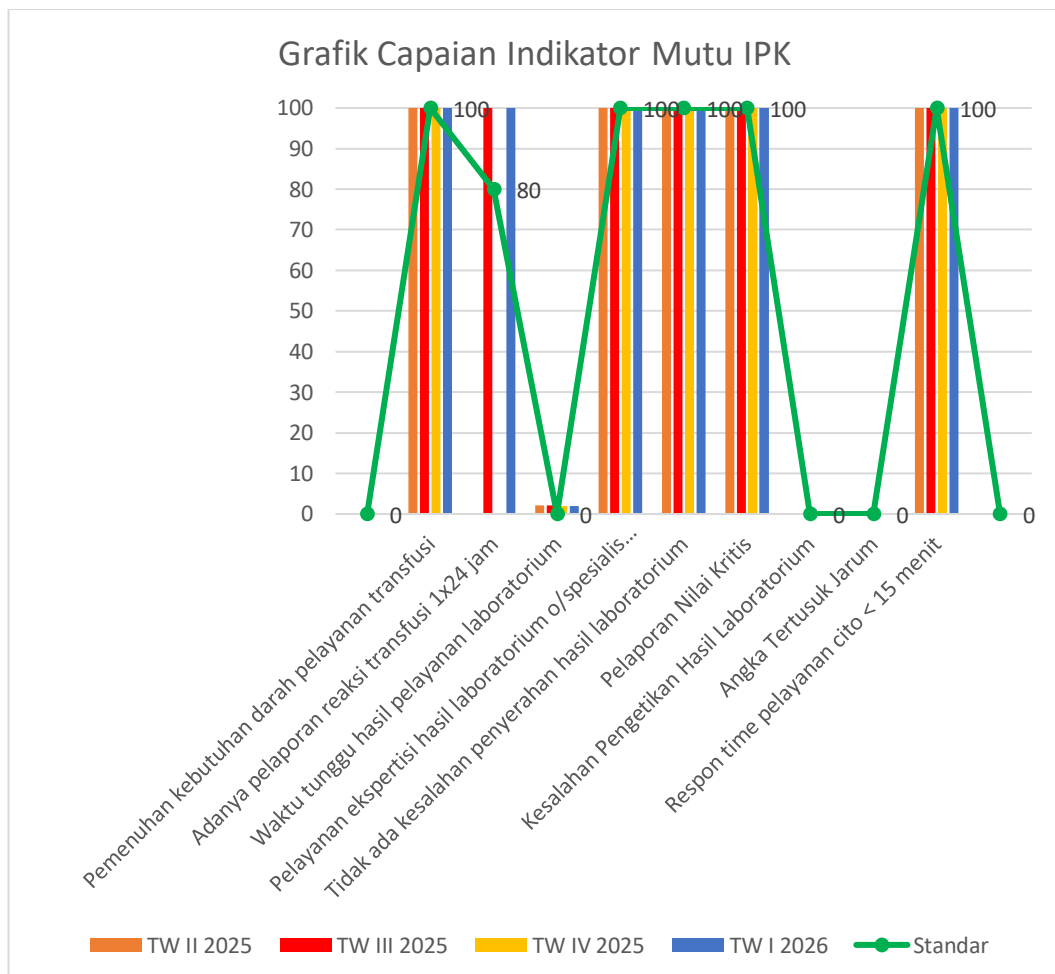
1.13. Instalasi pelayanan Laboratorium Terpadu (IPLT)

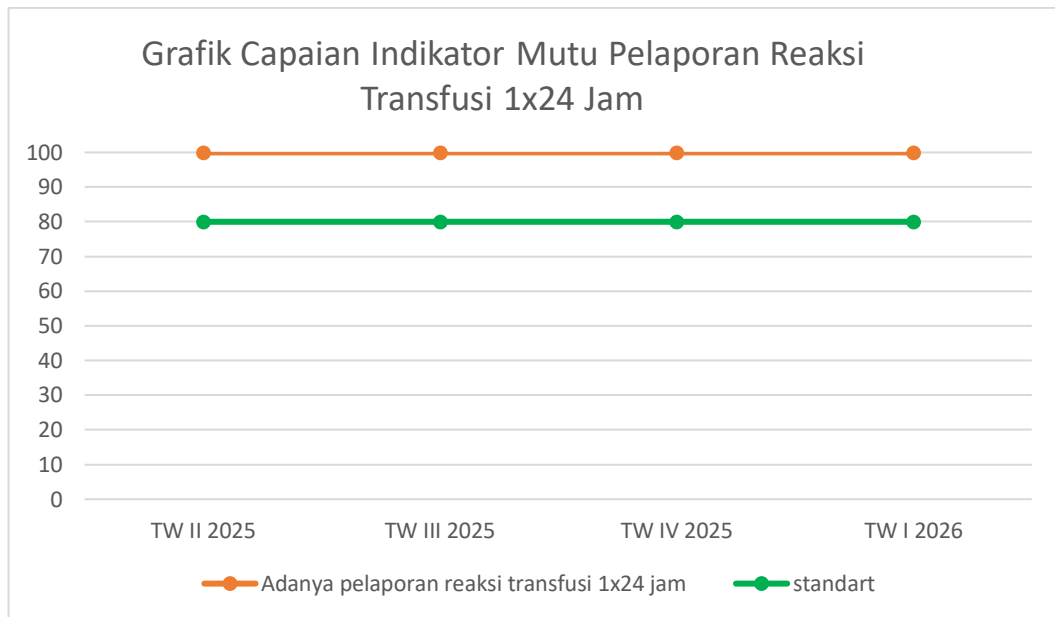
Tabel 13. Capaian indikator mutu Instalasi Pelayanan laboratorium Terpadu (IPLT)

No	Indikator	Target/Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan Kejadian reaksi tranfusi $\leq$ 24 jam	80%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaporan Nilai Kritis	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	99,95%	99,98%	99,96%
5	Angka Tertusuk Jarum	0%	0%	0%	0%	0%
6	Kesalahan Pengetikan Hasil Laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
7	Respon time pelayanan cito < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%
8	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	140 menit	2,1 menit	2,04 menit	1,99 menit	1,99 menit
9	Pelayanan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium oleh spesialis patologi klinik	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
10	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	81,6%	80%	85%	%

Sumber Data: SIMRS





Analisa:

Pada indikator tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan hasil laboratorium pada TW I 2026 mencapai 99,96% . Ada 2 kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan, hal ini disebabkan karena ketidak sesuaian informasi antara informasi yang diterima petugas laboratorium dengan kondisi aktual yang saat hasil diserahkan.

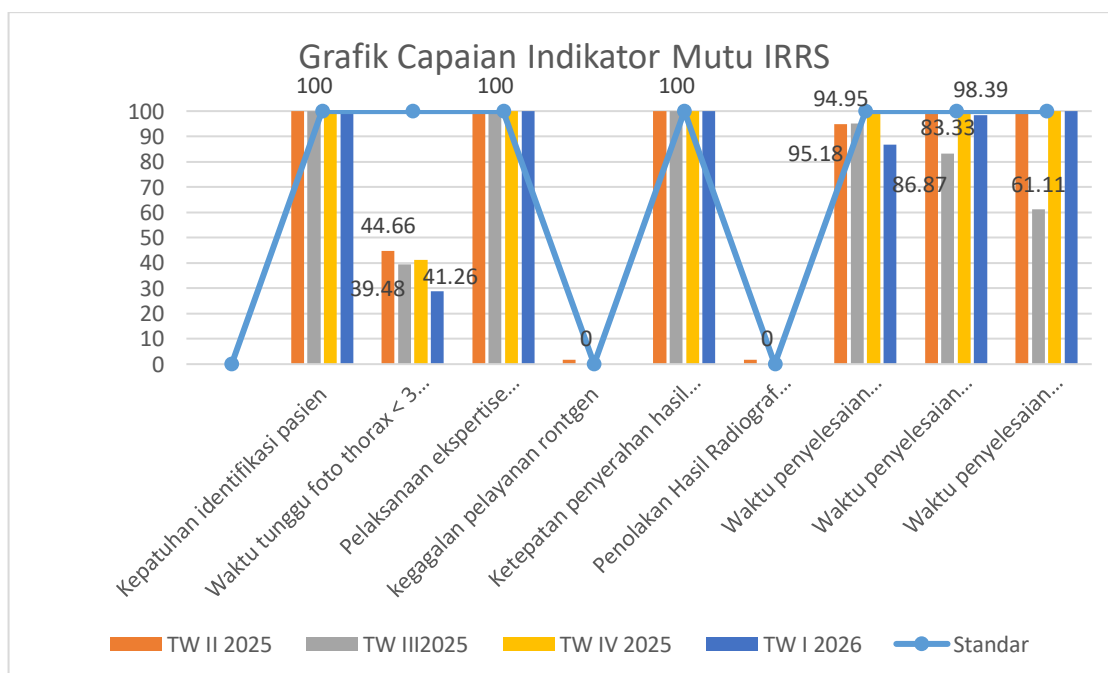
1.14. Instalasi Radiologi Rumah Sakit (IRRS)

Tabel 14. Capaian indikator mutu Instalasi Radiologi Rumah Sakit (IRRS)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 3 jam	100%	39,48%	41,26%	36,46%	28,76%
2	Pelaksanaan ekspertise	100 %	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	1,65%	0%	0%	0%
4	Ketepatan penyerahan hasil foto dan usg	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
5	Penolakan Hasil Radiograf Oleh Dokter Spesialis Radiologi	0%	0%	0%	0,57%	0%
6	Waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi reguler ≤ 24 jam	100%	95,18%	98,96%	91,91%	86,87%
7	Waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi CITO < 60 menit	100%	83,33%	100%	97,73%	98,39%
8	Waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi ke rumah sakit lain ≤ 24 jam	100%	61,11%	100%	97,37%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
9	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	$\geq 85\%$	83,3%	96%	89%	95%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax ≤ 3 jam pada Triwulan I 2026 28,76 % belum sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jam pelayanan dokter spesialis radiologi di RS.
2. Waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi reguler ≤ 24 jam pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 5,04% dari Triwulan IV 2025 dan waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi CITO < 60 menit pada TW I 2026 98,39% mengalami peningkatan dari TW IV 2025, dan belum mencapai standart yang telah ditentukan karena adanya keterlambatan dokter spesialis radiologi dalam membacakan dan memberikan pelaporan hasil interpretasi.

1.15. Instalasi Gizi Rumah Sakit (IGRS)

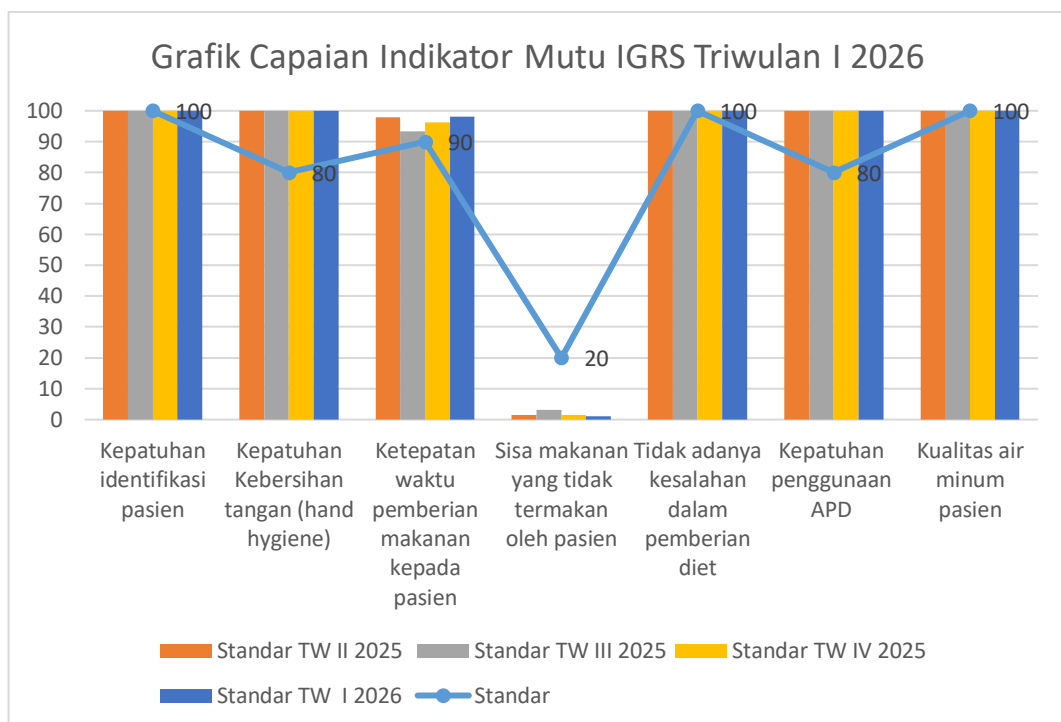
Tabel 15. Capaian indikator mutu Instalasi Gizi Rumah Sakit (IGRS)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien	$\geq 90\%$	97,85%	93,34%	96,34%	96,34%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	$\leq 20\%$	1,48%	3,13%	1,54%	1,54%
3	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan penggunaan APD	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mengidentifikasi pasien dengan benar	100	100%	100%	100%	100%
6	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	$\geq 85\%$	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

Seluruh indikator mutu IGRS sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada TW I tahun 2026.



1.16. Instalasi Laundry Rumah sakit (ILRS)

Tabel 16. Capaian indikator mutu Instalasi Laundry Rumah Sakit (ILRS)

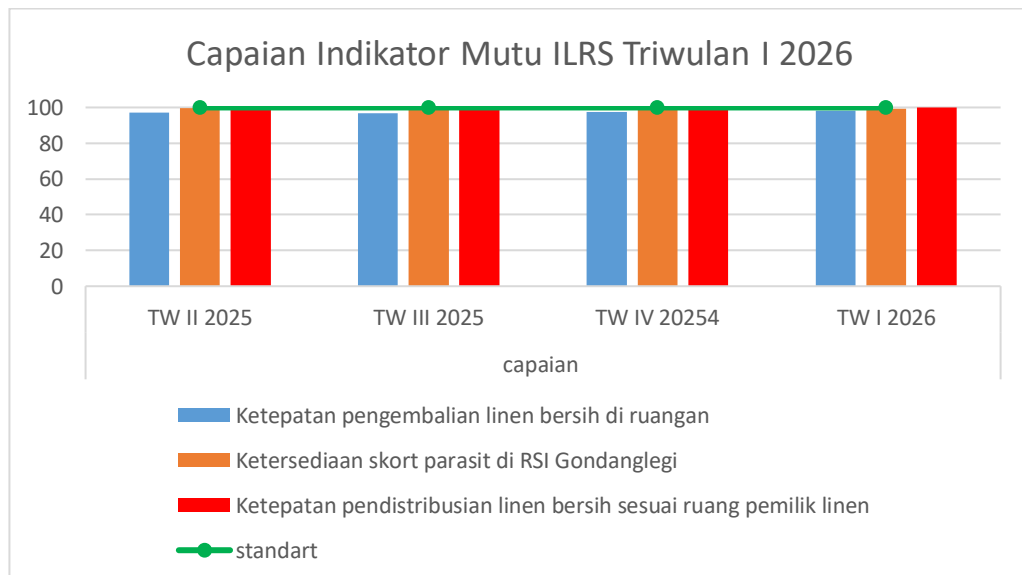
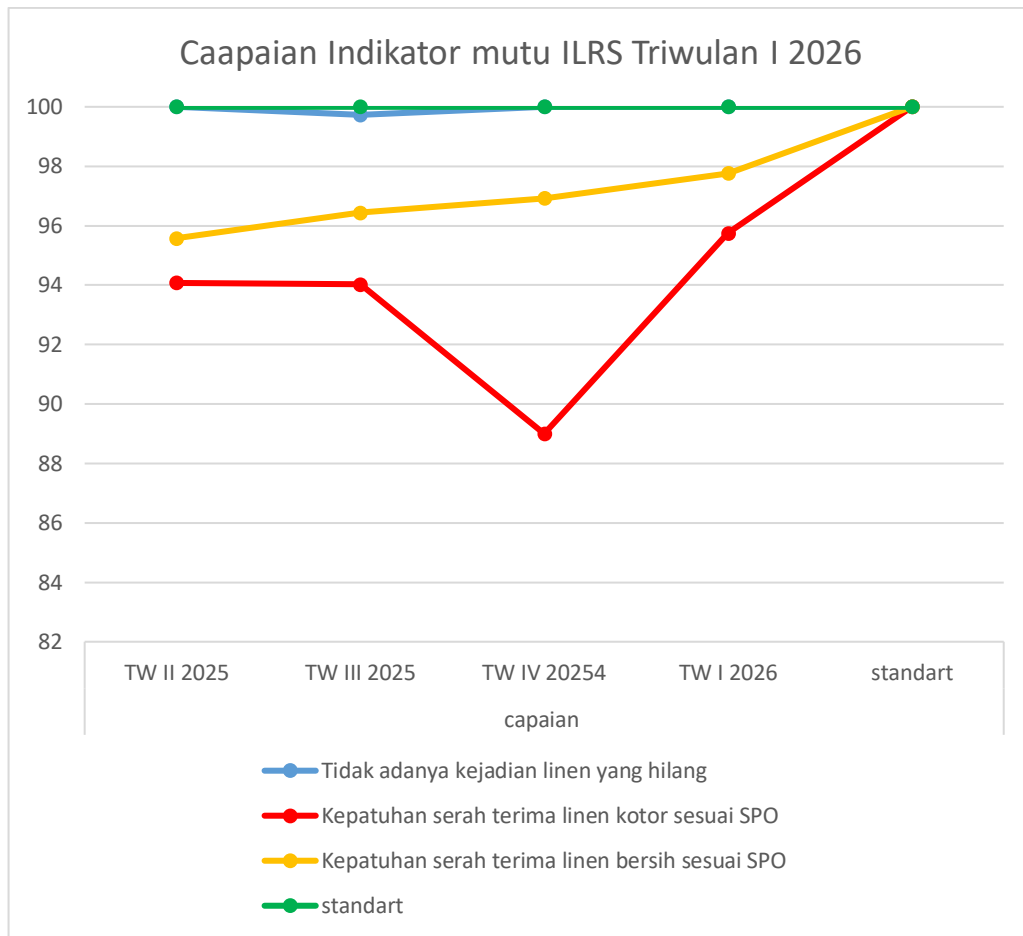
No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2025
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Tidak adanya linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	99,84%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan serah terima linen kotor sesuai SPO	100%	94,08%	94,02%	89%	85,81%
4	Kepatuhan serah terima linen bersih sesuai SPO	100%	95,58%	96,44%	96,92%	97,63%
5	Ketepatan pengembalian linen bersih di ruangan	100%	97%	96,84%	97,51%	97,65%
6	Ketersediaan skort parasit di RSI Gondanglegi	100%	99,62%	99,89%	99,53%	99,49%
7	Ketepatan pendistribusian linen bersih sesuai ruang pemilik linen	100%	100%	99,96%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2025
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
8	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	98%	97%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

1. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat Inap pada periode II 2025 sampai dengan periode I 2026 sudah mencapai standart.
2. Kepatuhan serah terima linen kotor dan linen bersih belum sesuai dengan SPO pada TW I 2026 masih belum mencapai standart target 100%, penyebabnya adalah petugas terkadang melewatkan langkah serah terima karena pada saat serah terima dengan instalasi rawat inap masih sibuk dengan pelayanan pasien.
3. Ketepatan pengembalian linen bersih di ruangan masih belum sesuai dengan standart karena prosedur penataan linen yang dilakukan secara bertumpuk didalam troly mengakibatkan ada linen yang terselip dan salah penempatan ruangan.
4. Ketersediaan skort parasit di RSI Gondanglegi pada TW I 2026 masih belum sesuai dengan standart yang telah ditentukan dikarenakan ketidaksesuaian waktu operasional antara petugas laundry dan unit IRJ (khusus untuk IRJ).
5. Pada indikator ketidakadanya linen hilang ada 1 linen hilang pada Triwulan I 2026 karena terbawa pasien saat rujuk.



1.17. Instalasi Sterilisasi Sentral (ISS)

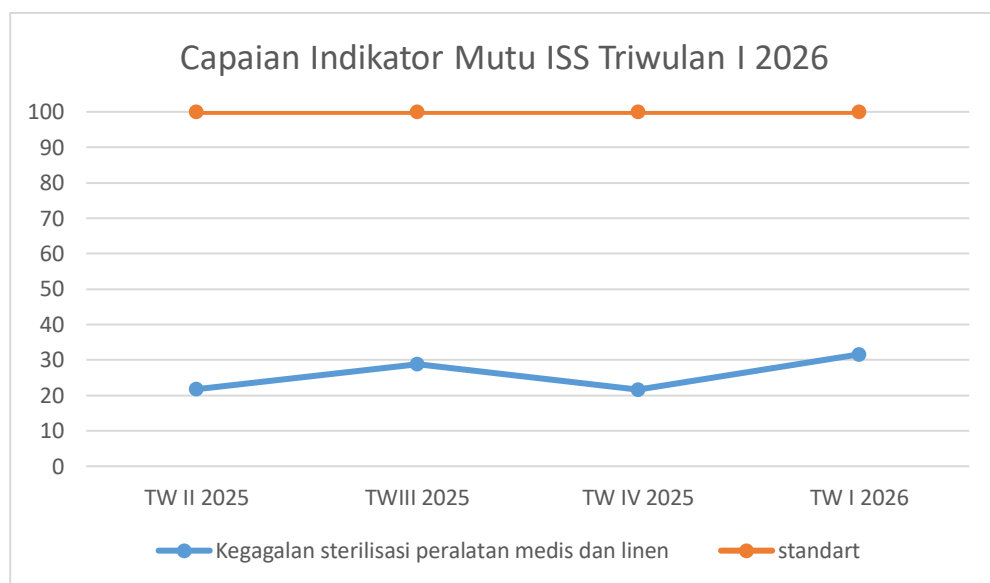
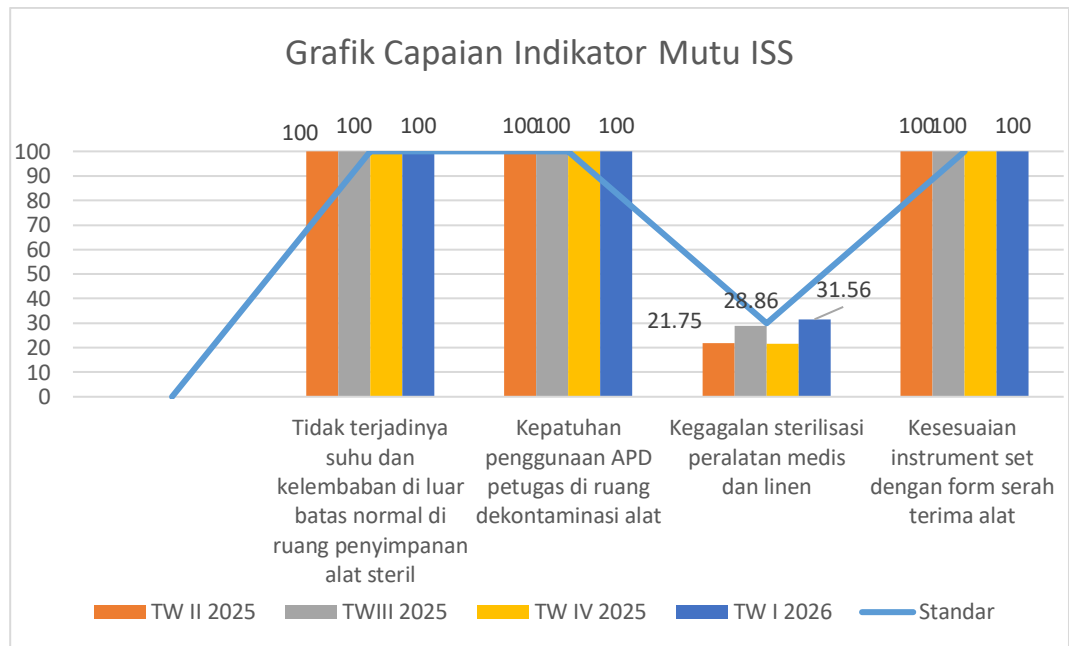
Tabel 17. Capaian indikator mutu Instalasi Sterilisasi sentral (ISS)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Tidak terjadinya suhu dan kelembaban di luar batas normal di ruang penyimpanan alat steril	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan APD petugas di ruang dekontaminasi alat	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kegagalan sterilisasi	30%	21,75%	28,86%	21,62%	31,56%
4	Kesesuaian instrument set dengan form serah terima alat	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
5	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	98%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

Pada indikator kegagalan sterilisasi pada TW I 2026 masih tinggi 31,56%, bahkan mengalami peningkatan 9,94% dari Triwulan IV 2025 hal ini disebabkan karena penggunaan autoclave tipe manual yang tidak memiliki sistem pengaturan otomatis terhadap parameter sterilisasi, sehingga proses pengeringan tidak optimal dan tekanan yang berlebihan menyebabkan segel pouches terbuka dan air masuk kedalam pouches.

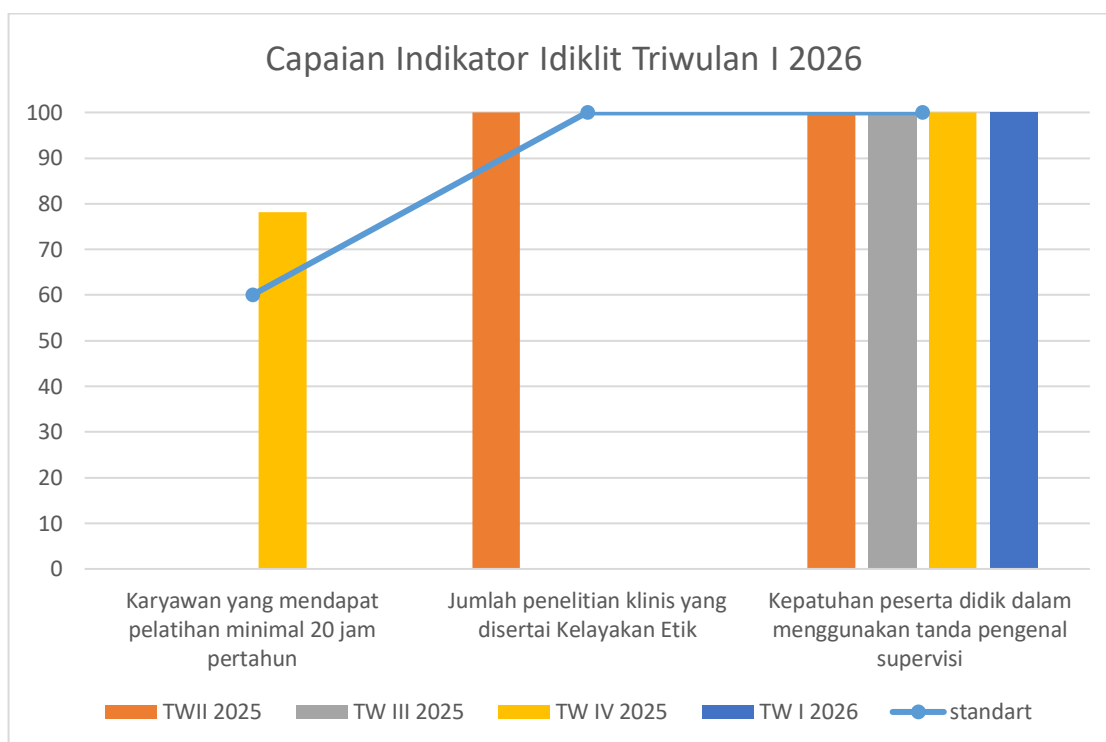


1.18. Instalasi Diklit

Tabel 18. Indikator Instalasi Pendidikan Pelatihan dan Penelitian (DIKLIT)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
1	Kepatuhan peserta didik dalam menggunakan tanda pengenalan supervisi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah penelitian klinis yang disertai dengan kelayakan etik	100%	100%	0%	0%	0%
3	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	60%	-	-	78,16%	-

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

1. Indikator I-Diklit pada Triwulan I 2026 sudah mencapai standart yang telah ditentukan.
2. Untuk indikator jumlah penelitian klinis yang disertai kelayakan etik pada periode Triwulan III tahun 2025 sampai Triwulan I 2026 0% karena tidak ada penelitian klinis pada periode tersebut.

1.19. Instalasi Teknologi Informasi (ITI)

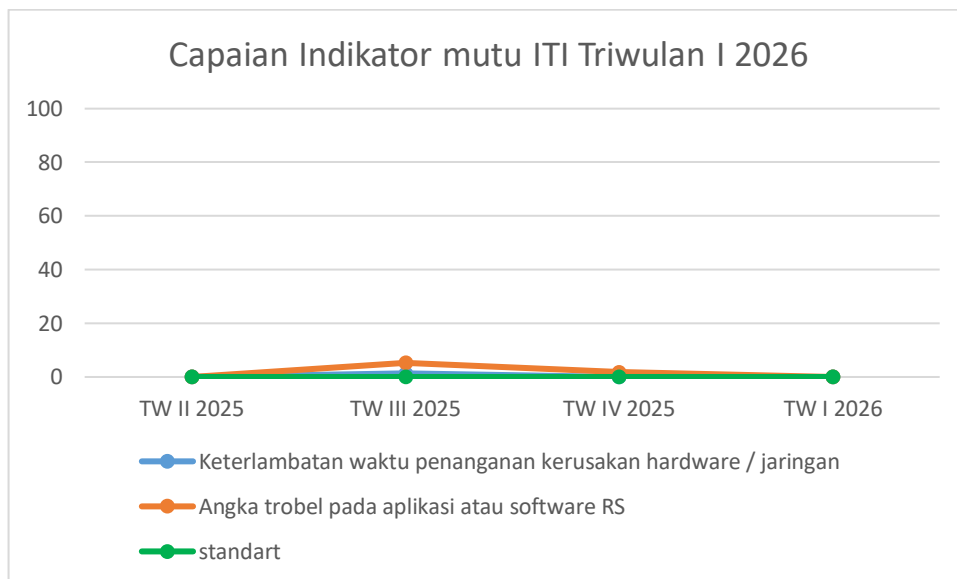
Tabel 19. Capaian indikator mutu Instalasi Teknologi Informasi

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2025
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Keterlambatan waktu penanganan kerusakan hardware / jaringan	0%	0%	1,35%	0%	0%
2	Angka trobel pada aplikasi atau software RS	0%	0%	5,26%	1,75%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

Pada TW I tahun 2026 capaian indikator mutu Instalasi Teknologi Informasi sudah mencapai standart yang telah ditentukan.

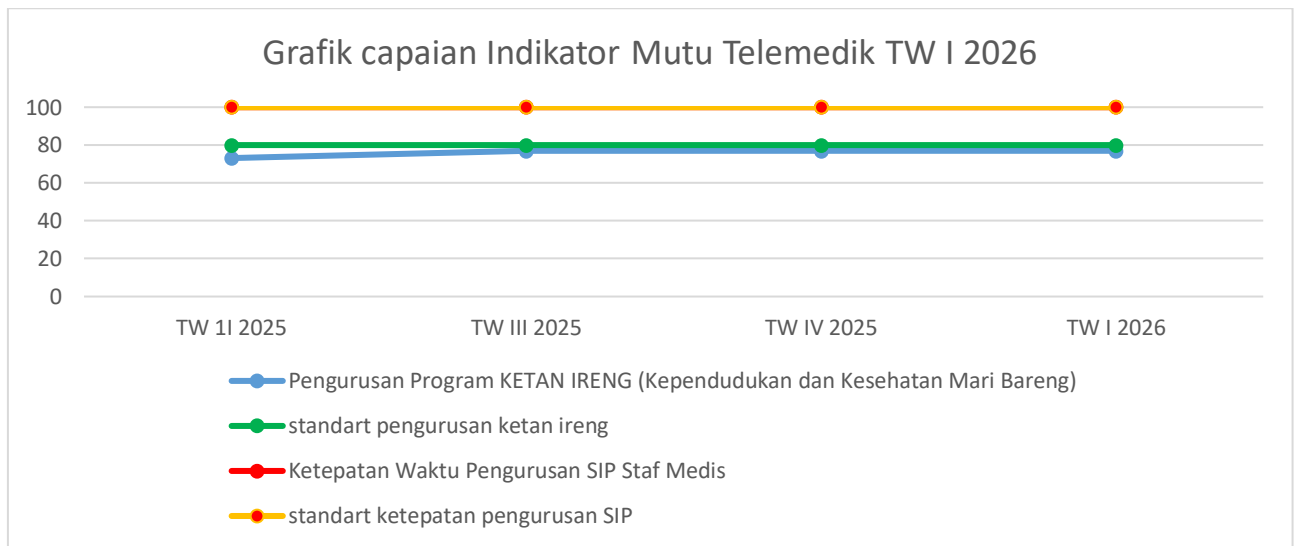


1.20. Pelayanan Telemedik

Tabel 20. Capaian Indikator Mutu Telemedik

No	Indikator	Target /standart	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
1	Pengurusan Program KETAN IRENG (Kependudukan dan Kesehatan Mari Bareng)	75%	73,13%	76,97%	76,84%	76,88%
2	Ketepatan Waktu Pengurusan SIP Staf Medis	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

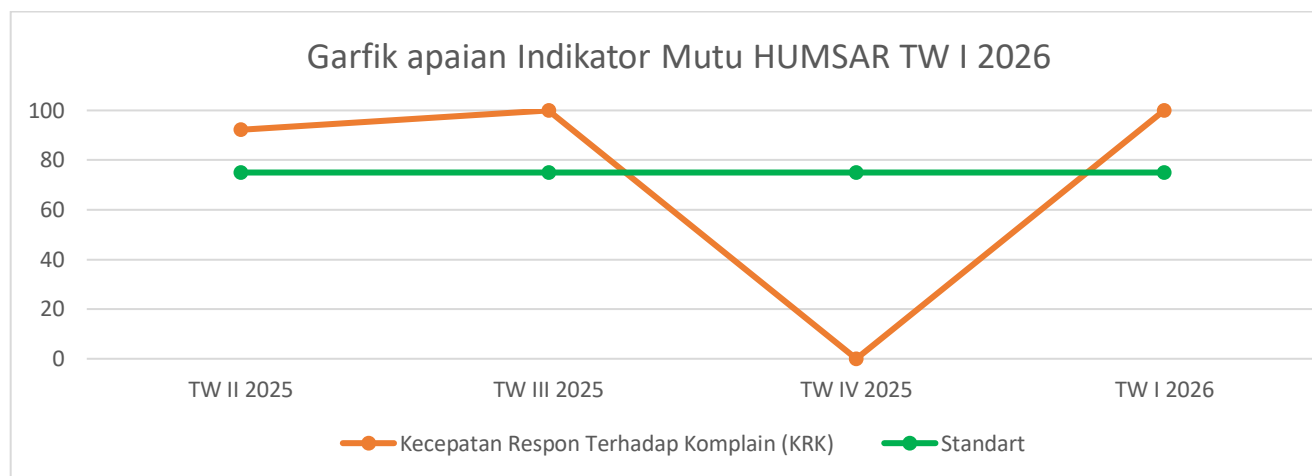
1. Capaian indikator mutu Telemedik TW I 2026 sudah mencapai target standart yang telah ditentukan.
2. Pada indikator ketepatan waktu pengurusan SIP staff medis pada Triwulan I 2026 capaiannya 0% karena pada kurun waktu Triwulan I 2026 tidak ada staff medis yang melakukan pengurusan SIP.

1.21. Pelayanan HUMSAR

Tabel 21. Capaian Indikator Mutu HUMSAR

No	Indikator	Target/ standart	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	75%	92,31%	100%	0%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

Pada TW I Tahun 2026 angka kecepatan respon tanggap komplain 100% dan semua komplain sudah ditanggapi sesuai dengan SPO.

1.22. Instalasi Logistik

Tabel 22. Capaian indikator Instalasi Logistik

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Ketidak sesuaian surat pesanan (SP) dengan fisik barang / bahan	0%	0%	0%	0%	0%
2	Angka kehilangan barang saat stock opname	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa :

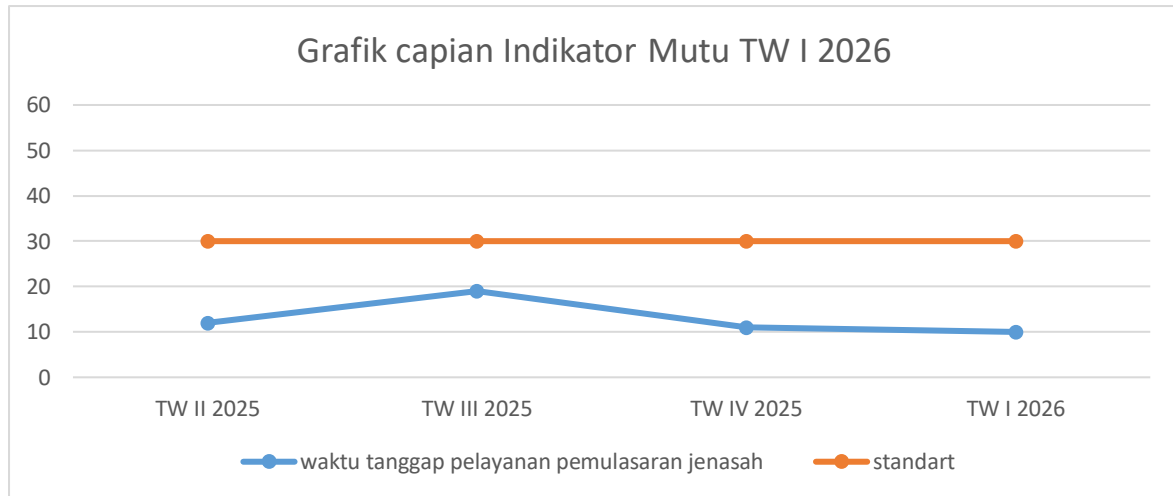
Seluruh Indikator mutu Instalasi logistik pada TW I 2026 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.23. Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Rohani

Tabel 23. Capaian indikator mutu Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Rohani (IPJPR)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤30 menit	12 menit	19,2 menit	10,9 menit	10,46 menit
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
2	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	97%	97%	97%	97%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

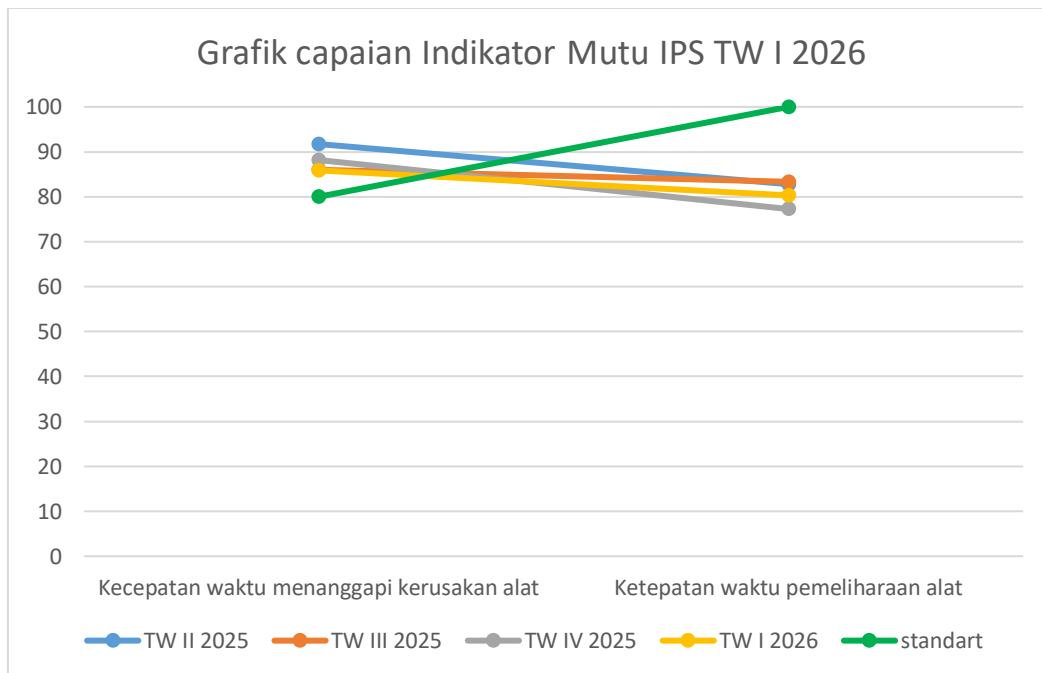
Indikator mutu pada unit IPJPR pada TW I 2026 100% sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.24. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)

Tabel 24. Capaian indikator mutu Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80%	85,23%	91,72%	88,17%	85,87%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	79,47%	82,8%	77,27 %	80,3%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit) Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
3	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	97%	97%	97%	97%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

1. Pada indikator kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat pada TW I Tahun 2026 mengalami penurunan 2,3% dari TW IV Tahun 2025. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan jumlah alat yang mengalami kerusakan dengan jumlah teknisi yang tersedia, beban teknisi meningkat seiring dengan jumlah alat yang mengalami perbaikan sehingga terjadi keterlambatan penanganan kerusakan alat.

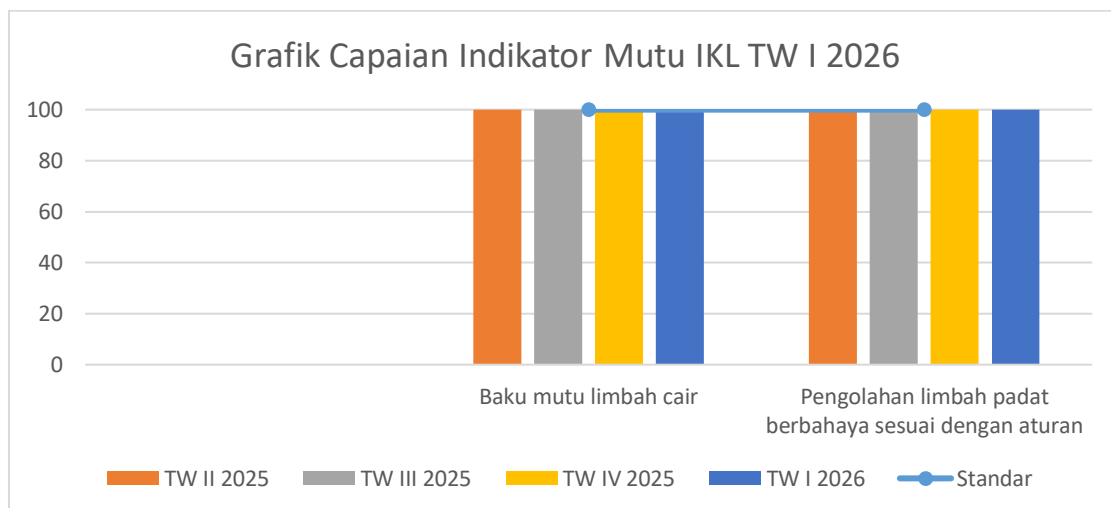
2. Pada indikator ketepatan waktu pemeliharaan alat pada TW I Tahun 2026 mengalami peningkatan dari TW IV Tahun 2025 sebesar 2,4%, tetapi masih belum mencapai standart yang ditentukan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor , diantaranya:
- Jumlah teknisi atau staf instalasi pemeliharaan alat yang terbatas.
 - Fokus teknisi lebih pada perbaikan alat yang rusak (corrective maintenance) dibandingkan pemeliharaan berkala.
 - Alat rusak mendesak cenderung menyita waktu dibanding alat yang masih berfungsi.

1.25. Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL)

Tabel 25. Capaian Indikator Mutu Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Baku mutu limbah cair	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
3	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	98%	97%	97%	98%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

Seluruh indikator mutu Instalasi Kesehatan Lingkungan TW I Tahun 2026 sudah memenuhi standart yang telah ditentukan.

1.26. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Tabel 26. Capaian Indikator Mutu Pelayanan Rehabilitasi Medis

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 5 %	0%	0%	0%	0%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
3	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	92,6%	100%	98%	98%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa :

Seluruh indikator mutu pelayanan rehab medis pada TW I Tahun 2026 sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.27. Unit Kendaraan

Tabel 27. Capaian Indikator Mutu Unit Kendaraan

No	Indikator	Target /standart	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit	30 menit	1 menit	1 menit	1menit	1 menit
3	Kelengkapan Ceklist Kendaraan Ambulan	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
4	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	90%	91%	93%	96%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa :

Seluruh indikator mutu pada unit kendaraan pada TW I Tahun 2026 sudah memenuhi standart target yang telah ditentukan.

1.28. Unit Keamanan

Tabel 28. Capaian indikator Instalasi Keamanan

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Angka kejadian kehilangan di RSIG	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

Tidak terjadi kehilangan di lingkungan RS selama triwulan I tahun 2026.

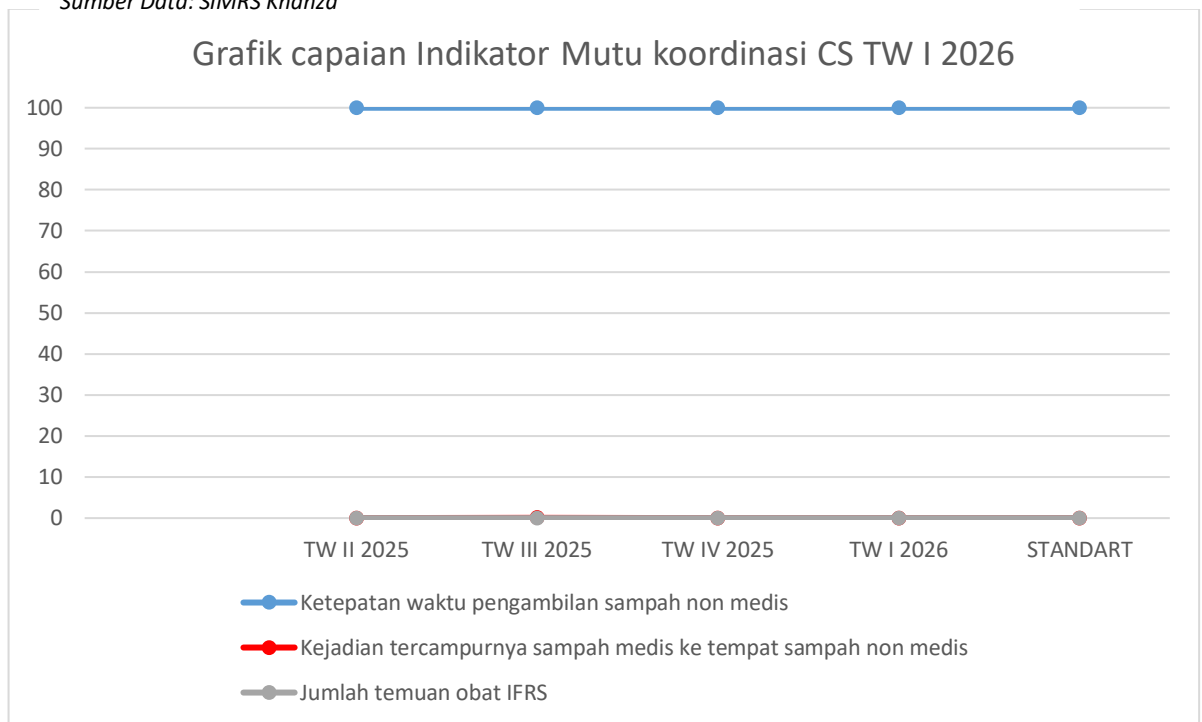
1.29. Koordinasi Cleaning Servis

Tabel 29. Capaian indikator Koordinasi Cleaning Service

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Ketepatan waktu pengambilan sampah non medis	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian tercampurnya sampah medis ke tempat sampah non medis	0%	2,54%	0%	0%	0%
3	Temuan perbekalan farmasi di tempat sampah	0%	0%	0%	0%	0%
Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						

3	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85%	97%	98%	98%	98%
---	---	------	-----	-----	-----	-----

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa:

Pada TW I 2026 seluruh capaian indikator mutu koordinasi CS sudah sesuai dengan standart yang telah dilakukan.

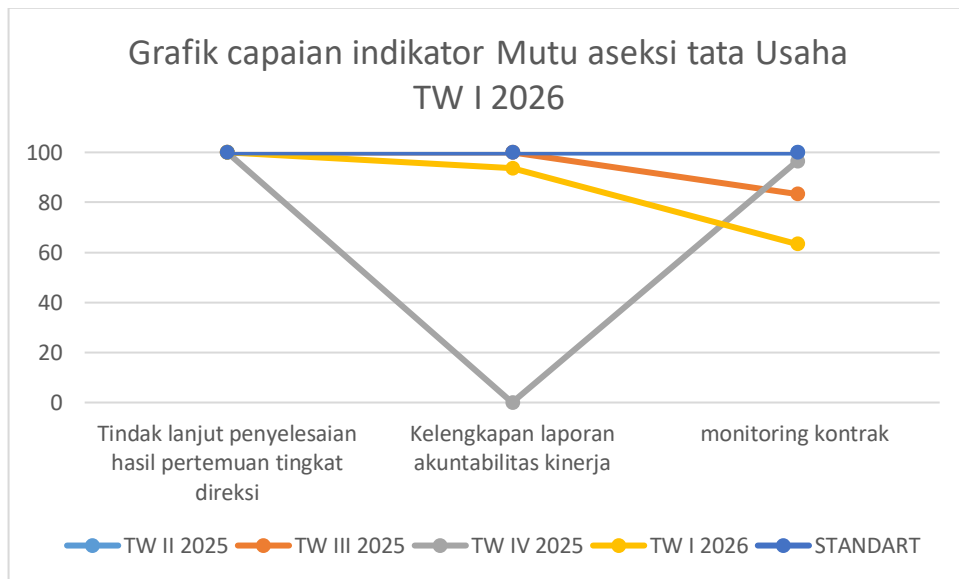
4. Capaian Indikator Mutu Management

2.1 Kepala Seksi Tata Usaha dan Hukum

Tabel 30 Capaian indikator Tata Usaha

No.	Indikator	Standart/ target	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit						
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	93,75%	93,59%
3	monitoring kontrak	100%	73,97%	95,65%	89,29%	63,33%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

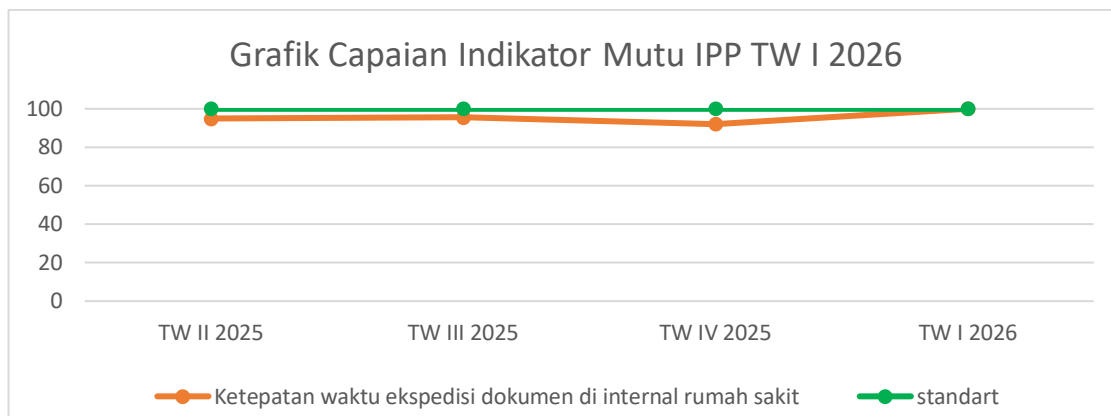
1. Pada indikator monitoring kontrak TW I Tahun 2026 sebesar 63,33 % karena ada perjanjian kerjasama dengan pihak luar yang tidak diperpanjang karena ada beberapa karyawan yang tidak meneruskan kontrak kerja karena mengundurkan diri dan beberapa karyawan kontrak yang telah dinyatakan lulus sebagai karyawan tetap, sehingga jumlah kontrak yang aktif pada periode ini berkurang.
2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja pada TW I Tahun 2026 mengalami penurunan karena ada beberapa laporan yang dikirim ke TU terlambat.

2.2 Instalasi Pelayanan Perkantoran

Tabel 31. Capaian Indikator Mutu IPP

No	Indikator	Target/ Standart	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
1	Ketepatan waktu ekspedisi dokumen di internal rumah sakit	100%	95,12%	94,76%	91,51%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

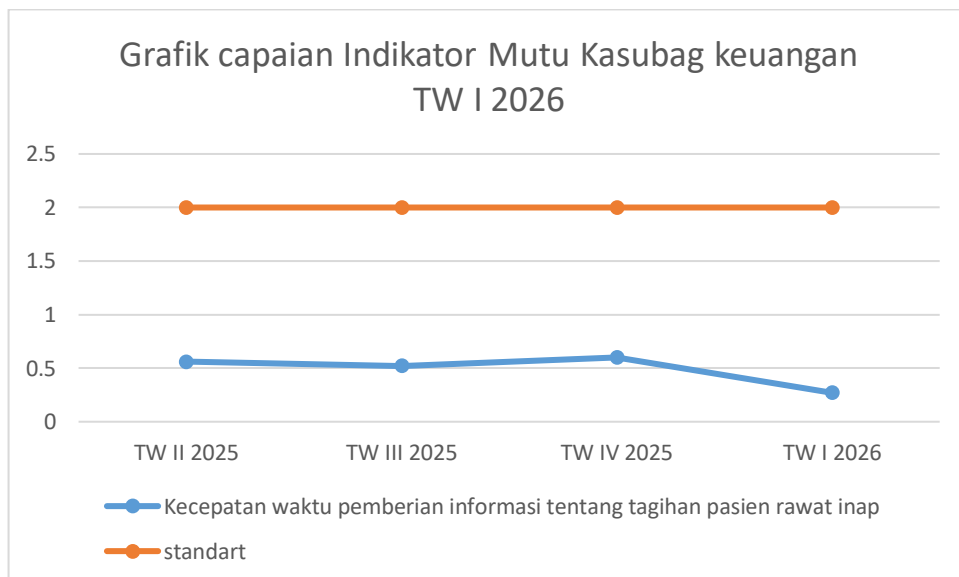
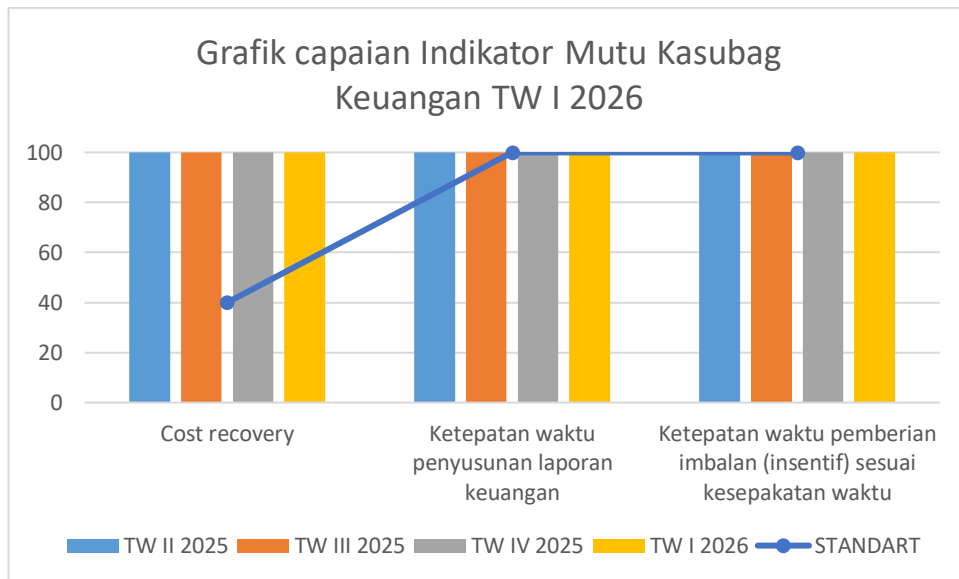
Pada TW I 2026 pada indikator ketepatan waktu ekspedisi dokumen internal rumah sakit mengalami peningkatan 8,49% dari TW IV Tahun 2025, dan sudah mencapai target standart yang telah ditentukan.

2.3 Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan

Tabel 32 Capaian Indikator Mutu Akuntansi dan Keuangan

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Cost recovery	≥ 40%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	0,56 jam	0,52jam	0,6jam	0,27 jam
4	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

Seluruh indikator pada kasubag akuntansi dan keuangan pada TW I 2026 semua sudah mencapai standart target yang telah ditentukan.

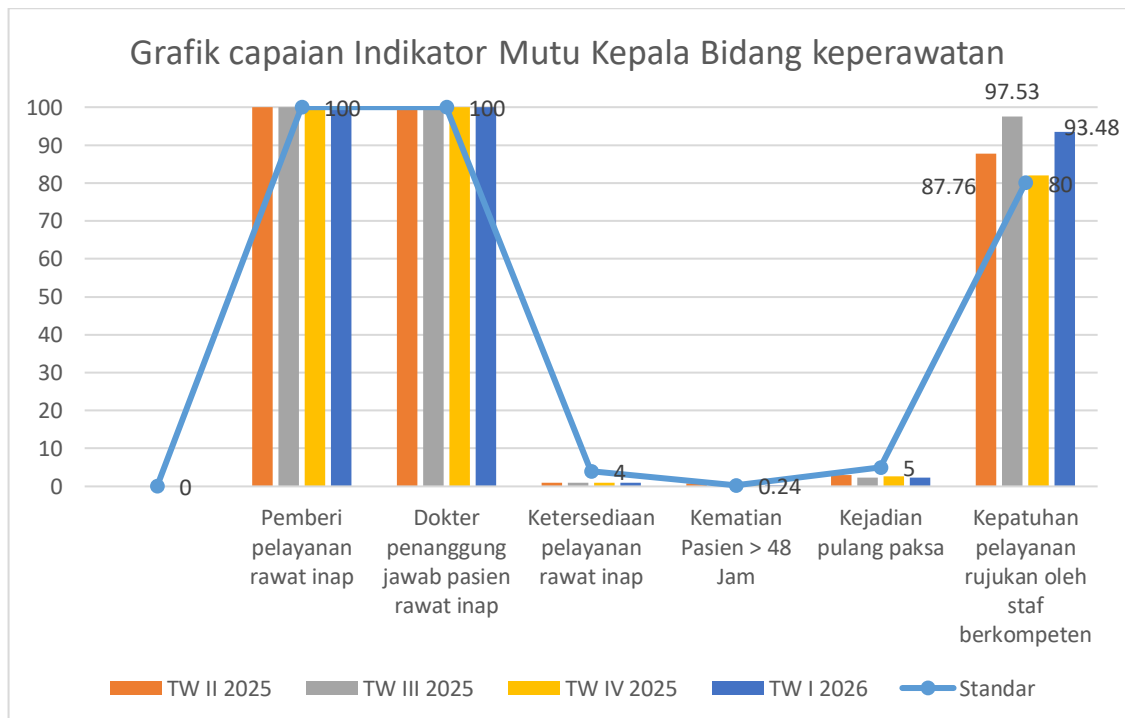
3. Capaian Indikator Kepala Bidang Keperawatan

Tabel 33. Capaian Indikator Bidang Keperawatan

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
1	Pemberi pelayanan rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	min kesehatan anak, PD, kebidanan ,bedah (ada-1 , tidak ada =0)	1	1	1	1
4	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0,87%	0,56%	0,71%	0,29%
5	Kejadian pulang atas permintaan sendiri	≤ 5%	2,91%	2,24%	2,58%	2,37%
6	Kepatuhan pelayanan rujukan oleh staf yang kompeten	80%	87,76%	97,53%	82,05%	93,48%

Sumber Data: SIMRS



Analisa :

1. Kematian pasien > 48 jam pada TW I Tahun 2026 0,29% mengalami penurunan belum memenuhi standart yang telah ditentukan. Kematian disebabkan perjalanan penyakit dan kondisi klinis pasien.
2. Kejadian pulang atas permintaan sendiri pada TW I 2026 turun 0,2 % dari TW IV 2025. Penyebab APS diantaranya yaitu pasien merasa sudah sembuh, faktor psikologis(kebosanan, takut,tidak nyaman dll), penolakan tindakan medis dan permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas/ spesifik. Maka perlu tetap ditingkatkan konseling tentang resiko APS dan evaluasi penyebab APS.
3. Kepatuhan pelayanan rujukan oleh staff yang kompeten pada TW I Tahun 2026 mengalami peningkatan 11,43% dari TW IV Tahun 2025, dan sudah mencapai standart target yang telah ditentukan.

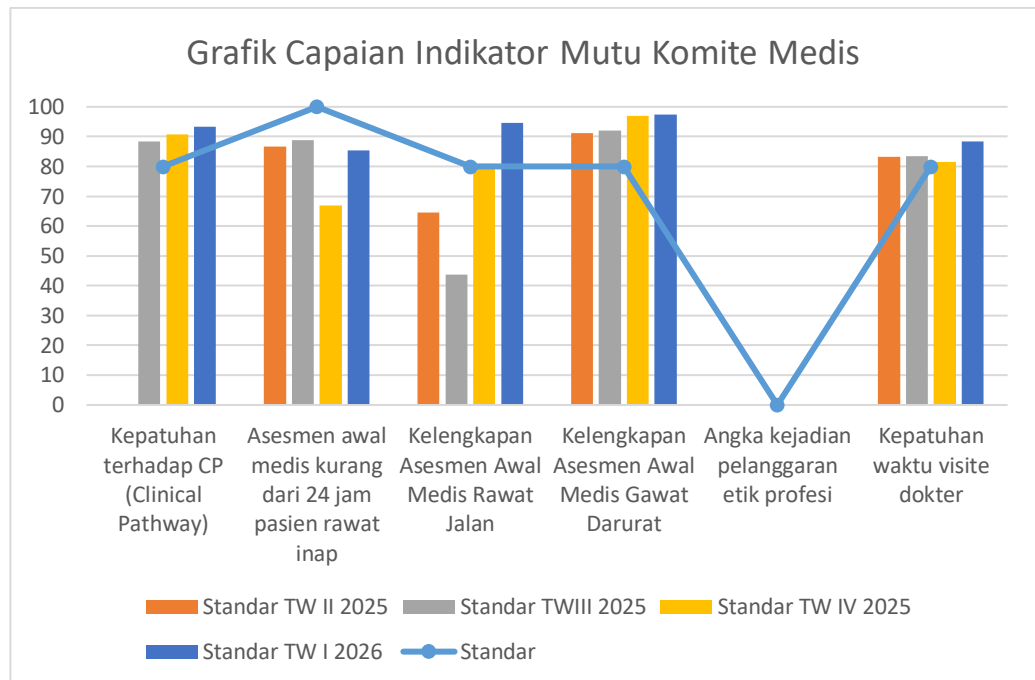
4. Capaian Indikator Mutu Komite Rumah Sakit

4.1 Komite Medis

Tabel 34 capaian Komite Medis (Komed)

No	Indikator	Target/ Standart	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit (IMUT)						
1	Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) pelayanan klinis prioritas	80%	0%	88,46%	90,7%	93,25%
2	Kepatuhan jam visite Dokter spesialis	80%	84,62%	83,49%	81,6%	88,31%
3	Asesmen awal medis ≤ 24 jam pasien rawat inap	100%	81,82%	88,73%	67%	85,38%
4	Kelengkapan Asesmen Awal Medis Rawat Jalan	80%	89,56%	43,66%	80,9%	94,58%
5	Kelengkapan Asesmen Awal Medis Gawat Darurat	80%	57,89%	92,12%	96,9%	97,48%
6	Angka kejadian pelanggaran kode etik profesi	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

1. Kelengkapan assesment awal medis gawat darurat ≤ 24 jam pasien rawat inap pada TW I Tahun 2026 mengalami peningkatan 18,38% dari TW IV 2025, tetapi masih belum memenuhi standart target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan beberapa dokter belum secara konsisten melakukan atau melengkapi asesmen medis sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan peralihan sistem rekam medis dari manual ke Rekam medis elektronik.
2. Tidak ada kejadian pelanggaran kode etik profesi pada TW I 2026.
3. Untuk indikator kepatuhan *clinical pathway* sesuai dengan layanan prioritas, kepatuhan visite dokter, kelengkapan asesmen awal medis rawat jalan dan gawat darurat pada Triwulan I 2026 sudah mengalami peningkatan dan sudah sesuai dengan standart target yang telah ditentukan.

4.2 Komite Etik dan Hukum

Tabel 35 Capaian Indikator Mutu Etik Dan Hukum (KEH)

No	Indikator	Target/Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Jumlah pelanggaran etik	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa :

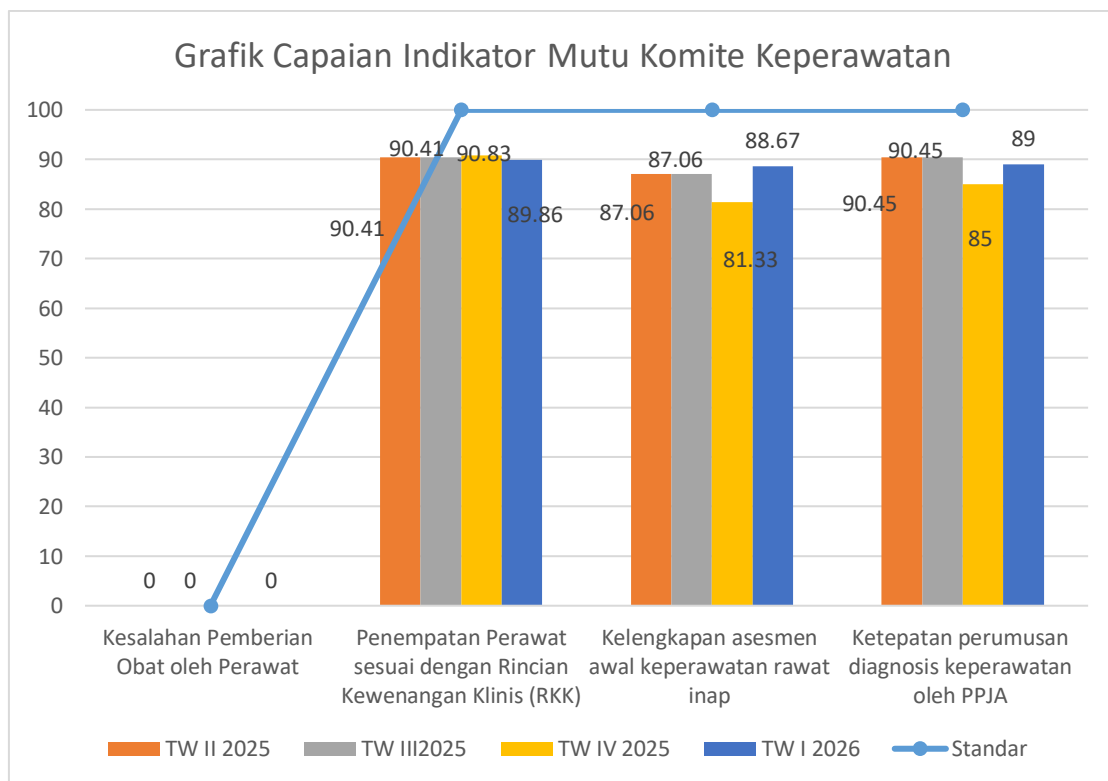
Pada TW I tahun 2026 tidak ada kejadian pelanggaran kode etik di Rumah sakit.

4.3 Komite Keperawatan

Tabel 36 Capaian indikator mutu komite keperawatan

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kesalahan pemberian obat oleh perawat	0%	0%	0%	0%	0%
2	Penempatan perawat sesuai dengan Rincian kewenangan klinis	100%	90,41%	90,76%	90,83%	89,96%
3	Kelengkapan assesment awal keperawatan rawat inap	100%	87,06%	84,71%	81,33%	88,67%
4	Ketepatan perumusan diagnosa keperawatan oleh PPJA	100%	90,45%	88,24%	85%	89%

Sumber Data: SIMRS Khanza



Analisa :

1. Tidak ada kesalahan pemberian obat oleh perawat pada TW I Tahun 2026.

2. Pada indikator mutu penempatan perawat sesuai dengan Rincian kewenangan klinis, pada TW I Tahun 2026 masih belum mencapai standart yang ditentukan, dikarenakan adanya tenaga kesehatan belum sempat melakukan kredensial sesuai dengan RKK karena adanya rotasi yang bersifat insidental.
3. Capaian indikator Kelengkapan assesment awal keperawatan rawat inap pada TW I 2026 mengalami peningkatan 7,34% tetapi belum mencapai standart yang telah ditetapkan 100%, hal ini disebabkan karena faktor adaptasi terhadap Rekam Medis Elektronik (RME) juga berpengaruh. Proses pengisian asesmen awal melalui sistem elektronik belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh perawat, sehingga beberapa kolom terlewat atau tidak terisi, terutama pada item yang memerlukan pengisian manual atau pilihan khusus
4. Pada indikator Ketepatan perumusan diagnosa keperawatan oleh PPJA capaian pada TW I Tahun 2026 mengalami peningkatan 4% dari TW IV Tahun 2025 , hal ini disebabkan karena:
 - a. proses pengkajian awal belum dilakukan secara komprehensif atau hasil pengkajian belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penetapan diagnosis keperawatan
 - b. variasi pemahaman dan kompetensi PPJA dalam menerapkan standar diagnosis keperawatan (SDKI).
 - c. Perubahan dan adaptasi terhadap rekam medis elektronik (RME) juga menjadi faktor pendukung. PPJA masih dalam proses penyesuaian terhadap format dan alur pendokumentasian, sehingga terdapat kecenderungan memilih diagnosis yang tersedia secara default atau yang dianggap paling mendekati, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan keluhan utama pasien.

4.4 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Tabel 37 Capaian indikator mutu Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Ada anggota tim PPI yang terlatih	≥75%	23,5%	58,8%	58,8%	58,8%
2	Tersedia APD disetiap Instalasi	≥60%	100%	100%	100%	100%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAIs (helth care asociated infections) dirumah sakit	≥75%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

Ada anggota tim PPI yang terlatih sampai TW I tahun 2026 masih 58,8% sama dengan TW IV Tahun 2025 belum ada pelatihan PPI dan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu $\geq 75\%$. Hal tersebut telah masuk dalam program kerja komite PPI tahun 2026 untuk pelatihan anggota tim PPI mengingat pelatihan PPI yang relatif jarang dengan biaya yang cukup mahal.

4.5 Komite Profesional Pemberian Asuhan (PPA) lain.

Tabel 38 Capaian Indikator Mutu PPA lain

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Angka kredensial PPA Lain dan Staf Klinis Lainnya	100%	0%	0%	0%	0%
2	Angka kejadian tidak diharapkan yang diakibatkan oleh staf	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa :

Angka kredensial tenaga kesehatan Lain dan Staf Klinis Lainnya 0% Menunjukkan tidak ada proses kredensial pada TW I Tahun 2026 . Dan tidak ada KTD yang melibatkan tenaga kesehatan lain dan staf kesehatan.

4.6 Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

Tabel 39 Capaian indikator mutu Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah sakit (K3RS)

No	Indikator	Target/ Standar	Capaian Triwulan II 2025	Capaian Triwulan III 2025	Capaian Triwulan IV2025	Capaian Triwulan I 2026
Indikator Mutu Unit / Imut Unit						
1	Kecelakaan Akibat Kerja	0%	0,36%	0,09%	0,27%	0,27%
2	Penyakit Akibat Kerja	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data: SIMRS Khanza

Analisa:

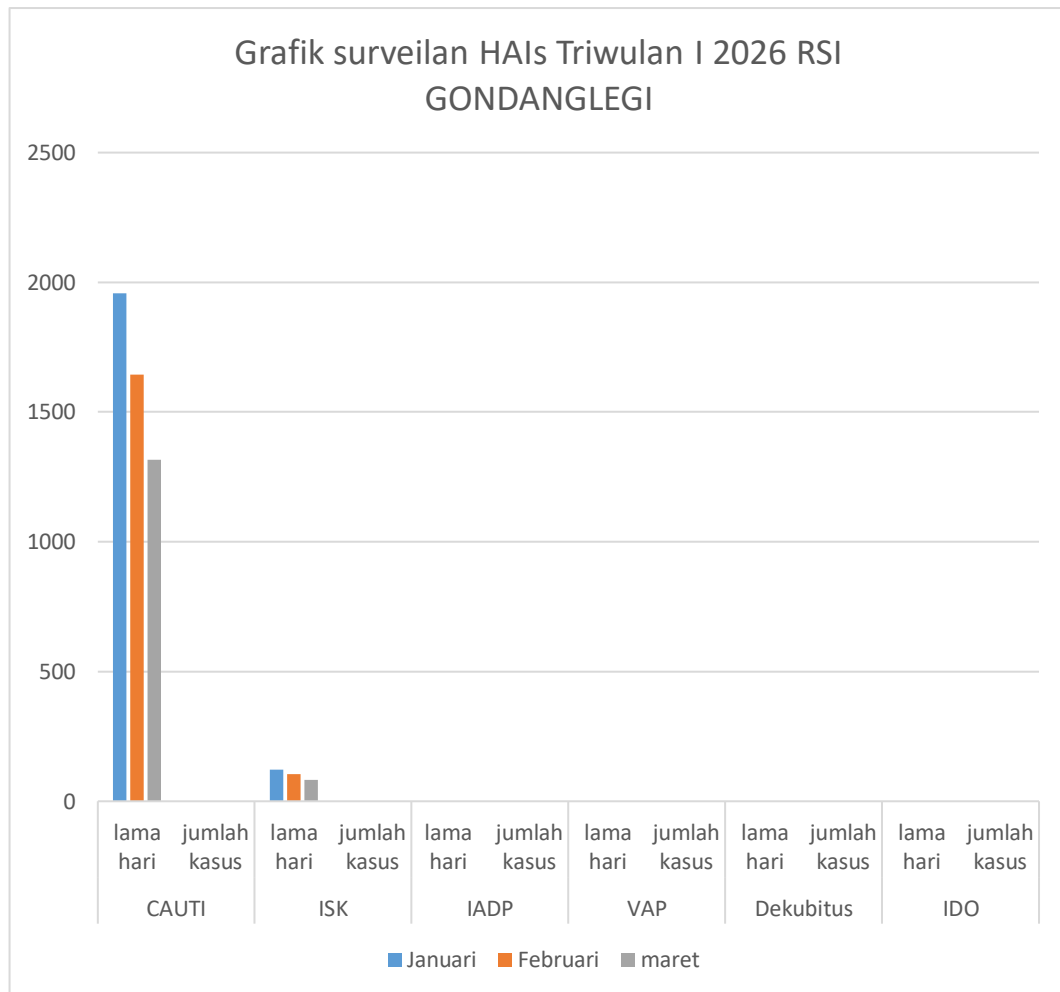
Pada TW I 2026 angka kecelakaan akibat kerja sebesar 0,27% yaitu ada 3 kasus kecelakaan pulang kerja.

5. Monitoring HAIs Rumah Sakit

Tabel 40 Surveilans HAIs Triwulan I Tahun 2026

Bulan	CAUTI		ISK		IADP		VAP		Dekubitus		IDO	
	lama hari	jumlah kasus	lama hari	jumlah kasus	lama hari	jumlah kasus	lama hari	jumlah kasus	lama hari	jumlah kasus	lama hari	jumlah kasus
Januari	1957	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	1645	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	1316	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik Survailen HAIs Triwulan I Tahun 2026



Analisa :

Tidak ada Angka Insiden (AI) untuk semua kategori infeksi pada TW I Tahun 2026.

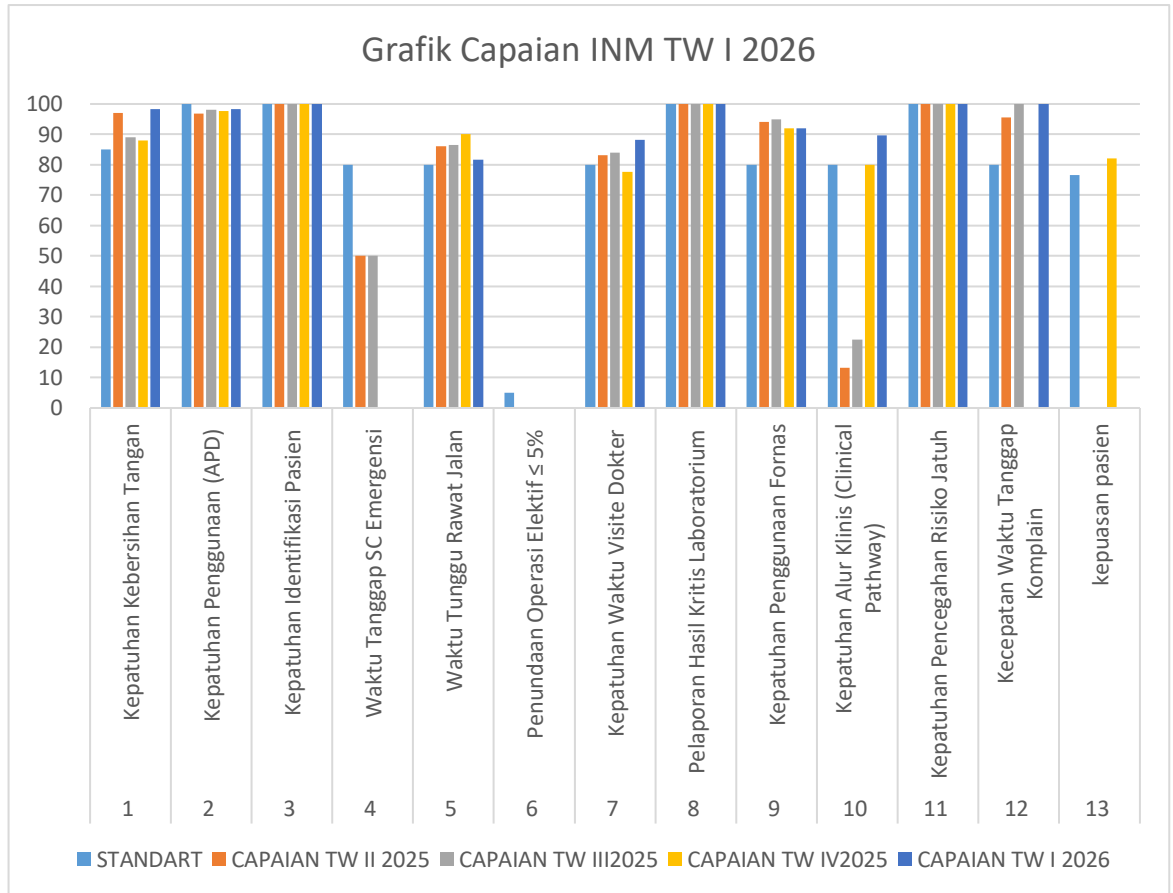
6. Monitoring INM

Tabel 41 Monitoring INM

NO	INDIKATOR MUTU	STANDART	CAPAIAN TW II 2025	CAPAIAN TW III2025	CAPAIAN TW IV2025	CAPAIAN TW I 2026
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	85	97	89	88	98
2	Kepatuhan Penggunaan (APD)	100	97	98	97,7	98,3
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100	100	100	100	100
4	Waktu Tanggap SC Emergensi	80	50	50	-	-
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	80	86	87	90	81,6
6	Penundaan Operasi Elektif $\leq 5\%$	5	0	0	0	0
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	80	83	84	77,6	88,1
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100	100	100	100	100
9	Kepatuhan Penggunaan Fornas	80	94	95	92	92
10	Kepatuhan Alur Klinis (Clinical Pathway)	80	13	22	80	89,6
11	Kepatuhan Pencegahan Risiko Jatuh	100	100	100	100	100
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	80	96	100	0	100
13	Kepuasan pasien	76,6	-	-	82	-

Sumber Data: SIMRS Khanza

Grafik capaian indikator mutu nasional 2026



Analisa :

- Indikator mutu kepatuhan pelindung diri APD mengalami kenaikan 1,4% pada Triwulan I 2026 tetapi masih belum mencapai standart yang telah ditentukan , karena merasa kurang nyaman saat menggunakan APD tertentu sehingga mengganggu saat beraktifitas.
- Pada Indikator kepatuhan hand hygiene mengalami peningkatan 10% dari TW I Tahun 2026 sebesar 1%.
- Waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 8,4%, karena ada dokter spesialis yang terlambat.
- Kepatuhan visite dokter pada Triwulan I Tahun 2026 mengalami kenaikan 10,5% dari Triwulan IV 2026.
- Waktu tanggap operasi sectio secarea emergency pada Triwulan I Tahun 2026 0%, karena tidak ada kasus Sectio Secarea Emergency pada TW I Tahun 2026.
- Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) pada TW I Tahun 2026 mengalami peningkatan 8% dari TW IV Tahun 2026, dan sudah memenuhi standart yang telah ditentukan.

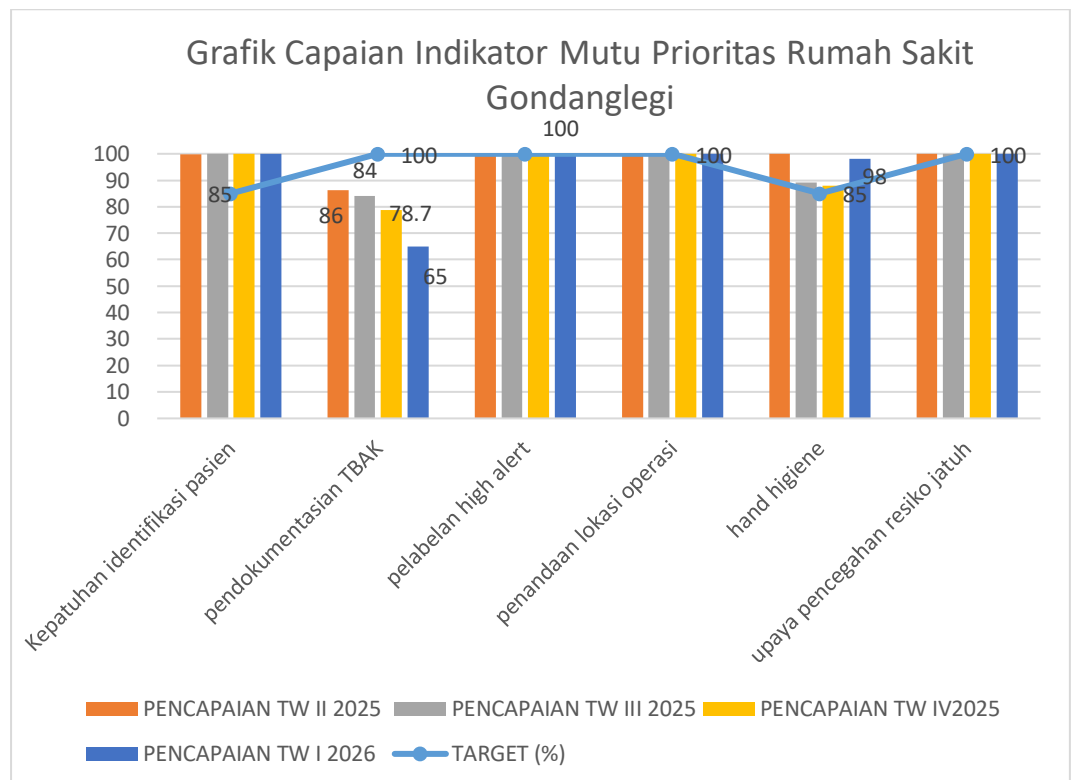
7. Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Tabel 43 Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

NO	INDIKATOR	TARGET (%)	PENCAPAIAN TW II 2025	PENCAPAIAN TW III 2025	PENCAPAIAN TW IV2025	PENCAPAIAN TW I 2026
1	Kepatuhan identifikasi pasien	85	100	100	100	100
2	pendokumentasian TBAK	100	86	84	78,7	65
3	pelabelan <i>high alert</i>	100	100	100	100	100
4	penandaan lokasi operasi	100	100	100	100	100
5	hand hygiene	85	100	89	88	98
6	upaya pencegahan resiko jatuh	100	100	100	100	100

Sumber Data: SIMRS Khanza

Grafik indikator mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 2026



Analisa:

- a. Kelengkapan dokumentasi TBAK 65 % pada Triwulan I tahun 2026 hal ini mengalami penurunan 13,7% dari triwulan IV 2025 karena

DPJP melakukan verifikasi >24 jam, penyebabnya antarlain proses transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medik elektronik, sehingga dokter masih berlangsung, sehingga dokter belum sepenuhnya familiar dengan alur dan fitur RME dan keterbatasan sosialisasi penggunaan RME kepada dokter DPJP, serta belum ada pengingat otomatis (allert sistem) pada sistem RME untuk kelengkapan isian RME dan verifikasi proses transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medik elektronik yang masih dalam tahap penyesuaian.

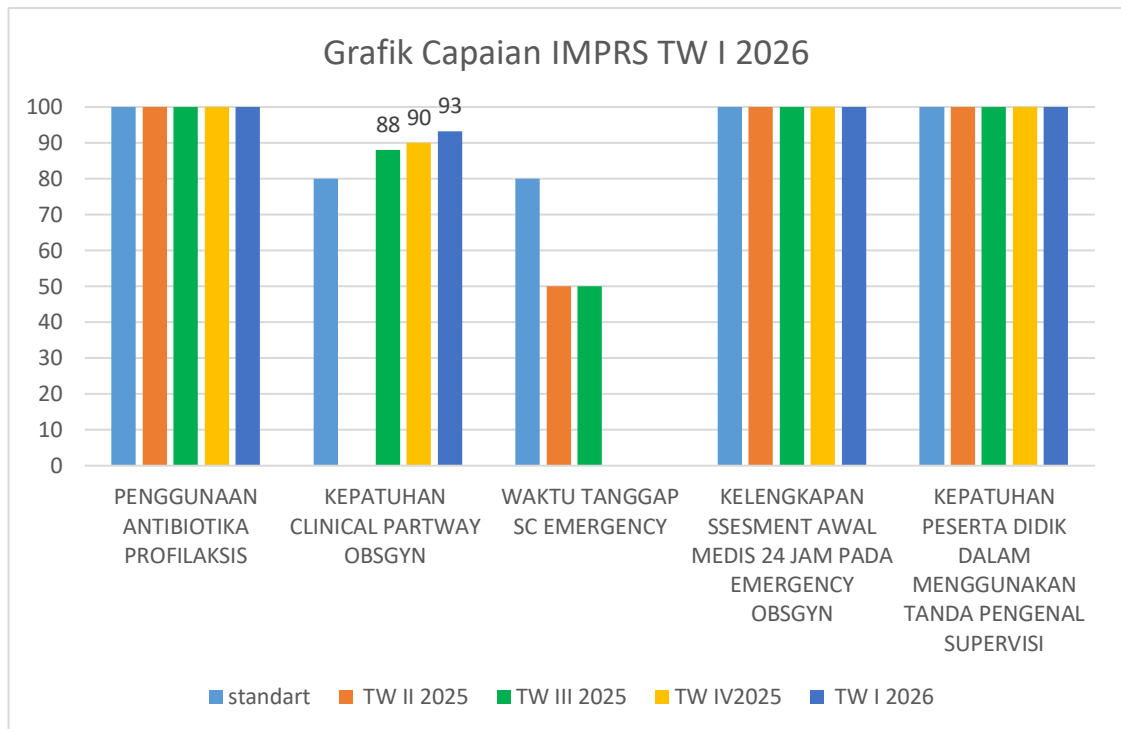
- b. Kepatuhan hand hygiene pada Triwulan I 2026 mengalami peningkatan 10% dari Triwulan IV 2025.

8. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

**Tabel 42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Triwulan I 2025 RSI
Gondanglegi**

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET (%)	CAPAIAN TW II 2025 (%)	CAPAIAN TW III 2025(%)	CAPAIAN TW IV 2025 (%)	CAPAIAN TW I 2026(%)
1	Penggunaan Antibiotik Profilaksis pada kasus Obgyn	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan Clinical Pathway Obsgyn	80	0	88	90	93,25
3	Waktu tanggap SC emergency krang dari 30 menit	80	50	50	-	-
4	Kelengkapan assesment awal pasien Obsgyn	100	100	100	100	100
5	Kepatuhan peserta didik dalam menggunakan tanda pengenal supervisi	100	100	100	100	100

Grafik Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) Triwulan I Tahun 2026



Analisa:

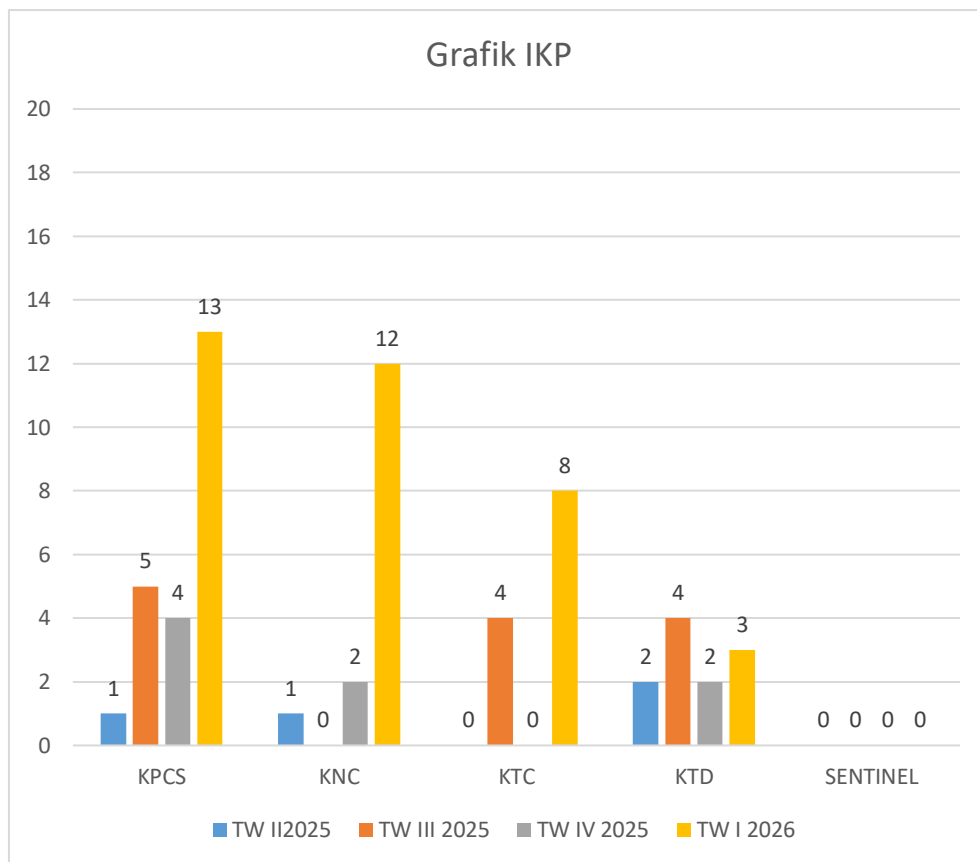
- Indikator mutu prioritas Rumah Sakit pada TW I Tahun 2026 seluruhnya sudah mencapai standart target yang telah ditentukan.
- Waktu tanggap operasi sectio secarea emergency pada TW I Tahun 2026 0% karena tidak ada kasus sectio secarea emergency.
- Pada indikator kepatuhan peserta didik dalam menggunakan tanda pengenal supervisi pada TW I 2026 100%.

9. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Tabel 44 Insiden Keselamatan Pasien TW I Tahun 2026

IKP	TW II2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026
KPCS	1	5	4	4
KNC	1	0	2	11
KTC	0	4	0	12
KTD	2	4	2	3
SENTINEL	0	0	0	0

Grafik Insiden Keselamatan Pasien (IKP) TW I 2026



a. Analisa:

- a) Selama Bulan Januari - Maret tahun 2026 terdapat 36 laporan IKP yang diterima oleh Sub Kom KPRS.
- b) Secara umum, insiden yang dilaporkan didominasi oleh kategori KPC dan KNC, disusul KTC, serta sebagian kecil KTD. Dominasi KPC dan KNC menunjukkan bahwa sebagian besar insiden masih berada pada tahap potensi atau terdeteksi sebelum menimbulkan dampak berat pada pasien. Hal ini mencerminkan bahwa sistem deteksi risiko telah berjalan, namun masih terdapat kelemahan pada proses pelayanan yang meliputi: ketepatan identifikasi pasien, *medical error*, ketepatan prosedur baik pelayanan maupun administrasi, kurang efektifnya komunikasi/ handover antar unit serta ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.
- c) Dilihat dari sisi profil resiko, KPCS & KNC mendominasi: Ini merupakan "*Early Warning*". Banyaknya Kondisi Potensial Cedera (KPCS) menandakan lingkungan kerja atau sistem memiliki banyak celah yang harus segera diperbaiki sebelum menjadi KTD dimana tim Fasilitas dan

Keselamatan (MFK) harus melakukan *rounds* untuk memperbaiki kondisi fisik atau sistem yang berpotensi menyebabkan cedera.

- d) Berdasarkan rekapitulasi laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) periode Januari–Maret 2026, tercatat 36 kejadian insiden yang terdiri dari berbagai kategori. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa *medication error* merupakan kategori insiden terbanyak, masing-masing sebanyak 7 kejadian (22,5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan obat masih memerlukan penguatan pada tahapan prescribing, dispensing, maupun administrasi obat.
- e) Kategori insiden terbanyak berikutnya adalah kesalahan identifikasi pasien 5 (13,8%) dan kesalahan pemeriksaan penunjang/laboratorium 6 kejadian (19,3%). Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap prosedur identifikasi pasien dan proses verifikasi hasil.
- f) Selain itu 3 kejadian (9,6%) pasien jatuh atau cedera pasien, dan 3 kejadian (9,6%) keterlambatan pelayanan, 8 (22,%) kejadian berhubungan sarana dan prasarana. Terdapat pula 2 kejadian (5,5%) yang berkaitan dengan dokumentasi atau rekam medis, 1 kejadian (2,7%) terkait risiko infeksi (PPI), serta 1 kejadian (2,7%) yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana (*Code Green*).
- g) Dari 36 kasus insiden, 14 kejadian (38,9%) dilaporkan tepat waktu, sedangkan 22 kejadian (61,1%) tidak dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan pelaporan insiden rumah sakit, termasuk 4 dari 7 kasus insiden *medication error* dilaporkan tidak tepat waktu. Persentase pelaporan IKP yang tidak tepat waktu masih cukup tinggi menunjukkan bahwa kepatuhan petugas terhadap prosedur pelaporan IKP belum optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat proses investigasi, analisis akar penyebab, serta pelaksanaan tindak lanjut perbaikan secara cepat sehingga peluang terulangnya insiden serupa menjadi lebih besar.
- h) Peningkatan pelaporan IKP pada Triwulan I 2026 tidak selalu menunjukkan peningkatan kejadian yang memburuk, tetapi justru dapat mencerminkan meningkatnya budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) di rumah sakit. Semakin banyak insiden yang dilaporkan, terutama kategori KNC dan KTC, menunjukkan bahwa petugas semakin terbuka dalam melaporkan kejadian, lebih peka terhadap risiko, serta tidak menutup-nutupi insiden. Hal ini merupakan indikator positif bahwa sistem pelaporan berjalan dan tenaga kesehatan mulai memahami pentingnya transparansi serta pembelajaran dari setiap kejadian.

- i) Kejadian sentinel pada Triwulan I 2026 adalah 0 dan itu menjadi prioritas utama yang harus dipertahankan.

b. Grading.

Seluruh laporan IKP yang telah masuk ke Sub Kom KPRS dalam kelompok KTC, KNC, KPCS dan KTD telah dilakukan penilaian risiko (grading) dengan kategori hijau dan biru sesuai dengan sistem manajemen risiko rumah sakit. Insiden dengan grading hijau dan biru termasuk risiko rendah hingga sedang, sehingga penanganannya cukup melalui investigasi sederhana (*simple investigation*) tanpa memerlukan analisa akar masalah (RCA) yang mendalam. Tindak lanjut IKP sesuai dengan grading resiko masing-masing, dengan investigasi sederhana di unit masing-masing.

c. Evaluasi dan Rekomendasi dan Tindak lanjut.

Secara keseluruhan, mutu keselamatan pasien pada periode ini menunjukkan bahwa masalah utama berada pada ketepatan identifikasi pasien, ketepatan obat, ketepatan prosedur, komunikasi antar petugas, serta kesiapan sarana-prasarana. Agar lebih efektif, perlu perbaikan yang bersifat sistemik, konsisten, dan dipantau melalui audit kepatuhan serta evaluasi ulang kejadian berulang, meliputi:

- a) Penguatan kepatuhan identifikasi pasien pada seluruh unit pelayanan (melalui sosialisasi SPO, *review* SPO).
- b) Penguatan sistem handover antar unit (peningkatan koordinasi antar unit).
- c) Audit rutin terhadap proses pemberian obat, etiket obat, dan kesesuaian advis DPJP.
- d) Evaluasi dan perbaikan sarana-prasarana yang berisiko terhadap keselamatan pasien.
- e) Analisa akar masalah (Root Cause Analysis) untuk insiden berulang dan insiden KTD.
- f) Monitoring tindak lanjut insiden melalui mekanisme evaluasi berkala oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.

10. Hasil Validasi IMPRS dan INM

Tabel 45 Validasi data IMPRS dan INM

NO	Indikator	Target/ standart	hasil Pengumpulan data TW I 2026	Hasil pengumpulan Data sampling validasi	Perbandingan data pengumpul Dengan data validasi	Keterangan (valid jika nilai perbandingan ≥90%)
A. INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT (IMPRS)						
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)						
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	valid
2	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	90%	65%	63%	96,9%	valid
3	Obat <i>High Alert</i> yang terlabel	100%	100%	100%	100%	valid
4	Pelaksanaan <i>Surgical Safety Checklist</i> (SSC) pasien Obgyn	100%	100%	100%	100%	valid
5	Kepatuhan Kebersihan tangan (<i>hand hygiene</i>)	≥85 %	98%	100%	100%	valid
6	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	valid
prioritas Indikator Pelayanan Klinis						
7	Penggunaan antibiotika profilaksis pada pada pasien bedah Obgyn	80%	100%	100%	100%	valid
Indikator sesuai tujuan strategi Rumah sakit <i>Key Performance indicator (KPI)</i>						
8	Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i> (CP) layanan Obgyn	≥80%	93,25%	93,58%	100%	valid
Indikator terkait perbaikan sistem						
9	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥80%	0%	0%	100%	valid
Indikator terkait manajemen risiko						

NO	Indikator	Target/ standart	hasil Pengumpulan data TW I 2026	Hasil pengumpulan Data sampling validasi	Perbandingan data pengumpul Dengan data validasi	Keterangan (valid jika nilai perbandingan ≥90%)
10	Kelengkapan asesmen awal medis 24 jam pada pasien emergensi obgyn	100%	100%	100%	100%	valid
NO	INDIKATOR	Standart / Target	Hasil Pengumpulan data TW III 2025	Hasil pengumpulan Data sampling validasi	Perbandingan data pengumpul Dengan data validasi	Keterangan (valid jika nilai perbandingan ≤5%)
B.	INDIKATOR MUTU NASIONAL					
	1. Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98%	100%	100%	valid
	2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	98,3%	100%	100%	valid
	3. Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	valid
	4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	0%	0%	100%	valid
	5. Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	81,6%	90%	100%	valid
	6. Penundaan Operasi Elektif ≤ 5%	≤ 5%	0%	0%	100%	valid
	7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	88,1%	82%	93%	valid
	8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	100%	100%	100%	valid
	9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	92%	92%	100%	valid

NO	Indikator	Target/ standart	hasil Pengumpulan data TW I 2026	Hasil pengumpulan Data sampling validasi	Perbandingan data pengumpul Dengan data validasi	Keterangan (valid jika nilai perbandingan ≥90%)
	10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	89,6%	90%	99,5%	valid
	11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	valid
	12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	100%	100%	valid
	13. Kepuasan Pasien	≥ 76,61	-	-	-	-

Analisa:

Seluruh indikator mutu pada TW I 2026 valid.

D. EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan PMKP Triwulan I Tahun 2026, kegiatan monitoring dan supervisi PMKP telah terlaksana sebesar sesuai dengan jadwal dan rencana yang ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dan supervisi telah mencakup sebagian besar unit pelayanan dan indikator mutu yang diprogramkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator mutu yang belum mencapai standar sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan pada periode berikutnya untuk memastikan seluruh program PMKP dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Meningkatnya jumlah laporan IKP dapat diinterpretasikan sebagai perbaikan dalam sistem pelaporan dan penguatan budaya keselamatan pasien, selama diikuti dengan analisis, tindak lanjut, serta pencegahan kejadian berulang. Namun demikian, peningkatan pelaporan tetap harus diiringi dengan penurunan insiden berulang dan penurunan kejadian berisiko tinggi (KPC dan KTD) sebagai indikator bahwa perbaikan sistem telah efektif.

E. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Beberapa permasalahan dan hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien adalah: ketidak tepatan waktu penginputan data indikator mutu ke dalam SIMRS KHANZA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

F. RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Berikut Rencana Tindak Lanjut (RTL) Monitoring & Supervisi PMKP TW II 2026 yang difokuskan pada indikator mutu yang belum mencapai standar pada TW I 2026 sebagai berikut:

Tabel 46 Rencana Tindak Lanjut

NO	INDIKATOR MUTU	AKAR PENYEBAB MASALAH	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	PIC	TIMELINE
1	Kelengkapan Dokumentasi TBAK	Verifikasi DPJP >24 jam, adaptasi RME belum optimal	Notifikasi TBAK	Kabid Keperawatan, DPJP, IT, TIM SIMRS	April- Mei 2026
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	Jadwal visite tidak konsisten	Reminder via WA	Kabid Medik	April-Mei 2026
3	Kepatuhan Penggunaan APD	Ketidaknyamanan APD	Monitoring kepatuhan penggunaan APD	PPI, K3RS	April- Mei 2026
4	Kematian Pasien ≤ 24 Jam di IGD	Sebagian besar pasien datang dalam kondisi kegawatan tinggi, DOA, keterlambatan rujukan	Penguatan triage, Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan pengirim untuk stabilisasi pasien sebelum dirujuk.	KUPP IGD	April- Juni
5	Penegakan diagnosa TB (mikroskopis) di rawat jalan	Menunggu hasil pemeriksaan mikroskopis 5-7 hari (karena pemeriksaan harus dikirim).	1. Digitalisasi hasil pelaporan TCM/akses hasil pemeriksaan via portal online/WhatsApp dari lab rujukan agar dokter bisa langsung menegakkan diagnosa tanpa menunggu fisik kertas. 2. Usul penambahan tenaga kurir tetap pengantar sampel ke laboratorium rujukan.	Pelayanan Medis, KUP IPLT IT, Tim TB	April- Juni 2026

6	Penulisan Resep Sesuai formularium	Dokter melihat kebutuhan obat berdasarkan kondisi klinis pasien sehingga terkadang mengabaikan formularium nasional	Evaluasi daftar obat Fornas internal RS, dengan mengusulkan penambahan obat ke formularium RS melalui KFT apabila sering digunakan dan terbukti dibutuhkan secara klinis.	Kepala IFRS	April- Juni 2026
7	Indikator ketepatan penempatan pasien isolasi TW I Tahun 2026 capaiannya 69,98% kurang dari standart 80%	Kendala situasional, seperti kondisi pasien yang tidak kooperatif jadi memerlukan ruang kohorting,keterbatasan kapasitas ruang rawat inap.	Optimalisasi manajemen kapasitas ruang isolasi, melalui pemetaan harian ketersediaan tempat tidur (bed management) dan prioritas penempatan pasien infeksius, Penguatan koordinasi lintas unit (IGD, IRNA, PPI, MPP) untuk keputusan cepat dan tepat terkait penempatan pasien isolasi/kohorting.	Kepala Irna, MPP,PPI	April-Mei 2026
8	Ketepatan penyediaan rekam medis rawat jalan (BPJS) belum memenuhi standart 70%	Berkas diterima > 15 menit	Optimalisasi Pendaftaran Online Mendorong pasien poli sore menggunakan aplikasi pendaftaran	Kepala IRM, kepala IRJ	April- Mei 2026

			online agar SEP bisa diproses mendekati jam praktek dokter		
9	Capaian waktu tunggu hasil thorax < 3 jam 28,76%	Keterbatasan jam pelayanan dokter spesialis radiologi	Penambahan dokter spesialis radiologi maka dilakukan evaluasi capaian dalam 3 bulan kedepan.	Kepala Radiologi, Komite Mutu, Kepala bidang pelayanan, Kepala bidang penunjang	April- Mei 2026
10	Capaian Waktu penyelesaian radiologi reguler ≤ 24 jam turun 7,05%	Keterlambatan pembacaan dan pelaporan hasil	Usul penggunaan Tele-Radiologi sebagai solusi alternatif untuk pemeriksaan di luar jam kerja. Evaluasi dengan adanya penambahan dokter spesialis radiologi	Kepala radiologi, Komite Mutu, Kabid penunjang	April- Mei 2026
11	Kepatuhan serah terima linen kotor & bersih belum mencapai 100%	Petugas ruangan sibuk pelayanan pasien sehingga serah terima terlewat	Penetapan waktu khusus serah terima linen saat perawat tidak sibuk.	Kepala laundry, Kepala irna	April- Mei 2026

12	Masih terjadi salah penempatan linen	Penataan linen bertumpuk di troli	Penataan ulang troli, pemisahan & pelabelan linen per ruangan,	Kepala laundry	April- Mei 2026
13	Angka kegagalan stelisisasi masih tinggi	Autoclave manual tanpa kontrol otomatis menyebabkan pengeringan tidak optimal dan segel pouches terbuka	1. Kajian dan perencanaan pengadaan autoclave dengan sistem otomatis, sebagai solusi jangka menengah–panjang untuk menurunkan risiko kegagalan sterilisasi. 2. Optimalisasi penggunaan autoclave dengan pengering. 3. Pengaturan kapasitas agar tidak terlalu penuh pada autoclave tanpa pengering otomatis.	Kepala ISS, KUPP ISS	6 bulan
14	capaian Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat menurun 2,3%	Jumlah teknisi terbatas	Klasifikasi prioritas kerusakan, optimalisasi pelaporan, pembagian tugas teknisi	Kepala IPS, KUPP ISS	April- Mei 2026
15	Capaian Ketepatan waktu pemeliharaan alat belum mencapai standart 100%(capaian 80,7%)	Fokus pada corrective maintenance	Penjadwalan preventive maintenance	Kepala ips	April- Mei 2026
16	Penempatan perawat sesuai RKK belum mencapai standart	Rotasi insidental menyebabkan kredensial belum lengkap	Mengintegrasikan status RKK sebagai dasar penempatan perawat di unit kerja,	Komite Keperawatan	April- Mei 2026
17	Assesment rawat inap belum lengkap	Adaptasi RME	Peningkatan ketelitian dalam pengisian RME untuk mencegah kolom penting terlewat.	Kepala instalasi, Komite Keperawatan,	April- Mei 2026

18	Capaian Ketepatan diagnosis keperawatan PPJA peningkatan 4%,tetapi belum mencapai standart yang telah ditetapkan.	Pengkajian belum optimal, adaptasi RME, variasi kompetensi	Penguatan proses pengkajian keperawatan komprehensif sebagai dasar penetapan diagnosis, Menyusun daftar diagnosis keperawatan di RME yang sesuai dengan keluhan utama dan hasil pengkajian,	Komite Keperawatan	April- Mei 2026
19	Persentase anggota Tim PPI terlatih belum memenuhi standart	Biaya pelatihan tinggi	Penyelenggaraan pelatihan PPI internal (in-house training) sebagai alternatif pelatihan eksternal untuk menekan biaya, Pemanfaatan metode blended learning, seperti e-learning, webinar, dan belajar mandiri yang diakui sebagai jam pelatihan PPI, Penjadwalan bertahap pelatihan PPI dengan prioritas anggota tim yang belum pernah mengikuti pelatihan, Kerja sama dengan jejaring PPI (RS rujukan, Dinkes, organisasi profesi) untuk mendapatkan pelatihan bersertifikat dengan biaya lebih terjangkau.	Komite PPI, Instalasi Diklit	April- Mei 2026
20	Penanganan BBLR 1500–2500 gr belum 100%	Rujuk BBLR yang membutuhkan CPAP	Penguatan kriteria rujukan BBLR sesuai kemampuan fasilitas RS, Peningkatan kompetensi tenaga	Tim PONEK	6 bulan

			kesehatan dalam stabilisasi awal BBLR sebelum rujukan, Kajian kebutuhan sarana pendukung perawatan BBLR sebagai perencanaan jangka menengah		
21	Tren SC masih tinggi	Indikasi medis dan rujukan jejaring	Penguatan edukasi dan konseling persalinan normal pada ibu hamil sejak ANC	Komite medik, Tim PONEK	April- Mei 2026
22	Pemberian ASI eksklusif belum 100%	Karena rujukan BBLR dan persepsi ibu tentang produksi ASI kurang.	Penguatan edukasi ASI eksklusif sejak ANC dan masa nifas, peningkatan peran konselor laktasi dan pendampingan ibu pasca persalinan, penerapan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sesuai kondisi klinis, pembatasan pemberian susu formula sesuai indikasi medis.	Tim PONEK, Bidan, perawat	April- Mei 2026
23	Manajemen laktasi 24 jam belum 100%	BBLR yang dirujuk	Penguatan manajemen laktasi pada ibu bayi BBLR sebelum dan sesudah rujukan, edukasi teknik memerah ASI bagi ibu dengan bayi dirujuk.	Bidan, perawat	April- Mei 2026

24	Komite K3	3 kasus angka kecelakaan saat pulang kerja	Edukasi <i>safety riding</i> , sosialisasi APD berkendara	Komite K3RS	April- Mei 2026
----	-----------	--	---	-------------	-----------------

Rencana Tindaklanjuti TW IV 2025 Terhadap Dampak Perbaikan Primer dan Dampak Perbaikan Sekunder TW I 2026

No	Indikator Mutu	RTL/Perbaikan yang Dilakukan	Dampak Primer	Dampak Sekunder
1	Kepatuhan waktu visite dokter meningkat	Reminder melalui WA	Peningkatan ketepatan waktu dokter melakukan visite sehingga kebutuhan asesmen dan terapi pasien lebih cepat terpenuhi	Meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta mengurangi keterlambatan pelayanan
2	Ketidakersediaan obat dalam resep rawat jalan	1. Koordinasi intensif dengan bidang keuangan untuk menekan keterlambatan pembayaran distributor. 2. Melakukan evaluasi penyebab kekosongan stok. 3. Meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan obat berdasarkan data konsumsi dan pola penyakit. 4. Menetapkan buffer stock dan safety stock untuk obat prioritas/fast moving. 5. Mempercepat proses pengadaan dengan pemesanan sebelum	Mempercepat proses pelayanan dan penyiapan obat di Instalasi Farmasi.	1. Meningkatnya kepuasan pasien karena pelayanan farmasi menjadi lebih cepat dan obat dapat diterima sesuai kebutuhan. 2. Meningkatkan citra rumah sakit melalui pelayanan farmasi yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

		mencapai batas minimum stok (Reorder Point). 6. Menjalin kerja sama dengan lebih dari satu distributor untuk obat kritis/prioritas. 7. Melakukan evaluasi kinerja distributor terkait ketepatan waktu pengiriman dan ketepatan faktur dan sp.		
3	Kepatuhan penggunaan FORNAS dan penulisan resep sesuai formularium meningkat	Evaluasi daftar obat FORNAS internal dan usulan penambahan obat melalui KFT	Kesesuaian pemberian obat dengan standar formularium meningkat	Pengendalian biaya obat, mengurangi variasi penggunaan obat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan farmasi
4	Ketepatan penempatan pasien isolasi meningkat	Optimalisasi bed management dan koordinasi IGD, IRNA, PPI, MPP	Pasien infeksius lebih cepat ditempatkan sesuai kebutuhan isolasi	Mengurangi risiko transmisi infeksi, meningkatkan keselamatan pasien dan pengendalian PPI
5	Waktu penyelesaian radiologi reguler ≤ 24 jam meningkat	Usulan penggunaan tele-radiologi di luar jam kerja, penambahan dokter spesialis radiologi	Mempercepat proses pembacaan hasil radiologi	Mempercepat diagnosis dan keputusan terapi pasien serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan
6	Tidak ada penolakan hasil radiograf oleh dokter radiologi	Pelaksanaan quality control hasil radiograf sebelum interpretasi	Kualitas hasil radiograf lebih baik dan sesuai kebutuhan diagnostik	Mengurangi pengulangan pemeriksaan, efisiensi penggunaan alat dan mengurangi paparan radiasi pasien

7	Kepatuhan serah terima linen kotor dan bersih meningkat	Penetapan waktu khusus serah terima linen	Proses distribusi linen menjadi lebih tertib dan sesuai jadwal	Mendukung pencegahan infeksi, meningkatkan kenyamanan pasien, dan efisiensi kerja petugas
8	Ketepatan waktu pemeliharaan alat meningkat	Penjadwalan preventive maintenance dan alokasi waktu khusus	Pemeliharaan alat terlaksana sesuai jadwal	1. Mengurangi risiko kerusakan alat saat pelayanan dan meningkatkan keandalan sarana medis. 2. Mengurangi biaya perbaikan darurat 3. Memperpanjang usia pakai alat kesehatan, 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 5. Meminimalkan penundaan pelayanan akibat alat yang tidak berfungsi.
9	Kepatuhan asesmen rawat inap 24 jam meningkat	Optimalisasi fitur RME penambahan notifikasi, reminder kepada DPJP	Kelengkapan asesment pasien meningkat sesuai standar waktu	Mendukung aspek legal rekam medis, mempercepat klaim BPJS dan Asuransi
10	Angka kematian pasien IGD turun	Koordinasi dengan pengirim rujukan untuk stabilisasi pasien pra rujuk	Identifikasi kegawatan dan penanganan pasien lebih cepat	Meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.
11	Kegagalan pemasangan infus anak turun/tidak ada kejadian	Pemilihan ukuran IV catheter sesuai kondisi vena, supervisi petugas kompeten, eskalasi kasus sulit	Keberhasilan pemasangan akses intravena meningkat	Mengurangi nyeri dan trauma pasien anak, mempercepat pemberian terapi, meningkatkan kepuasan keluarga pasien, mengurangi biaya pemasangan infus.
12	Kepatuhan terhadap <i>Clinical Pathway</i> meningkat	Peningkatan implementasi <i>Clinical Pathway</i> kepada DPJP	Pelayanan pasien lebih sesuai standar klinis yang telah ditetapkan	Mengurangi variasi pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan dan

				efisiensi penggunaan sumber daya, memperpendek LOS
13	Kejadian pulang atas permintaan sendiri menurun	Edukasi pasien dan keluarga tentang risiko pulang tanpa persetujuan dokter	Pasien dan keluarga lebih memahami risiko keputusan pulang	Meningkatkan kepuasan pasien dan kepercayaan terhadap masyarakat terhadap RS
14	Rujukan yang berkompeten meningkat	Evaluasi dan peningkatan koordinasi proses rujukan	Meningkatnya kepatuhan petugas terhadap regulasi pelayanan rujukan	1. Meningkatkan keselamatan pasien selama proses rujukan. 2. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RS.
15	Kepatuhan penggunaan antibiotik profilaksis mencapai 100%	Sosialisasi kepatuhan penggunaan antibiotik profilaksis Obsgyn	Pemberian antibiotik profilaksis sesuai indikasi dan waktu yang ditentukan	Menurunkan risiko infeksi luka operasi, mencegah resistensi antibiotik, dan meningkatkan mutu pelayanan bedah

TABEL PERBAIKAN INDIKATOR MUTU DENGAN METODA PDSA

Siklus PDSA (Plan–Do–Study–Act) pada perbaikan TW I 2026 dilakukan karena hasil monitoring indikator menunjukkan adanya peluang perbaikan (improvement opportunity). PDSA diprioritaskan pada indikator yang memenuhi satu atau lebih kriteria, yaitu:

1. Capaian indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan selama beberapa periode.
2. Terjadi trend penurunan capaian dibandingkan periode sebelumnya.
3. Indikator memiliki dampak yang tinggi terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
4. Indikator merupakan indikator prioritas rumah sakit yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen.

Melalui siklus PDSA, rumah sakit dapat menguji intervensi perbaikan secara sistematis, mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan data, serta melakukan standardisasi apabila perubahan terbukti meningkatkan mutu pelayanan.

No	Masalah/Indikator	PLAN (Perencanaan)	DO (Pelaksanaan)	STUDY (Evaluasi)	ACT (Tindak Lanjut)
1	<i>Medication Error</i> (IKP terbanyak selama Triwulan I)	Mengidentifikasi jenis medication error, melakukan RCA, mengevaluasi SPO dispensing dan pemberian obat, serta meningkatkan kepatuhan prinsip 6 benar obat.	Sosialisasi 6 benar pemberian obat, refresh High Alert & LASA, supervisi IFRS, double check obat, edukasi petugas.	Monitoring jumlah medication error setiap bulan dan kepatuhan pemberian obat dan pelabelan High Alert.	Revisi SPO bila diperlukan, implementasi sistem double verification, monitoring efektivitas perbaikan secara berkala.
2	Kelengkapan Dokumentasi TBAK belum mencapai standar pada beberapa unit	Mengidentifikasi penyebab ketidaklengkapan dokumentasi akibat transisi RME, dan belum adanya sistem reminder.	Pendampingan DPJP dalam penggunaan RME, checklist verifikasi TBAK, koordinasi dengan IT untuk penambahan notifikasi.	monitoring kelengkapan TBAK setiap dan evaluasi per unit.	Optimalisasi fitur reminder RME dengan penambahan notifikasi

3	Waktu tunggu rawat jalan mengalami penurunan capaian	Melakukan analisis penyebab peningkatan waktu tunggu rawat jalan dan mengevaluasi alur pelayanan.	KIE pasien bahwa jam kedatangan untuk menyesuaikan jadwal pelayanan	Monitoring waktu tunggu setiap poli setiap bulan.	Perbaikan alur pelayanan dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan waktu tunggu.
4	Angka kegagalan sterilisasi masih tinggi karena penggunaan autoclave manual tanpa fitur pengering otomatis sehingga proses pengeringan tidak optimal,	1. Mengoptimalkan penggunaan autoclave yang memiliki fitur pengering otomatis untuk proses sterilisasi. 2. Menetapkan pengaturan kapasitas muatan pada autoclave tanpa pengering otomatis agar tidak diisi penuh sehingga sirkulasi uap dan proses pengeringan lebih optimal. 3. Serta melakukan sosialisasi ulang kepada petugas CSSD mengenai teknik	1. Mengimplementasikan penggunaan autoclave dengan pengering otomatis sebagai prioritas. 2. Untuk autoclave manual tanpa pengering otomatis diterapkan pembatasan kapasitas muatan sesuai ketentuan serta penataan instrumen yang tidak terlalu penuh. 3. Dilakukan sosialisasi kepada seluruh petugas CSSD mengenai prosedur baru.	1. Membandingkan angka kegagalan sterilisasi sebelum dan sesudah intervensi.	1. Menetapkan penggunaan autoclave dengan pengering otomatis sebagai standar apabila tersedia. 2. Pengaturan kapasitas muatan pada autoclave tanpa pengering otomatis dijadikan SPO tetap jika diperlukan. 3. Monitoring indikator kegagalan sterilisasi dilakukan secara berkala setiap bulan, disertai audit kepatuhan petugas dan evaluasi berkala terhadap kondisi autoclave.

		penyusunan beban sterilisasi sesuai SOP.			4. Apabila angka kegagalan masih belum memenuhi target, dilakukan analisis lanjutan terhadap faktor mesin, metode, material, maupun kompetensi petugas serta penyusunan rencana perbaikan berikutnya.
5	Penegakan diagnosa TB (mikroskopis) di rawat jalan 0%	1. Pengadaan kurir tetap untuk pengiriman spesimen sesuai jadwal, penyusunan jadwal pengiriman yang pasti. 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan Via WA untuk pengiriman hasil pemeriksaan secara elektronik agar hasil dapat diterima lebih cepat oleh dokter penanggung jawab.	1. Menetapkan kurir tetap yang bertanggung jawab mengirim spesimen ke laboratorium rujukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Melakukan koordinasi dengan laboratorium rujukan mengenai jadwal penerimaan spesimen dan mekanisme pelaporan hasil melalui SITB. 3. Memberikan sosialisasi kepada petugas poli, laboratorium, dan program TB mengenai alur baru pengiriman spesimen dan	1. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu pengiriman spesimen, waktu keluarnya hasil pemeriksaan, dan waktu penegakan diagnosis TB sebelum dan sesudah intervensi. 2. Evaluasi pula kepatuhan kurir terhadap jadwal pengiriman serta ketepatan penggunaan SITB dalam penyampaian hasil.	1. Apabila terjadi perbaikan, penggunaan kurir tetap dan pemanfaatan SITB ditetapkan sebagai prosedur baku (SPO). 2. Monitoring dilakukan setiap bulan capaian indikator penegakan diagnosis TB. 3. Jika target belum tercapai, dilakukan evaluasi lanjutan bersama laboratorium rujukan dan program TB untuk mengidentifikasi

			pemantauan hasil melalui SITB.	3. Hasil dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui efektivitas perbaikan.	hambatan lain serta menyusun tindakan perbaikan berikutnya.
--	--	--	--------------------------------	---	---

G. KESIMPULAN

Pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) pada Triwulan I tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal monitoring yang ditetapkan. Seluruh kegiatan pemantauan indikator mutu telah mencakup unit-unit pelayanan terkait dengan tingkat validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi keselamatan pasien, terjadi peningkatan pelaporan insiden sebanyak 36 laporan yang didominasi oleh Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Tidak Cedera (KTC). Peningkatan jumlah laporan ini tidak menunjukkan penurunan kualitas, melainkan mencerminkan keberhasilan penguatan budaya keselamatan pasien di mana staf semakin proaktif dalam melaporkan setiap temuan tanpa rasa takut. Namun efektivitasnya budaya keselamatan pasien tetap perlu dibuktikan dengan penurunan insiden berulang serta kejadian berisiko tinggi.

Terkait capaian Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien, dan Indikator Mutu Prioritas RS, seluruhnya berhasil mencapai target 100%. Namun, rumah sakit masih menghadapi tantangan pada indikator yang bersifat administratif dan prosedural. Hal ini terlihat pada rendahnya capaian dokumentasi TBAK (65%) dan Asesmen Awal Keperawatan yang dipengaruhi oleh masa transisi penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). Selain itu, kendala logistik mengakibatkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, persentase pelaksanaan kegiatan PMKP telah mencapai hampir 90% dari sisi pengumpulan data dan supervisi rutin. Namun, jika dilihat dari sisi efektivitas atau persentase keberhasilan (capaian indikator sesuai standar), angka keberhasilan berada di kisaran 75-80%. Untuk indikator yang belum tercapai telah dipetakan ke dalam rencana tindak lanjut melalui perbaikan sistem SIMRS, edukasi berkelanjutan mengenai RME, serta evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga.

Malang,
Ketua Komite Mutu Rumah Sakit



dr. Dzikrulloh Abdi
NIK 12 00 12